BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng

Năm 2026

Phạm vi sử dụng

Tài liệu gồm 79 kỹ thuật phục hồi chức năng phục vụ nhân viên được phân công tại Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân. Mỗi kỹ thuật áp dụng trong phạm vi chuyên môn, năng lực nhân viên, chỉ định người bệnh và điều kiện thiết bị đã được bệnh viện xác nhận.

Căn cứ xây dựng và hiệu lực

Đề cương và thể thức: Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023. Quyết định này hướng dẫn cấu trúc tài liệu, không thay thế hướng dẫn chuyên môn của từng kỹ thuật.

Nguồn chuyên ngành: Quyết định 3553/QĐ-BYT ngày 14/11/2025 ban hành Tập 1; Quyết định 3555/QĐ-BYT cùng ngày ban hành Tập 3. Tập 2 theo Quyết định 3554/QĐ-BYT cùng ngày được lùi hiệu lực đến 01/01/2028 tại khoản 16 Điều 1 Quyết định 1986/QĐ-BYT ngày 01/7/2026; không ghi Tập 2 là căn cứ có hiệu lực trong năm 2026.

Nguồn thao tác được kế thừa từ tài liệu khoa gửi. Trước ban hành, khoa chuyên môn xác nhận đối chiếu từng kỹ thuật với đúng tập, bổ sung hướng dẫn của thiết bị thực tế, tên và số lượng vật tư, thuốc sử dụng trực tiếp; không dùng danh mục tham khảo chung để xác nhận đã đối chiếu toàn bộ.

Yêu cầu triển khai

Bác sĩ chỉ định và lượng giá; người thực hiện có phạm vi hành nghề, đào tạo và phân công phù hợp. Liều năng lượng, lực kéo, mức chịu tải, thời gian và cường độ tập phải cá thể hóa. Không tự áp dụng thông số của một thiết bị cho thiết bị khác.

Tài liệu đối chiếu chung

1. Bộ Y tế. Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

2. Bộ Y tế. Quyết định 3553/QĐ-BYT, 3554/QĐ-BYT, 3555/QĐ-BYT ngày 14/11/2025; lần lượt Tập 1, Tập 2, Tập 3 về Phục hồi chức năng. Hiệu lực Tập 2 được sửa đổi tại QĐ1986/QĐ-BYT ngày 01/7/2026.

3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Công bố QĐ1986/QĐ-BYT ngày 02/7/2026. https://kcb.vn/tin-tuc/sua-doi-quy-dinh-ve-hieu-luc-thi-hanh-thoi-diem-ap-dung-tai-mot-so-quyet-dinh-cua-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh-tai-lieu-ch.html

4. OSHA. Guidelines for Laser Safety and Hazard Assessment. https://www.osha.gov/enforcement/directives/std-01-05-001. Tham khảo an toàn mắt và kính bảo vệ, không thay thế quy định Việt Nam.

5. FDA. Cảnh báo sóng ngắn đối với máy tạo nhịp, ICD cấy ghép. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf22/P220012C.pdf. Cần đối chiếu hướng dẫn của thiết bị cấy ghép cụ thể.

6. Bản QTKT PHCN Nhật Tân năm 2026 do khoa cung cấp. Giữ các nguồn lịch sử tại từng bài để truy nguyên; không đồng nghĩa văn bản cũ còn hiệu lực.

Danh mục 79 quy trình

01 ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG NGẮN

02 ĐIỀU TRỊ BẰNG TỪ TRƯỜNG

03 ĐIỀU TRỊ BẰNG CÁC DÒNG ĐIỆN XUNG

04 ĐIỀU TRỊ BẰNG SIÊU ÂM

05 ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG XUNG KÍCH

06 ĐIỀU TRỊ BẰNG DÒNG GIAO THOA

07 ĐIỀU TRỊ BẰNG TIA HỒNG NGOẠI

08 ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP

09 ĐIỀU TRỊ BẰNG NHIỆT NÓNG (CHƯỜM NÓNG)

10 ĐIỀU TRỊ BẰNG NHIỆT LẠNH (CHƯỜM LẠNH)

11 ĐIỀU TRỊ BẰNG PARAFIN

12 ĐIỀU TRỊ BẰNG MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG

13 TẬP NẰM ĐÚNG TƯ THẾ CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI (KỸ THUẬT ĐẶT TƯ THẾ ĐÚNG CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI)

14 KỸ THUẬT ĐẶT TƯ THẾ ĐÚNG CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT TỦY (TẬP NẰM ĐÚNG TƯ THẾ CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT TỦY)

15 KỸ THUẬT TẬP TAY VÀ BÀN TAY CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI

16 KỸ THUẬT TẬP ĐỨNG VÀ ĐI CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI

17 TẬP LĂN TRỞ KHI NẰM

18 TẬP THAY ĐỔI TƯ THẾ TỪ NẰM SANG NGỒI

19 TẬP NGỒI THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG

20 TẬP THAY ĐỔI TƯ THẾ TỪ NGỒI SANG ĐỨNG

21 TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG

22 TẬP DÁNG ĐI

23 TẬP ĐI VỚI THANH SONG SONG

24 TẬP ĐI VỚI KHUNG TẬP ĐI

25 TẬP ĐI VỚI NẠNG (NẠNG NÁCH, NẠNG KHUỶU)

26 TẬP ĐI VỚI GẬY

27 TẬP ĐI VỚI BÀN XƯƠNG CÁ

28 TẬP LÊN XUỐNG CẦU THANG

29 TẬP ĐI TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH KHÁC NHAU (DỐC SỎI, GỒ GHỀ..)

30 TẬP VẬN ĐỘNG THỤ ĐỘNG

31 TẬP VẬN ĐỘNG CÓ TRỢ GIÚP (TẬP VẬN ĐỘNG VỚI CÁC DỤNG CỤ TRỢ GIÚP)

32 TẬP VẬN ĐỘNG CHỦ ĐỘNG

33 TẬP VẬN ĐỘNG TỰ DO TỨ CHI

34 TẬP VẬN ĐỘNG CÓ KHÁNG TRỞ

35 TẬP KÉO DÃN (TẬP KÉO GIÃN)

36 TẬP VẬN ĐỘNG TRÊN BÓNG

37 TẬP VỚI THANG TƯỜNG

38 TẬP VỚI GIÀN TREO CÁC CHI

39 TẬP VỚI RÒNG RỌC

40 TẬP VỚI DỤNG CỤ QUAY KHỚP VAI

41 TẬP VỚI DỤNG CỤ CHÈO THUYỀN

42 TẬP THĂNG BẰNG VỚI BÀN BẬP BÊNH

43 TẬP VỚI MÁY TẬP THĂNG BẰNG

44 TẬP VỚI GHẾ TẬP MẠNH CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI

45 TẬP VỚI XE ĐẠP TẬP

46 TẬP VỚI BÀN NGHIÊNG

47 TẬP CÁC KIỂU THỞ

48 TẬP HO CÓ TRỢ GIÚP

49 KỸ THUẬT VỖ RUNG LỒNG NGỰC

50 KỸ THUẬT DẪN LƯU TƯ THẾ

51 KỸ THUẬT KÉO NẮN TRỊ LIỆU (KÉO NẮN, KÉO DÃN, CỘT SỐNG, CÁC KHỚP)

52 KỸ THUẬT DI DỘNG KHỚP

53 KỸ THUẬT TẬP CHUỖI ĐÓNG VÀ CHUỖI MỞ

54 KỸ THUẬT XOA BÓP VÙNG

55 XOA BÓP ÁP LỰC HƠI (KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ BẰNG MÁY ÉP KHÍ NGẮT QUÃNG)

56 KỸ THUẬT XOA BÓP TOÀN THÂN

57 KỸ THUẬT KIỂM SOÁT ĐẦU, CỔ VÀ THÂN MÌNH

58 TẬP ĐIỀU HỢP VẬN ĐỘNG

59 TẬP MẠNH CƠ ĐÁY CHẬU (CƠ SÀN CHẬU, PELVIC FLOOR)

60 KỸ THUẬT TẬP SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KHIỂN XE LĂN

61 TẬP CÁC VẬN ĐỘNG THÔ CỦA BÀN TAY

62 TẬP CÁC VẬN ĐỘNG KHÉO LÉO CỦA BÀN TAY

63 LƯỢNG GIÁ LAO ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP

64 THỬ CƠ BẰNG TAY

65 ĐO TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP

66 ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP VÀO ĐIỂM VẬN ĐỘNG VÀ HUYỆT ĐẠO

67 TẬP VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG

68 KỸ THUẬT XOA BÓP BẰNG MÁY

69 KỸ THUẬT XOA BÓP DẪN LƯU

70 KỸ THUẬT KIỂM SOÁT TƯ THẾ (NGỒI, BÒ, ĐỨNG, ĐI)

71 KỸ THUẬT TẠO THUẬN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ
(LẪY, NGỒI, BÒ, ĐỨNG, ĐI)

72 KỸ THUẬT KÉO GIÃN CHO TRẺ EM BỊ VẸO CỔ DO XƠ CƠ ỨC ĐÒN CHŨM (KỸ THUẬT KÉO GIÃN CHO TRẺ EM BỊ VẸO CỔ BẨM SINH)

73 KỸ THUẬT TẬP VẬN ĐỘNG CHO TRẺ XƠ HÓA CƠ

74 KỸ THUẬT TẬP VẬN ĐỘNG CHO TRẺ BỊ BIẾN DẠNG CỘT SỐNG (CONG, VẸO, GÙ, ƯỠN)

75 KỸ THUẬT KIỂM SOÁT TƯ THẾ VÀ VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI BỆNH PARKINSON

76 KỸ THUẬT GƯƠNG TRỊ LIỆU

77 KỸ THUẬT THÔNG MŨI HỌNG NGƯỢC DÒNG Ở TRẺ EM

78 ĐIỀU TRỊ BẰNG ÂM DẪN THUỐC

79 ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT CAO

01 ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG NGẮN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Sóng ngắn điều trị sử dụng điện trường hoặc điện từ trường cao tần theo thiết bị. Tần số, công suất, chế độ phát và thời gian phải theo chỉ định và hướng dẫn sử dụng của đúng máy; không suy ra thông số điều trị từ tần số ghi trong phần đại cương.

- Cơ chế tác dụng chính: tương tác điện trường cao tần đối với tổ chức sống và tăng nhiệt các mô bằng cơ chế nội nhiệt.

- Chỉ sử dụng điều trị cục bộ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chống viêm.

- Giảm sưng nề và máu tụ sau chấn thương, phẫu thuật.

- Tăng dinh dưỡng tổ chức tại chỗ.

- Giảm đau cục bộ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trực tiếp trên u lành hoặc ác tính.

- Trực tiếp lên vùng đang chảy máu hoặc đe dọa chảy máu.

- Thai nhi.

- Cơ thể suy kiệt nặng, suy tim nặng, đang sốt cao.

- Người quá mẫn cảm với điện trường cao tần.

- Người có máy tạo nhịp, máy khử rung hoặc thiết bị kích thích điện cấy ghép: không thực hiện sóng ngắn khi nhà sản xuất thiết bị cấy ghép chống chỉ định; kiểm tra thông tin cấy ghép trước chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

- Vùng tổn thương lao chưa ổn định.

- Vùng có kim loại cấy ghép: đánh giá tương thích với thiết bị và vị trí điều trị trước chỉ định.

- Điều trị trực tiếp qua não, tủy sống, tim.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện:

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Găng tay
- Mũ giấy
- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn
- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế:

- Máy sóng ngắn cùng các phụ kiện

5.5. Người bệnh:

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...
- Tư thế người bệnh phải thoải mái, tốt nhất là ở tư thế nằm hoặc ngồi.
- Tháo bỏ các dụng cụ kim loại như đồng hồ, đồ trang sức...
- Kiểm tra vùng điều trị nếu có mồ hôi hay nước phải lau khô.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.
- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Chọn và đặt điện cực đúng vị trí theo chỉ định.
- Bật máy. Đặt các thông số kỹ thuật: công suất, thời gian, chế độ biểu hiện trên máy.
- Kiểm tra dây nối đất nếu có.
- Kiểm tra trường điện từ phát ra ở điện cực băng đèn thử điều trị.
- Tắt máy khi hết thời gian, thăm hỏi người bệnh, ghi phiếu

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn

phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng của người bệnh.
- Hoạt động máy xê dịch điện cực cần điều chỉnh đúng và kiểm tra.
- Điện giật: tắt máy, xử trí điện giật.
- Bỏng tại chỗ: xử trí như xử trí bỏng nhiệt.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu và cộng sự, 2019, “Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng”, NXB Y học.

02 ĐIỀU TRỊ BẰNG TỪ TRƯỜNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Là điều trị bằng từ trường nhân tạo. Trong vật lý trị liệu thường dùng từ trường biến thiên của máy tạo từ trường chuyên dụng.

- Cơ chế tác dụng chính: Tương tác từ trường ngoài lên mô cơ thể bằng các hiệu ứng sinh học và ảnh hưởng đối với từ trường nội sinh của cơ thể.

- Có thể điều trị cục bộ hoặc toàn thân.

2. CHỈ ĐỊNH

- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên.

- Các bệnh lý viêm.

- Sau phẫu thuật kết hợp xương.

- Chậm liền xương.

- Các trường hợp đau cấp tính và mạn tính.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh máu, tình trạng đang chảy máu hoặc đe dọa chảy máu.

- Trực tiếp lên khối u ác tính và lành tính.

4. THẬN TRỌNG:

- Người mang máy tạo nhịp tim.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Dây nối đất

- Găng tay

- Mũ giấy

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế :

- Máy tạo từ trường và phụ kiện

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh phải thoải mái, tốt nhất là ở tư thế nằm hoặc ngồi.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-30 phút (ước tính 0,25-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bật máy. Đặt các thông số theo chỉ định.

- Chọn và đặt đầu phát theo chỉ định.

- Kiểm tra từ trường tại bề mặt đầu phát với thiết bị riêng kèm theo máy.

- Hết thời gian điều trị: tắt máy, ghi chép vào phiếu điều trị.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng của người bệnh.

- Hoạt động máy, tiếp xúc của đầu phát, điều chỉnh, kiểm tra.

- Điện giật: tắt máy xử trí cấp cứu điện giật.

- Choáng váng, mệt mỏi (thường gặp) do người bệnh quá mẫn cảm với từ trường: ngừng điều trị.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế, 2014, “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”, ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. NXB Y học.

2. Học viện Quân Y, 2003, “Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân

03 ĐIỀU TRỊ BẰNG CÁC DÒNG ĐIỆN XUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Dòng điện xung là dòng điện do nhiều xung điện liên tiếp tạo nên. Trong vật lý trị liệu thường sử dụng các dòng điện xung có dạng xung và tần số khác nhau một chiều (nửa sóng) và xoay chiều (cả sóng).

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau sau chấn thương, phẫu thuật, đau thần kinh, đau cơ, xương, khớp…
- Kích thích thần kinh cơ.
- Cải thiện tuần hoàn ngoại vi
- Liệu pháp ion hóa (điện phân dẫn thuốc bằng xung một chiều)
- Điện phân thuốc cục bộ bằng dòng điện xung trung tần một chiều.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị mẫn cảm với dòng điện một chiều.
- Suy tim độ III
- Trực tiếp lên vùng đang chảy máu hoặc nguy cơ chảy máu.
- Người bệnh tinh thần kích động, mất cảm giác tại vùng điều trị, động kinh, trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

4. THẬN TRỌNG

- Khi thực hiện trên các vùng da bị tổn thương
- Người mang máy tạo nhịp tim.
- Người bệnh bị ung thư.
- Phụ nữ có thai.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện:

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Găng tay
- Mũ giấy
- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau vị trí điều trị

- Điện cực, tấm đệm điện cực

- Dây nối đất.

- Dụng cụ phương tiện cấp cứu choáng.

5.4. Thiết bị y tế: Máy điện xung

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh thoải mái.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bật máy

- Đặt và cố định điện cực: theo chỉ định.

+ Đặt các thông số kỹ thuật theo chỉ định.

- Tăng cường độ từ từ theo mục tiêu, chế độ và dung nạp. Kích thích cơ và giảm đau có yêu cầu đáp ứng khác nhau; không mặc định mọi chế độ phải gây co cơ.

- Hết giờ tắt máy bằng tay hoặc tự động.

- Tháo điện cực kiểm tra da vùng điều trị. Thăm hỏi người bệnh ghi hồ sơ bệnh án.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng người bệnh

- Hoạt động của máy.

- Điện giật: xử trí cấp cứu điện giật.

- Bỏng hoặc tổn thương da: ngừng phát điện, ngắt nguồn an toàn, đánh giá và báo bác sĩ; xử trí theo loại và mức độ tổn thương. Không tự dùng acid hoặc kiềm để trung hòa trên da.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Học viện Quân Y, 2003, “Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

04 ĐIỀU TRỊ BẰNG SIÊU ÂM

1. ĐẠI CƯƠNG

Siêu âm là sóng âm thanh có tần số trên 20.000 Hz. Trong điều trị thường dùng siêu âm tần số 1 và 3 MHz với tác dụng chính sóng cơ học, tăng nhiệt và sinh học. Các kỹ thuật chính: trực tiếp, qua nước, siêu âm dẫn thuốc

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau cục bộ

- Giãn cơ theo chỉ định.

- Viêm bán cấp và mạn tính.

- Xơ cứng, sẹo nông ở da.

- Dẫn một số thuốc vào tổ chức cục bộ (siêu âm dẫn thuốc).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trực tiếp lên các u ác tính, tinh hoàn, buồng trứng, tử cung đang có thai, đang hành kinh.

- Trực tiếp vùng khớp ở trẻ em, các đầu xương của trẻ em, nhất là phần sụn tiếp hợp.

- Viêm tắc mạch, viêm da cấp tại vị trí điều trị.

- Vùng phổi người bị lao đang tiến triển, giãn phế quản thể khô hoặc viêm hạch do lao.

- Trực tiếp vùng chảy máu, đe dọa chảy máu.

4. THẬN TRỌNG

- Không thực hiện trên các vùng da bị tổn thương

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện:

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: Thuốc giảm đau, chống viêm dạng mỡ, gel hoặc dung dịch…

5.3. Vật tư:

- Găng tay

- Mũ giấy

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau vị trí điều trị

- Chậu nước (siêu âm qua nước) nếu cần

5.4. Thiết bị y tế

- Máy siêu âm cùng các phụ kiện đi kèm. Kiểm tra tần phát siêu âm theo quy định.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh thoải mái.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bật máy, đặt các thông số kỹ thuật và cách điều trị theo chỉ định.

- Bôi gel, thuốc theo chỉ định lên vùng điều trị

- Đặt đầu phát đúng vùng, bảo đảm tiếp âm; di chuyển đều theo kỹ thuật được chỉ định, không để đầu phát đứng yên một điểm khi đang phát năng lượng.

- Hết giờ tắt máy (bằng tay hoặc tự động).

- Kiểm tra vùng điều trị, thăm hỏi người bệnh, ghi chép hồ sơ.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng người bệnh.

- Hoạt động của máy.

- Điện giật: Tắt máy và xử trí theo quy định.

- Dị ứng tại chỗ, đau hoặc nóng rát: dừng điều trị, kiểm tra da, chất tiếp âm và thông số; báo bác sĩ xử trí.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Học viện Quân Y, 2003, “Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

05 ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG XUNG KÍCH

1. ĐẠI CƯƠNG

- Điều trị băng sóng xung kích là kỹ thuật ứng dụng sóng cơ học tạo ra bởi luồng khí nén xung lực cao (từ 1 đến 5 bar) tác động vào các điểm đau khu trú nhằm mục đích giảm đau, giãn cơ và kích thích quá trình lành tổn thương cục bộ.

- Áp suất khí nén chỉ là thông số của một số máy. Không dùng mức bar làm liều chung cho mọi thiết bị; ghi thông số và số xung theo chỉ định của đúng máy.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau cân, gân chi thể.

- Đau cơ khớp không do chấn thương cấp, viêm cấp.

- Co cứng cơ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trực tiếp lên vùng đang chảy máu hoặc nguy cơ chảy máu.

- Chấn thương cấp.

- Trực tiếp lên đầu xương trẻ em, gãy xương chưa được xử lý, thai nhi.

4. THẬN TRỌNG

- Khi thực hiện trên các vùng da bị tổn thương

- Khối u ác tính.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện:

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: Gel điều trị

5.3. Vật tư:

- Găng tay

- Mũ giấy

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau vị trí điều trị

5.4. Thiết bị y tế

- Máy điều trị sóng xung kích cùng các phụ kiện

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh thoải mái (nằm hoặc ngồi).

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị. Xác định điểm đau (bằng tay).

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 1-10 phút (ước tính 0,02-0,17 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bật máy

- Cài đặt các thông số kỹ thuật

- Bôi gel lên bề mặt da vùng điều trị.

- Đặt đầu phát sóng lên vị trí điều trị và tiến hành điều trị theo chỉ định

- Hết thời gian điều trị: tắt máy

- Lau đầu phát sóng và vùng da điều trị.

- Kiểm tra vùng điều trị, thăm hỏi người bệnh, ghi chép hồ sơ.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng của người bệnh.

- Đau tăng hoặc sưng nề: ngừng điều trị, kiểm tra và báo bác sĩ đánh giá.

- Chảy máu dưới da: ngừng điều trị, theo dõi và xử trí theo phác đồ.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh

ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

06 ĐIỀU TRỊ BẰNG DÒNG GIAO THOA

1. ĐẠI CƯƠNG

- Dòng giao thoa được tạo bởi sự giao thoa của các dòng điện xoay chiều trung tần. Chọn tần số mang, tần số điều biến, cường độ và cách đặt điện cực theo mục tiêu điều trị, chỉ định và hướng dẫn máy.

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau sau chấn thương, phẫu thuật, đau thần kinh, đau cơ, xương, khớp...
- Kích thích thần kinh cơ.
- Cải thiện tuần hoàn ngoại vi
- Liệu pháp ion hóa (điện phân dẫn thuốc bằng xung một chiều)
- Điện phân thuốc cục bộ bằng dòng điện xung trung tần một chiều.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị mẫn cảm với dòng điện một chiều.
- Suy tim độ III
- Trực tiếp lên vùng đang chảy máu hoặc nguy cơ chảy máu.
- Người bệnh tinh thần kích động, mất cảm giác tại vùng điều trị, động kinh, trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

4. THẬN TRỌNG

- Khi thực hiện trên các vùng da bị tổn thương
- Người mang máy tạo nhịp tim.
- Người bệnh bị ung thư.
- Phụ nữ có thai.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện:

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Găng tay
- Mũ giấy
- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

5.4. Thiết bị y tế

- Máy điện xung có dòng giao thoa và các phụ kiện

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh thoải mái, tốt nhất là ở tư thế nằm hoặc ngồi.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

-Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bật máy

- Cài đặt các thông số kỹ thuật

- Đặt điện cực lên vùng điều trị theo chỉ định

- Điều chỉnh cường độ tăng dần theo mục tiêu và dung nạp; không gây đau, bỏng rát. Đáp ứng co cơ chỉ áp dụng khi đó là mục tiêu được chỉ định.

- Hết thời gian điều trị: điều chỉnh cường độ dòng điện giảm dần về “0”, tắt máy, tháo điện cực

- Kiểm tra vùng da đặt điện cực

- Thăm hỏi người bệnh, ghi chép hồ sơ.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng người bệnh.
- Hoạt động của máy
- Điện giật: và xử trí theo phác đồ
- Dị ứng vùng da đặt điện cực: Xử trí theo phác đồ.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

07 ĐIỀU TRỊ BẰNG TIA HỒNG NGOẠI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Hồng ngoại nguồn nhân tạo do các loại đèn hồng ngoại phát ra có công suất khác nhau. Tác dụng chủ yếu là nhiệt nóng, giúp gia tăng lưu lượng tuần hoàn, giảm đau, giãn cơ…

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau, giãn cơ, tăng cường lưu thông máu ngoại vi trong các trường hợp co cứng cơ do lạnh, sai tư thế hoặc sau phẫu thuật…

- Chống viêm mạn tính.

- Dự phòng loét, các vết loét, vết thương chậm liền

- Mềm xơ sẹo, kết dính

- Sưởi ấm

- Vách hóa hoặc dày dính màng phổi

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Vùng da vô mạch, mất cảm giác.

- Các bệnh ngoài da cấp tính.

- Các vết thương đang chảy máu

- Sốt cao

- Không điều trị trực tiếp lên khối u.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá cảm giác nóng lạnh, tuần hoàn và khả năng báo nóng rát. Theo dõi sát người cao tuổi, người khó giao tiếp; tránh để đèn chiếu vào mắt.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện:

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Thước dây

- Mũ giấy

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

5.4. Thiết bị y tế: Đèn hồng ngoại theo chỉ định công suất.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Thử cảm giác nóng lạnh trên người bệnh

- Tư thế người bệnh phải thoải mái, thuận lợi.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bố trí đèn ổn định, hướng chiếu và khoảng cách theo hướng dẫn của đúng thiết bị và chỉ định. Kiểm tra cảm giác, nhiệt độ da, tránh tiếp xúc trực tiếp với bóng đèn.

- Bật đèn chiếu theo thời gian chỉ định

- Hết giờ tắt đèn

- Kiểm tra da vùng điều trị, thăm hỏi người bệnh, ghi chép hồ sơ.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng người bệnh.

- Bỏng da xử trí theo phác đồ.

- Choáng váng: nằm nghỉ ngơi theo dõi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh

ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu và cộng sự, 2019, “Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng”, NXB Y học.

3. Học viện Quân Y, 2003, “Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân

08 ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thường sử dụng laser bán dẫn, He- Ne, nitơ công suất thấp.
- Tác dụng do hiệu ứng sinh học.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chống viêm, chống phù nề nông.
- Kích thích tái tạo mô, làm liền vết thương, vết loét.
- Giảm đau cục bộ.
- Châm cứu bằng laser.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Sốt cao
- Chiếu trực tiếp vào mắt.
- Trực tiếp lên vùng đang chảy máu hoặc đe dọa chảy máu.

4. THẬN TRỌNG

- U ác tính

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Găng tay
- Mũ giấy
- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn
- Kính bảo vệ mắt cho người bệnh và người trong vùng kiểm soát, phù hợp bước sóng và mật độ quang học ghi trên kính.

5.4. Thiết bị y tế

- Máy laser và các phụ kiện

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh thoải mái, tốt nhất là ở tư thế nằm hoặc ngồi.

- Bộc lộ và kiểm tra vùng chiếu laser. Với các vết thương vết loét nên được thay băng làm sạch dịch mủ và các mô hoại tử bề mặt.

- Đeo kính bảo vệ cho người bệnh

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 6-18 phút (ước tính 0,10-0,30 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bật máy, chọn các tham số kỹ thuật theo chỉ định

- Chiếu tại vùng da theo chỉ định và hướng dẫn máy. Không hướng tia trực tiếp hoặc phản xạ vào mắt; không chiếu vào giác mạc, kể cả theo tiếp tuyến.

- Hết giờ điều trị: tắt đèn

- Kiểm tra vùng da chiếu

- Thăm hỏi người bệnh, ghi chép phiếu.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Hoạt động của máy, các thông số, chùm tia.

- Phản ứng và cảm giác của người bệnh

- Thực hiện an toàn theo phân loại laser của đúng máy. Không nhìn trực tiếp vào chùm tia; kiểm soát vùng chiếu, phản xạ và kính bảo vệ phù hợp.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

09 ĐIỀU TRỊ BẰNG NHIỆT NÓNG (CHƯỜM NÓNG)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Dùng phương tiện có khả năng giữ nhiệt đắp lên vùng cơ thể gây tác dụng tăng nhiệt mô do truyền nhiệt trực tiếp.

- Phương tiện giữ nhiệt cơ thể: túi chườm, parafin, thảo dược…

- Tác dụng cục bộ

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau, giãn cơ, giãn mạch ngoại vi, tăng tuần hoàn cục bộ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không điều trị trực tiếp lên khối u.

- Không điều trị lên chỗ da viêm, chấn thương cấp.

- Đang chảy máu, sốt cao, suy kiệt.

4. THẬN TRỌNG

- Khi điều trị cho trẻ em

- Khi điều trị vùng mặt, che phủ mắt

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Mũ giấy

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lót

- Khăn lau vị trí điều trị

- Vải quấn

- Nhiệt kế 100 độ C

- Túi nước nóng hoặc túi thuốc lá nóng hoặc parafin hoặc bùn nóng hoặc bao cát.

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành...

- Tư thế người bệnh thoải mái, thuận lợi.

- Kiểm tra và bộc lộ bộ phận cơ thể được điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bộc lộ vùng điều trị

- Đặt túi chườm nóng lên bộ phận cơ thể được điều trị và cố định băng băng hoặc bao cát.

- Khi túi chườm nguội sau 15-20 phút thì tháo bỏ ra. Dùng khăn bông lau sạch da vùng điều trị, kiểm tra da, thăm hỏi người bệnh, ghi phiếu điều trị.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Bỏng nhiệt do nóng quá: kiểm tra da và xử trí theo phác đồ.

- Dị ứng mẩn ngứa tại chỗ: ngừng điều trị và theo dõi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu và cộng sự, 2019, “Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng”, NXB Y học.

10 ĐIỀU TRỊ BẰNG NHIỆT LẠNH (CHƯỜM LẠNH)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Điều trị băng nhiệt lạnh là chườm lạnh từ 0 độ C đến 18 độ C.
- Thường dùng túi nước lạnh, nước đá
- Điều trị cục bộ

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau, giảm phù nề và xuất huyết dưới da trong chấn thương cấp.
- Hạ nhiệt
- Hạn chế quá trình viêm cấp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tổ chức xơ sẹo, viêm tắc mạch chi.
- Trực tiếp lên thai nhi

4. THẬN TRỌNG

- Co cơ cục bộ
- Khi điều trị cho trẻ em
- Khi điều trị vùng mặt, che phủ mắt

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện:

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Găng tay
- Mũ giấy
- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn
- Khăn lau vị trí điều trị
- Túi bọc đá vụn
- Túi nước lạnh, nước đá tan

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh thoải mái, thuận lợi.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 6-12 phút (ước tính 0,10-0,20 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bộc lộ vùng điều trị

- Chườm lạnh lên vùng cần điều trị, cố định hoặc di động, thời gian theo chỉ định

- Kết thúc lau khô, kiểm tra vùng da, thăm hỏi người bệnh, ghi phiếu điều trị

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Người bệnh: cảm giác và phản ứng của người bệnh

- Bỏng lạnh tại chỗ: ngừng điều trị, xử trí theo bỏng lạnh

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó

thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu và cộng sự, 2019, “Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng”, NXB Y học.

11 ĐIỀU TRỊ BẰNG PARAFIN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Parafin là phương tiện nhiệt nông dùng ngoài da. Nhiệt độ nấu chảy không phải nhiệt độ được phép áp trực tiếp lên da; kiểm tra nhiệt độ tiếp xúc theo thiết bị và loại parafin trước mỗi lần sử dụng.

- Có nhiều kỹ thuật điều trị parafin, chỉ đề cập điều trị parafin đắp ngoài

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau giãn cơ

- Viêm mạn tính

- Giãn mạch ngoại vi, tăng tuần hoàn cục bộ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương cấp, nhiễm trùng cấp

- Trực tiếp lên vùng đang chảy máu hoặc đe dọa chảy máu

- Sốt cao, quá suy kiệt

- Dị ứng với parafin, bệnh ngoài da tại vùng điều trị

4. THẬN TRỌNG

- Mất cảm giác

- Khi điều trị cho trẻ em

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: Parafin

5.3. Vật tư

- Găng tay

- Mũ giấy

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn bọc giữ nhiệt

- Khăn lau vị trí điều trị

- Nồi nấu parafin

- Nilon bọc Paraffin,

- Bao cát

- Nhiệt kế

- Chổi quét

- Khay đựng

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh thoải mái, thuận lợi.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Làm nóng parafin bằng thiết bị chuyên dụng, đo nhiệt độ và chuẩn bị miếng đắp theo hướng dẫn. Kiểm tra da, cảm giác và tuần hoàn vùng điều trị.

- Đặt miếng đắp khi đạt nhiệt độ tiếp xúc an toàn, bọc và phủ giữ nhiệt phù hợp; không dùng bao cát gây chèn ép vùng được làm nóng.

- Quy trình này áp dụng parafin đắp ngoài. Quét hoặc nhúng chỉ thực hiện khi có hướng dẫn riêng đã được phê duyệt và kiểm soát lây nhiễm phù hợp.

+ Thời gian theo chỉ định

+ Kết thúc điều trị: gỡ parafin kiểm tra lau khô, dặn dò người bệnh, ghi phiếu điều trị

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn

phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng người bệnh

- Sau điều trị dị ứng mẩn ngứa

- Bỏng nhẹ (vùng da mỏng, trong parafin có nước): xử trí theo phác đồ

- Dị ứng với parafin: ngừng điều trị, xử trí theo phác đồ, kiểm tra paraffin (có lẫn hóa chất không) cần làm sạch tuân theo quy định

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu và cộng sự, 2019, “Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng”, NXB Y học.

12 ĐIỀU TRỊ BẰNG MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Kéo giãn cột sống bằng máy dựa trên nguyên lý cơ học có điều chỉnh kéo, chế độ, thời gian theo yêu cầu lên cột sống.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoái hóa cột sống
- Thoát vị đĩa đệm giai đoạn đầu, thoát vị đĩa đệm vừa và nhẹ
- Hội chứng đau lưng và thắt lưng do nguyên nhân ngoại vi (cơ, dây chằng).
- Vẹo cột sống do tư thế

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tổn thương thực thể cột sống: ung thư, lao, viêm tấy áp xe vùng lưng
- Chấn thương cột sống có gãy xương biến dạng
- Bệnh lý tủy sống và ống sống
- Thoái hóa cột sống có các cầu xương nối các đốt sống
- Viêm cột sống dính khớp nặng
- Loãng xương nặng
- Người bệnh suy kiệt
- Trẻ em < 6 tuổi
- Phụ nữ có thai, đang có kinh nguyệt

4. THẬN TRỌNG

- Trong cơn tăng huyết áp

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện:

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

5.4. Thiết bị y tế

- Máy kéo giãn cột sống

- Hệ thống bàn kéo và các phụ kiện khác.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Cố định trên bàn hoặc ghế kéo đúng tư thế

- Hướng dẫn người bệnh sử dụng công tắc an toàn

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bật máy

- Cố định đai kéo tùy theo vùng điều trị theo đúng chỉ định

- Đặt các thông số trên máy tùy theo chỉ định (lực kéo, chế độ, thời gian), kéo theo chương trình hay điều chỉnh bằng tay

- Bấm nút kéo

- Kết thúc điều trị: tháo bỏ đai cố định, thăm hỏi người bệnh để người bệnh nằm nghỉ tại chỗ 5-10 phút, ghi chép hồ sơ

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng của người bệnh

- Tình trạng hoạt động của máy

- Đau nhói vùng kéo giãn: ngừng kéo, kiểm tra theo dõi, xử trí theo phác đồ

- Đau tăng dần và kéo dài: kiểm tra vùng đau, ngừng kéo giãn hoặc giảm lực kéo

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

13 TẬP NẰM ĐÚNG TƯ THẾ CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI (KỸ THUẬT ĐẶT TƯ THẾ ĐÚNG CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Liệt nửa người là liệt một tay và một chân và nửa mặt cùng bên, có nhiều nguyên nhân nhưng thường gặp là do đột quỵ não, chấn thương sọ não...

- Kỹ thuật tập năm đúng tư thế là kỹ thuật vị thế, người bệnh được đặt hoặc hướng dẫn năm ở các tư thế đúng theo mẫu phục hồi

- Sự cần thiết phải năm đúng tư thế

+ Để đề phòng và khắc phục co cứng bên liệt

+ Kích thích người bệnh sử dụng bên liệt trong các động tác sinh hoạt hàng ngày

+ Hạn chế các biến chứng do bất động

2. CHỈ ĐỊNH

- Các giai đoạn của liệt nửa người do đột quỵ não; chấn thương sọ não; viêm não, màng não

- Phòng ngừa biến chứng và các thương tật thứ cấp như loét, nhiễm trùng hô hấp...

- Phòng ngừa co cứng trong giai đoạn đầu và ức chế co cứng khi co cứng đã xuất hiện của người bệnh liệt nửa người.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh hôn mê

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Gối vuông mềm: 06 chiếc

- Gối tròn: 04 chiếc

- Chăn hoặc vỏ chăn: 02 chiếc

- Túi cát loại 02 kg: 03 túi

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, tác dụng và các bước tiến hành, những chú ý cần ghi nhớ khi thực hiện ...

- Kiểm tra tình trạng người bệnh trước khi tập

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Người bệnh nằm nghiêng về phía bên liệt

- Đầu người bệnh được đỡ ngay ngắn và chắc chắn trên gối, không làm gấp các đốt sống cổ.

- Vai bên liệt được đưa ra trước vuông góc với thân; tay bên liệt duỗi, xoay ngửa, các ngón tay duỗi, dạng.

- Chân bên liệt ở tư thế khớp háng duỗi, khớp gối hơi gấp.

- Thân mình ở tư thế nửa ngửa

- Tay bên lành ôm gối.

- Chân bên lành được đỡ trên gối cao ngang mức với thân và hông, khớp háng và khớp gối gấp

6.2. Người bệnh nằm ngửa trên giường bệnh hoặc trên giường tập

- Đầu người bệnh được đỡ chắc chắn trên gối có chiều cao phù hợp để không làm gấp các đốt sống cổ, mặt nhìn thẳng hoặc quay về phía bên liệt.

- Dùng gối mỏng đỡ dưới xương bả vai để đưa khớp vai bên liệt ra trước; tay liệt xoay ngửa, duỗi dọc theo thân mình hoặc dạng ngang vai, hoặc duỗi lên phía trên đầu.

- Dùng gối mỏng đỡ dưới hông bên liệt để đưa hông bên liệt ra trước, gối đỡ dưới khoeo để gấp khớp háng và khớp gối bên liệt, gối hoặc túi cát đỡ phía mắt cá ngoài để chân bên liệt không bị đổ ra ngoài.

- Tay và chân bên lành ở vị trí mà người bệnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

6.3. Người bệnh nằm nghiêng về phía bên lành

- Đầu người bệnh được đỡ ngay ngắn và chắc chắn trên gối, không làm gấp các đốt sống cổ.

- Tay bên liệt được đỡ bằng gối ở phía trước, cao ngang bằng mức với thân mình với khớp vai và khớp khuỷu duỗi.

- Thân mình vuông góc với mặt giường, có gối đỡ phía lưng.

- Chân bên liệt được đỡ trên gối ở phía trước cao ngang mức với thân mình, khớp háng và khớp gối gấp.

- Chân và tay bên lành ở vị trí mà người bệnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu

6.4. Cứ 3 đến 4 giờ phải lăn trở và thay đổi tư thế nằm cho người bệnh

6.5. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi tập

- Theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường và xử trí kịp thời theo đúng phác đồ, báo cáo bác sỹ

- Ghi chép hồ sơ bệnh án: Tình trạng người bệnh trong và sau khi tập

- Hướng dẫn người bệnh đề phòng những tai biến có thể xảy ra như: Đau, khó chịu, mệt mỏi... nếu thấy có gì bất thường báo cáo bác sĩ ngay

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó

thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

14 KỸ THUẬT ĐẶT TƯ THẾ ĐÚNG CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT TỦY (TẬP NẰM ĐÚNG TƯ THẾ CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT TỦY)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Đặt tư thế đúng cho người bệnh tổn thương tủy sống nhằm giữ cân bằng những lực cơ trái nghịch nhau có hại cho người bệnh (rối loạn thăng bằng, tăng trương lực cơ), gây cản trở người bệnh tiếp cận một cách đúng đắn với môi trường, do đó làm hạn chế những khả năng còn lại của họ

- Đặt tư thế đúng cho người bệnh tổn thương tủy sống sẽ giúp phòng ngừa, hạn chế hoặc sửa đổi các biến chứng như loét và cứng khớp.

- Cách đặt tư thế đúng liên quan đến tư thế nằm và ngồi, và cũng liên quan đến tất cả những bộ phận khác của cơ thể dễ bị biến chứng.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh tổn thương tủy sống gây liệt tứ chi hoặc hai chân.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Bảo vệ cột sống và da vùng tỳ đè; duy trì trục đầu cổ thân, kiểm tra huyết áp khi đổi tư thế ở người tổn thương tủy.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

- Điều dưỡng

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Gối vuông mềm: 06 chiếc

- Gối tròn: 04 chiếc

- Chăn hoặc vỏ chăn: 02 chiếc

- Túi cát loại 02 kg: 03 túi

- Ghế hoặc xe lăn: 01 chiếc

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường bệnh hoặc giường tập: phải phù hợp với mức tổn thương, phải thoải mái và phải giúp tạo thuận cho người bệnh tiếp cận với môi trường sống.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện : mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Kiểm tra huyết áp trước khi tập

- Giải thích và hướng dẫn cách tập cho người bệnh

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1 Đặt tư thế đúng trên giường

- Hai chi dọc theo thân, đảm bảo cho cả cánh tay được nâng đỡ để tránh phù nề và tránh đau

+ Vai và bả vai được nâng đỡ để tránh một tư thế gắng sức gây đau

+ Khuỷu để duỗi để tránh biến dạng gập

+ Hai bàn tay được đặt sao cho thuận tiện cho tác dụng khóa gân (tenodesis) (động tác gập duỗi cổ tay): Gấp cuộn tròn các ngón tay, cổ tay ở tư thế duỗi nhẹ 30 độ, các xương bàn - đốt ngón tay và những khớp gian đốt ngón tay ở tư thế gập 90 độ, các khớp gian đốt ngón xa ở tư thế trung tính 0 độ.

+ Hoặc tư thế của bàn tay ở tư thế nghỉ ngơi (cổ tay duỗi 30 độ, xương bàn tay-đốt ngón tay gập 45 độ, các khớp gian đốt gấp nhẹ.

- Chi dưới:

+ Hông và gối được đặt thẳng, hông dạng 30 độ: sử dụng gối chêm.

+ Tư thế nằm nghiêng: Sử dụng gối chêm giữa hai gối, sát dưới lưng để giảm tải cho phần xương cùng và giữ hai bàn chân gập mặt mu (xoay trở đều đặn về ban đêm).

+ Giảm tải dưới gót chân bằng cách duy trì gập mu cổ chân 90 độ.

6.2. Đặt tư thế ngồi đúng (trên ghế hoặc trên xe lăn)

- Tư thế lý tưởng là ngồi trên một mặt phẳng nằm ngang với hông gấp 90 độ, gối gấp 90 độ, gập mu chân 90 độ, bàn chân đặt sát vào chỗ tựa.

- Khung chậu: Kiểm tra qua ba mặt phẳng không gian:

+ Hai gai chậu trước trên ngang bằng nhau (mặt phẳng nằm ngang)

+ Gai chậu trước trên thẳng đứng so với mấu chuyển lớn (mặt phẳng đứng)

+ Hai gối ngang bằng nhau (mặt phẳng trán)

- Hai chân: Hai chân phải được nâng đỡ tốt bằng hai tấm để chân, sao cho phần dưới đùi phải tiếp xúc với nơi tựa của chỗ ngồi. Có thể thêm một miếng mút hoặc gối chêm để bảo vệ hai gót chân.

- Cột sống: Cột sống phải được giữ thẳng và vững . Chiều cao chỗ tựa lưng của xe lăn có thể được điều chỉnh tùy theo mức độ thăng bằng và mức tổn thương tủy cao hay thấp.

- Hai chi trên: Hai vai được giữ vững và đối xứng nhờ vào sự điều chỉnh hai chỗ gác tay. Đối với người liệt tứ chi: hai bàn tay phải luôn ở tư thế bàn tay chức năng.

- Cổ và đầu: Tránh tất cả những tư thế gập, duỗi, nghiêng hoặc mọi trạng thái căng cứng. Có thể thêm một chỗ tựa đầu để giúp nâng đỡ và tạo thoải mái cho người bệnh liệt tứ chi cao.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi tập

- Theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường

- Nếu có bất thường xử trí kịp thời theo đúng phác đồ, báo cáo bác sỹ

- Ghi chép hồ sơ bệnh án: Tình trạng người bệnh trong và sau khi tập

- Đau, khó chịu, mệt mỏi : cho người bệnh nghỉ ngơi, theo dõi, dùng thuốc giảm đau nếu đau nhiều.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh

ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu và cộng sự, 2019, “Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng”, NXB Y học.

3. Cẩm Bá Thức, Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu, 2022, “Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống”, NXB Y học.

15 KỸ THUẬT TẬP TAY VÀ BÀN TAY CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Liệt nửa người có thể gặp sau đột quỵ và các tổn thương thần kinh khác. Chương trình tập dựa trên chẩn đoán, giai đoạn và lượng giá chức năng. Dấu hiệu thần kinh mới xuất hiện cần được đánh giá cấp cứu, không chờ đủ 24 giờ.

- Tầm quan trọng của tập tay và bàn tay

+ Tay và bàn tay liệt thường bị giảm và mất chức năng nặng và khó hồi phục hơn chân do mức độ vận động tinh tế của tay và bàn tay.

+ Phục hồi chức năng tay và bàn tay liệt giúp người bệnh phục hồi được khả năng độc lập trong sinh hoạt hàng ngày

+ Do bàn tay có hoạt động rất tinh tế do đó cần có kỹ thuật tập phục hồi chức năng riêng

2. CHỈ ĐỊNH

- Tất cả các giai đoạn của liệt nửa người do đột quỵ não

- Có thể áp dụng cho người bệnh liệt nửa người do chấn thương sọ não; viêm não, màng não, lao màng não, u não…

- Các trường hợp giảm, mất chức năng tay, bàn tay do nhiều nguyên nhân khác nhau.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh trong tình trạng cấp cứu.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Bóng tập

- Gậy tập

- Các dụng cụ hoạt động trị liệu

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường bệnh hoặc giường tập

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành... để người bệnh hợp tác

- Tư thế người bệnh phải thoải mái, thuận tiện

- Trang phục gọn gàng.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Bệnh án và phiếu điều trị chuyên khoa vật lý có chỉ định của bác sỹ

- Tình trạng người bệnh trước trong và sau khi tập

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Tập vận động ở tư thế nằm

- Kỹ thuật nắm giữ bàn tay liệt trong các động tác hỗ trợ của tay lành

- Tập vận động tay liệt có sự trợ giúp của tay lành

- Tập kiểm soát vận động tay liệt

- Tập vận động khớp vai bên liệt ra trước

6.2. Tập vận động ở tư thế ngồi

- Kỹ thuật vị thế: giúp hoặc hướng dẫn người bệnh ngồi ở vị thế đúng

- Ức chế co cứng vai tay bên liệt

- Ức chế co cứng khớp cổ tay và các ngón tay bên liệt

- Tập vận động tay liệt có sự hỗ trợ của tay lành

- Tập kiểm soát vận động tay liệt

- Tập phục hồi chức năng bàn tay

- Tập với các dụng cụ, tập theo nhóm

- Hoạt động trị liệu

6.3. Tập vận động ở tư thế đứng

- Kỹ thuật vị thế: Người bệnh kiểm soát được thăng bằng khi đứng

- Ức chế co cứng của tay liệt ở tư thế đứng.

- Tập vận động tay liệt, tay lành và toàn thân ở tư thế đứng

- Tập với các dụng cụ, tập theo nhóm

6.4. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi tập

- Theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường

- Nếu có bất thường xử trí kịp thời theo đúng phác đồ, báo cáo bác sỹ

- Ghi chép hồ sơ bệnh án: Tình trạng người bệnh trong và sau khi tập

- Hướng dẫn người bệnh đề phòng những tai biến có thể xảy ra như: Đau tăng lên, khó chịu, mệt mỏi... nếu thấy có gì bất thường báo cáo bác sĩ ngay.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

16 KỸ THUẬT TẬP ĐỨNG VÀ ĐI CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Liệt nửa người là liệt một tay, và một chân và nửa mặt cùng bên, thường do đột quỵ não.

- Tầm quan trọng của tập đứng và đi

+ Tập đứng và đi giúp người bệnh có thể tự di chuyển được

+ Dự phòng được các biến chứng của bất động

+ Giúp người bệnh phục hồi khả năng tự phục vụ và hòa nhập với gia đình và xã hội.

2. CHỈ ĐỊNH

- Giai đoạn sau của liệt nửa người do đột quỵ não, chấn thương sọ não, sau mổ u não, sau viêm não….

- Khi người bệnh đã có thể tự ngồi và kiểm soát được thăng bằng.

- Tình trạng tim mạch và toàn thân cho phép.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh liệt mềm

- Người bệnh có rối loạn thăng bằng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Thanh song song, bàn tập, khung tập đi, nạng, gậy chống

- Bàn tập

- Ghế

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ... để người bệnh yên tâm phối hợp tập luyện

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Tình trạng toàn thân, tim mạch, hô hấp của người bệnh trước khi tập

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh, hành lang…

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Kỹ thuật tập đứng

- Người bệnh ngồi trên ghế có chiều cao phù hợp, đầu và thân mình thẳng, hai vai cân xứng, trọng lượng cơ thể dồn đều lên hai bên mông và hai chân.

- Kỹ thuật y đứng phía trước hoặc phía bên liệt của người bệnh.

- Giúp hoặc hướng dẫn người bệnh dồn trọng lượng về phía trước để đứng lên

- Hướng dẫn người bệnh tự đứng lên không cần trợ giúp

- Thực hiện các bài tập ở tư thế đứng như:

+ Đứng thăng bằng tĩnh và động

+ Tập dồn trọng lượng lên chân liệt

+ Tập chuyển và dồn trọng lượng lần lượt lên hai chân

+ Tập chủ động gấp, duỗi chân liệt

+ Tập luân phiên gấp riêng khớp gối từng bên

+ Tập kiểm soát vận động của khớp gối bên liệt

+ Tập làm giảm co cứng duỗi ở khớp cổ chân.

6.2. Kỹ thuật tập đi

- Tập đứng dồn trọng lượng lên chân lành, bước chân liệt lên phía trước và ra phía sau

- Tập tăng cường thăng bằng và kiểm soát vận động của khớp háng, chân bên liệt.

- Tập luyện dáng đi

- Tập bước tại chỗ trên bàn chạy

- Tập đi

- Tập lên, xuống dốc; tập lên xuống cầu thang: lên cầu thang bước chân lành lên trước rồi đưa chân liệt lên cùng bậc, khi xuống cầu thang bước chân lành xuống bậc thang đầu tiên rồi đưa chân lành xuống cùng bậc.

- Tập đi trên các bề mặt không bằng phẳng và các địa hình khác nhau:

Thời gian đầu tập trong thanh song song, sau đó tập trong khung tập đi rồi mới tập với nạng.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi tập

- Theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường và xử trí kịp thời theo đúng phác đồ, báo cáo bác sỹ

- Ghi chép hồ sơ bệnh án: Tình trạng người bệnh trong và sau khi tập

- Hướng dẫn người bệnh đề phòng những tai biến có thể ngã trong khi tập

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

17 TẬP LĂN TRỞ KHI NẰM

1. ĐẠI CƯƠNG

- Lăn trở mình thay đổi tư thế là một trong những biện pháp quan trọng nhất nhằm phòng chống các thương tật thứ cấp.

- Lăn trở mình thay đổi tư thế được áp dụng rộng rãi tại các bệnh viện, các cơ sở y tế và tại gia đình người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

Những người bệnh nằm lâu một tư thế nào đó.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có nguy cơ trật cột sống, nguy cơ chảy máu…

- Ngay sau phẫu thuật cắt 1 bên phổi

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh trong tình trạng choáng, trụy tim mạch.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

- Điều dưỡng

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Giường đệm dày, đủ rộng và an toàn, thang dây buộc ở giữa giường.

- Các loại gối kê lót.

- Ga hoặc chăn mềm.

- Máy đo huyết áp, ống nghe

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Kiểm tra huyết áp trước khi tập

- Tùy theo từng giai đoạn của bệnh, tùy theo sự tổn thương mà kỹ thuật y lăn trở, thay đổi tư thế cho người bệnh.

- Trước và sau lăn trở, thay đổi tư thế: kỹ thuật y chuẩn bị tư thế cho người bệnh một cách thuận tiện và cần đặt họ ở một tư thế đúng.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Hiểu chỉ định, chống chỉ định ở các tư thế mà bác sĩ chuyên khoa yêu cầu.

- Lượng giá và lập chương trình phục hồi chức năng

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chỉ định, chống chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Tâm lý tiếp xúc

Tạo tâm lý tiếp xúc tốt với người bệnh, giải thích rõ lý do, mục đích việc lăn trở- thay đổi tư thế cho người bệnh và người chăm sóc của họ để tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa người bệnh và người thực hiện.

6.2. Kỹ thuật

- Nguyên tắc: lăn trở - thay đổi tư thế phải làm rất nhẹ nhàng và thận trọng để không làm tổn thương các khớp.

- Lăn trở - thay đổi tư thế làm từ 2 đến 3 giờ/ lần.

a) Người bệnh chưa chủ động vận động được tay chân

- Người thực hiện (2-3 người) nhẹ nhàng, đồng bộ lăn trở cho người bệnh và kê lót gối ở các điểm tỳ đè để chống loét và chống co rút.

- Người thực hiện dùng ga, chăn vải mềm để lăn trở cho người bệnh (từ vị trí

năm ngửa sang năm nghiêng hoặc ngược lại...)

b) Người bệnh chủ động vận động được

- Người bệnh năm ngửa tập lăn trở sang phía bên liệt, người thực hiện hướng dẫn nâng tay chân của người bệnh bên không liệt ra phía trước rồi đưa sang bên bị liệt, người bệnh lăn theo.

- Người bệnh năm ngửa tập lăn trở sang phía bên không liệt:

+ Người thực hiện nâng tay chân phía bị liệt của người bệnh ra phía trước chuyển sang phía không bị liệt, người bệnh lăn theo.

+ Người bệnh có thể cài các ngón tay của hai bên vào nhau và lăn trở sang bên phải hoặc bên trái theo ý muốn của mình.

c) Lăn trở thay đổi tư thế từ năm nghiêng sang năm sấp

Khi người bệnh đã tự thay đổi được tư thế thì nhóm phục hồi chức năng phải đánh giá và tiếp tục chỉ định phục hồi chức năng phù hợp.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tình trạng toàn thân của người bệnh: mạch, huyết áp, nhiệt độ, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

- Ghi chép, đánh giá kết quả.

- Nếu khi vận động lăn trở- thay đổi tư thế có những diễn biến xấu phải dừng ngay vận động, báo cáo bác sĩ để kịp thời xử trí.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

18 TẬP THAY ĐỔI TƯ THẾ TỪ NẰM SANG NGỒI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thay đổi tư thế từ năm sang ngồi là các vận động cần thiết cho các chức năng di chuyển thường nhật thông thường mà người bệnh cần tự thực hiện hay thực hiện có trợ giúp bằng dụng cụ hay bằng trợ giúp của người điều trị.

- Tư thế ngồi là một trong những tư thế thoải mái, tự nhiên, vững vàng và được dùng nhiều nhất trong đời sống hàng ngày.

2. CHỈ ĐỊNH

- Nguòi bệnh năm lâu tại giường

- Chuẩn bị cho tiến trình tập tiếp theo như đứng dậy từ vị thế ngồi hay di chuyển từ giường qua ghế và xe lăn

- Dùng trong trường hợp người bệnh cần được ngồi để :

+ Cố định xương chậu, tập cột sống nhất là cử động xoay trong vị thế ngồi.

+ Tập cử động cẳng bàn chân trong trạng thái không chịu trọng lượng của cơ thể.

+ Rèn luyện tư thế đúng cho phần trên của cơ thể.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có gãy xẹp thân đốt sống, gãy xương chậu mới can xương chưa chắc (độ 1, độ 2).

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Dây đu, thang dây, khung cố định vào tường, vòng nắm treo trên đầu giường

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường tập.

- Ghế ngồi

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành để người bệnh hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe tổng quát, huyết áp của người bệnh để chắc chắn người bệnh không chóng mặt hay tụt huyết áp khi ngồi dậy.

- Dùng các kỹ thuật thư giãn trước khi tập ngồi dậy nếu người người bệnh co cứng cơ ở các chi hay thân mình.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-20 phút (ước tính 0,17-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Lựa chọn bài tập và kỹ thuật phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh để có thể đạt được mục đích tốt nhất.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Ngồi dậy từ vị thế nằm nghiêng một bên (thường dùng cho người bệnh liệt nửa người): Người bệnh nằm nghiêng một bên sát mép giường, tay trên dọc trên thân, người điều trị giúp người bệnh đưa hai chân ra khỏi mép giường, hướng dẫn người bệnh nâng đầu, vai lên, chống tay dưới đẩy nâng thân mình lên để ngồi dậy.

- Tự ngồi dậy từ vị thế nằm ngửa (thường dùng cho người bệnh liệt hai chi dưới hay người bệnh nằm lâu trên giường): Nằm ngửa, hai tay dọc thân mình, nâng đầu dậy hoặc nâng hai vai bằng cách tỳ trên hai khuỷu tay, chịu sức nặng trên bàn tay, duỗi cánh tay và cẳng tay. Từ từ nâng thân mình luân phiên hay đồng thời lùi hai bàn tay về phía sau để ngồi dậy hoàn toàn, sau đó đưa hai tay về phía trước đặt lên đùi để giữ vững vị thế ngồi.

- Ngồi dậy từ vị thế nằm ngửa có trợ giúp (thường dùng cho người bệnh liệt hai

chi dưới): Níu tay một người ngồi cuối giường để ngồi dậy, níu thang dây hay bám vào thanh song song hai bên giường để ngồi dậy.

- Ngồi dậy một bên từ vị thế nằm sấp (dùng cho trẻ em chậm phát triển vận động, trẻ bại não): Nằm sấp, nâng đầu dậy bằng cách duỗi cổ, đặt một hoặc hai bàn tay trên nệm hoặc sàn nhà ngay phía dưới khớp vai, chống tay duỗi khuỷu để đẩy thân đồng thời xoay thân, đẩy người vào vị thế ngồi một bên. Nếu dùng một tay để đẩy, người bệnh xoay và ngồi về phía tay đó.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi người bệnh về chỉ số mạch an toàn, huyết áp trước và sau khi tập để đảm bảo an toàn cho người bệnh nhất là những người bệnh nằm lâu tại giường trước đó.

- Nếu người bệnh mệt nhiều giảm cường độ tập.

- Nếu người bệnh có thể tự ngồi dậy từ vị thế nằm vững và an toàn, đúng mẫu, có thể chuyển sang giai đoạn tập ngồi thăng bằng tĩnh và động.

- Tụt huyết áp tư thế, chóng mặt. Cách dự phòng có thể nâng đầu giường từ từ tăng dần để tránh hạ huyết áp tư thế đối với người bệnh nằm lâu tại giường trước khi tập cho người bệnh ngồi dậy

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

19 TẬP NGỒI THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thăng bằng là phản ứng của cơ thể nhằm duy trì tư thế trong các hoạt động hàng ngày. Tư thế là một từ dùng để mô tả bất cứ vị trí nào của cơ thể con người. Một vài tư thế hay vị trí đòi hỏi hoạt động cơ nhiều hơn những tư thế hay vị trí khác để duy trì, nhưng bất cứ tư thế nào cũng đòi hỏi thăng bằng, nếu không trọng lực sẽ tạo ra sự thay đổi tư thế.

- Thăng bằng và tư thế có liên quan đến nhau. Tùy thuộc vào chân đế, vị thế của trọng lực, đường trọng lực mà cơ thể có thể thăng bằng trong cân bằng hay không.

- Thăng bằng là nền tảng của tất cả các tư thế tĩnh hay động và thăng bằng phải được xem xét khi hoạch định bất cứ một bài tập hay một chương trình phục hồi chức năng nào cho người bệnh.

- Thăng bằng tĩnh là hiện tượng cố định vững một phần của chi thể trên các phần khác và dựa trên sự co cơ đẳng trường hay đồng co cơ.

- Bài tập thăng bằng tĩnh có thể được phát triển tăng tiến từ vị thế vững nhất (người bệnh co cơ ít nhất để giữ thăng bằng) đến vị thế ít vững nhất (người bệnh phải co cơ nhiều nhất để giữ thăng bằng). Sự ổn định và kiểm soát đầu phải được thành lập đầu tiên vì nó cực kỳ quan trọng trong mọi tư thế để giữ thăng bằng đặc biệt khi ngồi và đứng. Cơ cổ mạnh có thể được sử dụng để làm gia tăng sự co của bất cứ cơ nào còn lại trên cơ thể người bệnh.

- Thăng bằng động là phản ứng của cơ thể để duy trì sự cân bằng của nó trong các tư thế trước tác động của các lực làm mất thăng bằng của cơ thể.

- Các lực tác động làm mất sự thăng bằng của cơ thể có nhiều mức độ khác nhau từ rất nhỏ không thể đo được đến mức lớn đủ để hoàn toàn đánh đổ sự cân bằng của một người làm họ ngã xuống đất.

- Khi điều chỉnh thăng bằng ở mức độ nhỏ, các cơ có thể co đẳng trường hoặc co đẳng trương, nhưng khi cần điều chỉnh thăng bằng ở mức độ lớn hơn thì các cơ co đẳng trương. Như vậy, có thể nói thăng bằng động dựa trên co cơ đẳng trương.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người do đột quỵ não, chấn thương sọ não, u não, viêm não...

- Người bệnh tổn thương tủy sống, viêm tủy cắt ngang, đa u tủy, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống tủy...

- Người bệnh bị các bệnh lý thần kinh như Parkinson, viêm đa dây đa rễ thần kinh, đa xơ cứng, xơ cứng cột bên teo cơ...

- Người bệnh bị bại não, chậm phát triển vận động tinh thần

- Người bệnh yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới...

- Người bệnh sau phẫu thuật thay khớp toàn phần hay bán phần các khớp háng, gối...

- Người bệnh đoạn chi, lắp chân giả các loại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có gãy xẹp thân đốt sống, gãy xương chậu mới can xương chưa chắc (độ 1, độ 2).

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Ván thăng bằng với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau từ cầu thăng bằng đến ván trượt bằng gỗ có chiều dài 200cm và rộng 61cm với hai hãm ở hai đầu hay các đĩa thăng bằng.

- Các trục tròn, các ống tròn dài

- Những trái bóng thổi phồng với những kích thước khác nhau.

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường tập

- Ghế ngồi

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành để người bệnh hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng làm người bệnh thư giãn.

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Kiểm tra huyết áp, chỉ số mạch an toàn, tình trạng sức khỏe tổng quát đối với những người bệnh nằm lâu tại giường.

- Đặt người bệnh trong tư thế thoải mái, vững chắc và ổn định để cho phép người bệnh thực hiện được bài tập tốt nhất khi thực hiện quy trình.

- Dùng các kỹ thuật thư giãn trước khi tập ngồi thăng bằng tĩnh và động nếu người bệnh co co cứng cơ ở các chi hay thân mình.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-20 phút (ước tính 0,17-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Lựa chọn bài tập và kỹ thuật phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh để có thể đạt được mục đích tốt nhất.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bài tập ngồi thăng bằng tĩnh

- Người bệnh ngồi, hai bàn chân được nâng đỡ bằng bục gỗ hay đặt trên sàn nhà. Gập gối 90°, hai bàn chân gập mặt lưng hơn 90°, cổ chân ở phía sau khớp gối theo mặt phẳng đứng. Thân người thẳng, đầu thăng bằng trên hai vai, hai tay bên người hoặc kê nâng đỡ bên tay liệt nếu bị liệt bán thân.

- Yêu cầu người bệnh thay đổi tư thế đầu cổ bằng cách nhìn lên trần nhà, nhìn sang hai bên, nhìn qua vai ra sau trong khi vẫn giữ ổn định tư thế ngồi.

- Yêu cầu người bệnh chuyển trọng lượng từ mông này sang mông kia trong vị thế ngồi

6.2. Bài tập ngồi thăng bằng động

- Người bệnh ngồi trong tư thế như tập thăng bằng ngồi tĩnh, yêu cầu người bệnh với một tay hoặc cả hai tay lên trên, sang hai bên, ra phía trước hay cúi xuống nhặt vật dưới đất, ném bóng, bắt bóng. Thay đổi khoảng cách và chiều cao của hoạt động tùy theo tình trạng của người bệnh. Yêu cầu người bệnh dịch chuyển mông để ra trước, ra sau trên ghế có thể sử dụng hai tay trợ giúp.

- Người bệnh ngồi, bàn chân không được nâng đỡ.

- Người điều trị đứng phía sau hay phía trước người bệnh, nắm lấy khung chậu. Di chuyển trọng lượng ra sau, người bệnh phản ứng bằng cách duỗi khớp gối.

- Người điều trị đứng đối mặt với người bệnh, nắm lấy khung chậu. Di chuyển trọng lượng về trước, người bệnh phản ứng bằng gập gối nhiều hơn.

- Di chuyển trọng lượng sang bên, người bệnh di chuyển một chân hay một tay.

- Một khi phản ứng thăng bằng của người bệnh được tạo thuận thì nhiều cử động chi thể sẽ được thực hiện. Những cử động này liên quan đến mức độ cố gắng người bệnh để duy trì thăng bằng.

- Nếu phản ứng thăng bằng thất bại thì phản ứng duỗi bảo vệ của cánh tay là một trong những phản ứng quan trọng nhất cần được tập để người bệnh chống đỡ khi mất thăng bằng. Đặt người bệnh trong tư thế ngồi, người điều trị giữ ở cánh tay không bị liệt, di chuyển trọng lượng của người bệnh sang bên về phía liệt.

- Người điều trị giữ ở cánh tay liệt hoặc băng một bàn tay giữ cho cổ tay, các ngón tay của người bệnh duỗi, ngón cái dang, tay kia kiểm soát khớp khuỷu. Di chuyển trọng lượng lên cánh tay liệt của người bệnh. Người điều trị sau đó sử dụng kỹ thuật kéo đẩy trên trục dài của chi để tạo thuận cho phản xạ duỗi bảo vệ.

- Người bệnh ngồi trên bàn bập bênh, trên bóng tròn, trục lăn... để thực hiện các bài tập thay đổi tư thế tay, đầu ở các hướng trong không gian.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Kiểm tra tình trạng huyết áp, chỉ số mạch an toàn đối với những người bệnh nằm lâu trước đó. Nếu người bệnh chóng mặt, mệt thì nên ngừng tập và để người bệnh nằm nghỉ.

- Khi người bệnh đã có thể ngồi vững, thăng bằng động khi ngồi tốt, có thể chuyển tiếp lên giai đoạn tập đứng dậy từ vị thế ngồi cho người bệnh.

- Người bệnh có thể bị ngã khi cử động tay, thân và đầu để tập thăng bằng động đặc biệt ở những người bệnh tai biến mạch não, chấn thương sọ não hay liệt hai chân do tổn thương tủy, người điều trị cần đứng gần người bệnh ở phía trước hay bên liệt để hỗ trợ người bệnh kịp thời khi cần.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

20 TẬP THAY ĐỔI TƯ THẾ TỪ NGỒI SANG ĐỨNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng là các vận động cần thiết chuẩn bị cho tập đứng và đi mà người bệnh cần tự thực hiện hay thực hiện có trợ giúp bằng dụng cụ hay bằng trợ giúp của người điều trị.

- Tư thế đứng được dùng trong nhiều phương thức tập luyện nhưng chỉ thích hợp nếu duy trì được đúng vì trạng thái cân bằng cơ thể kém ổn định hơn các tư thế khác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người do đột quỵ não, chấn thương sọ não, u não, viêm não...

- Người bệnh liệt hai chân do tổn thương tủy sống, viêm tủy cắt ngang, đa u tủy, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống tủy...

- Người bệnh bị các bệnh lý thần kinh như Parkinson, viêm đa dây đa rễ thần kinh, đa xơ cứng, xơ cứng cột bên teo cơ...

- Người bệnh bị bại não, chậm phát triển vận động tinh thần

- Người bệnh yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới, sau thở máy kéo dài, sau ghép phổi...

- Người bệnh sau phẫu thuật thay khớp toàn phần hay bán phần các khớp háng, gối...

- Người bệnh đoạn chi, lắp chân giả các loại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Hạ huyết áp tư thế đứng

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

- Rối loạn thăng bằng

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Bục gõ
- Khung tập đi
- Thanh song song
- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn
- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường tập, ghế tập

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.
- Người bệnh trang phục gọn gàng
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe tổng quát, huyết áp của người bệnh để chắc chắn người bệnh không chóng mặt hay tụt huyết áp khi đứng dậy nhất là những người bệnh nằm dài ngày trên giường.
- Dùng các kỹ thuật thư giãn trước khi tập đứng dậy nếu người bệnh có co cứng cơ ở các chi hay thân mình.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.
- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...
- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.
- Lựa chọn bài tập và kỹ thuật phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh để có thể đạt được mục đích tốt nhất.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Tư thế người bệnh: Người bệnh ngồi trên giường hoặc trên ghế, hai bàn chân đặt sát trên sàn nhà, ngang nhau và ở sau hai gối một chút.

- Người điều trị đứng phía trước người bệnh, trợ giúp bằng cách dùng hai tay đỡ hai tay người bệnh, hai bàn tay người điều trị đặt trên hai bả vai người bệnh, kéo người bệnh cúi về phía trước cho đến khi đầu ở phía trước hai gối, lưng duỗi thẳng, chuyển trọng lượng từ mông sang hai chân và đứng dậy. Khi người bệnh đã đứng dậy, yêu cầu người bệnh giữ háng và gối duỗi thẳng.

- Người điều trị ngồi một bên của người bệnh, dùng một tay giúp người bệnh đưa hai tay về phía trước, một tay giữ gối bên liệt ấn xuống về phía sàn nhà, yêu cầu người bệnh cúi người về trước, hai vai ra trước hai gối, lưng duỗi, cổ duỗi, chuyển trọng lượng từ mông sang hai chân và đứng dậy.

- Đứng dậy trong thanh song song hay sử dụng khung đi: người bệnh ngồi trên ghế, hai tay nắm lấy thanh song song hai bên hay nắm lấy khung đi, kéo người về phía trước, chuyển trọng lượng từ mông sang chân, duỗi háng gối hai bên để đứng thẳng dậy.

- Tập đứng dậy trong thanh song song với hai nẹp chân khóa gối trong trường hợp liệt hai chi dưới có mang nẹp: Đưa xe lăn vào thanh song song, khóa gối hai nẹp, khóa xe lăn, hai chân người bệnh duỗi thẳng về phía trước, hai gót chân tiếp xúc với nền nhà. Gập thân mình về trước, nắm hai tay trên hai thanh song song, kéo hai cánh tay và nâng thân mình lên, đưa hông về phía trước. Người điều trị đứng phía trước người bệnh giữ hai chân không cho người bệnh trượt. Có thể dùng một đai ngang thắt lưng để kéo hỗ trợ người bệnh đứng dậy.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Kiểm tra tình trạng huyết áp, chỉ số mạch an toàn đối với những người bệnh nằm lâu trước đó. Nếu người bệnh chóng mặt, mệt thì nên ngừng tập và để người bệnh nằm nghỉ.

- Khi người bệnh có thể chuyển vị thế từ ngồi sang đứng an toàn, đúng mẫu, có thể chuyển sang giai đoạn tập thăng bằng đứng tĩnh và động.

- Người bệnh có thể bị ngã khi cố gắng chuyển trọng lượng từ mông sang chân để đứng dậy, đặc biệt ở những người bệnh tai biến mạch não, chấn thương sọ não hay liệt hai chân do tổn thương tủy, người điều trị cần đứng gần người bệnh ở phía trước hay bên liệt để hỗ trợ người bệnh kịp thời khi cần.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

21 TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thăng bằng là phản ứng của cơ thể nhằm duy trì tư thế trong các hoạt động hàng ngày. Tư thế là một từ dùng để mô tả bất cứ vị trí nào của cơ thể con người. Một vài tư thế hay vị trí đòi hỏi hoạt động cơ nhiều hơn những tư thế hay vị trí khác để duy trì, nhưng bất cứ tư thế nào cũng đòi hỏi thăng bằng, nếu không trọng lực sẽ tạo ra sự thay đổi tư thế.

- Thăng bằng và tư thế có liên quan đến nhau. Tùy thuộc vào chân đế, vị thế của trọng lực, đường trọng lực mà cơ thể có thể thăng bằng trong cân bằng hay không.

- Thăng bằng là nền tảng của tất cả các tư thế tĩnh hay động, thăng bằng phải được xem xét khi hoạch định bất cứ một bài tập hay một chương trình phục hồi chức năng nào cho người bệnh.

- Thăng bằng tĩnh là hiện tượng cố định vững một phần của chi thể trên các phần khác và dựa trên sự co cơ đẳng trường hay đồng co cơ. Bài tập thăng bằng tĩnh có thể được phát triển tăng tiến từ vị thế vững nhất (người bệnh co cơ ít nhất để giữ thăng bằng) đến vị thế ít vững nhất (người bệnh phải co cơ nhiều nhất để giữ thăng bằng).

- Sự ổn định và kiểm soát đầu phải được thành lập đầu tiên vì nó cực kỳ quan trọng trong mọi tư thế để giữ thăng bằng đặc biệt khi ngồi và đứng. Cơ cổ mạnh có thể được sử dụng để làm gia tăng sự co của bất cứ cơ nào còn lại trên cơ thể người bệnh.

- Thăng bằng động là phản ứng của cơ thể để duy trì sự cân bằng của nó trong các tư thế trước tác động của các lực làm mất thăng bằng của cơ thể.

- Các lực tác động làm mất sự thăng bằng của cơ thể có nhiều mức độ khác nhau từ rất nhỏ không thể đo được đến mức lớn đủ để hoàn toàn đánh đổ sự cân bằng của một người làm họ ngã xuống đất.

- Khi điều chỉnh thăng bằng ở mức độ nhỏ, các cơ có thể co đẳng trường hoặc co đẳng trương, nhưng khi cần điều chỉnh thăng bằng ở mức độ lớn hơn thì các cơ co đẳng trương. Như vậy có thể nói thăng bằng động dựa trên co cơ đẳng trương.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người do đột quỵ não, chấn thương sọ não, u não, viêm não...

- Người bệnh liệt hai chân do tổn thương tủy sống, viêm tủy cắt ngang, đa u tủy, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống tủy...

- Người bệnh bị các bệnh lý thần kinh như Parkinson, viêm đa dây đa rễ thần kinh, đa xơ cứng, xơ cứng cột bên teo cơ...

- Người bệnh bị bại não, chậm phát triển vận động tinh thần

- Người bệnh yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới, sau thở máy kéo dài...

- Người bệnh sau phẫu thuật thay khớp toàn phần hay bán phần các khớp háng, gối...

- Người bệnh đoạn chi, lắp chân giả các loại.

- Người bệnh sau phẫu thuật ghép phổi.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Hạ huyết áp tư thế

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Ván thăng bằng với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau từ cầu thăng bằng đến ván trượt bằng gỗ có chiều dài 200cm và rộng 61 cm với hai hãm ở hai đầu hay các đĩa thăng bằng.

- Thảm tập.

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường tập, ghế tập

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành để người bệnh hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Kiểm tra huyết áp, chỉ số mạch an toàn, tình trạng sức khỏe tổng quát

- Dùng các kỹ thuật thư giãn trước khi tập đứng thăng bằng tĩnh và động nếu người bệnh co cứng cơ ở các chi hay thân mình.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Lựa chọn bài tập và kỹ thuật phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh để có thể đạt được mục đích tốt nhất

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thăng bằng đứng trên hai chân

- Người bệnh đứng thẳng trên nệm hay trên sàn nhà, khớp háng và gối hai bên duỗi, hai bàn chân cách nhau khoảng 8-10cm, góc bàn chân xoay ngoài khoảng 6°. Đầu thăng bằng trên hai vai, hai tay thả lỏng bên thân. Yêu cầu người bệnh lần lượt nhìn lên trần nhà, nhìn sang hai bên nhìn ra sau, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia, trong khi vẫn giữ ổn định tư thế đứng.

- Người bệnh đứng trên nệm hay trên sàn nhà:

+ Người điều trị đứng phía sau người bệnh, giữ người bệnh ở khung chậu hay khớp vai (người bệnh cảm thấy an toàn hơn khi được giữ ở khung chậu). Di chuyển trọng lượng ra sau làm gập mặt lưng bàn chân. Nếu di chuyển nhiều hơn sẽ làm người bệnh bước một bước ra sau, để không cho người bệnh bước ra sau người điều trị đặt một bàn chân của mình ngay sau gót chân của người bệnh, khi đó người bệnh gập hông và lưng về phía trước, cánh tay nâng cao về phía trước một cách đồng thời.

+ Người điều trị đứng trước mặt người bệnh, giữ người bệnh ở khung chậu. Di chuyển trọng lượng ra trước làm người bệnh đứng trên các ngón chân. Di chuyển trọng lượng xa hơn về phía trước sẽ làm người bệnh bước lên một bước.

+ Người điều trị đứng phía sau hay trước người bệnh. Di chuyển trọng lượng sang bên lên một chân, người bệnh dang chân bên không chịu sức nặng và chéo qua trước chân chịu sức nặng.

Nếu trọng lượng sau đó được chuyển sang hướng ngược lại thì chân sẽ quay trở lại vị thế khởi đầu. Sự di chuyển trọng lượng thay đổi nhau này có thể làm nhịp nhàng để tạo nên sự di chuyển chân lặp đi lặp lại.

- Người bệnh đứng trên bàn nghiêng, tập chuyển trọng lượng sang hai bên trong

khi đứng.

6.2. Thăng bằng đứng trên một chân

- Người bệnh đứng trên một chân, tập bước chân kia lên trước và ra sau.

- Người bệnh giữ một chân trên bục thấp, tập chuyển trọng lượng trên chân đó bằng cách bước chân kia lên xuống

- Người bệnh đứng trên một chân. Người điều trị nắm chân kia nâng lên đặt bàn chân người bệnh trên một tay, tay còn lại nắm lấy mặt sau của chân đó ngay dưới khớp gối, để gối người bệnh hơi gập. Người điều trị cử động nhẹ, chân được nâng tạo nên phản ứng thăng bằng trên chân trụ để duy trì đứng yên không động đậy.

- Người điều trị di chuyển nhiều hơn chân được nâng để người bệnh di chuyển theo cử động trục gót chân - ngón chân, hoặc là nhảy lò cò.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Kiểm tra tình trạng huyết áp, chỉ số mạch an toàn đối với những người bệnh nằm lâu trước đó. Nếu người bệnh chóng mặt, mệt thì nên ngừng tập và để người bệnh nằm nghỉ.

- Khi người bệnh đã thực hiện đứng thăng bằng tốt, an toàn, có thể chuyển tiếp lên giai đoạn tập dáng đi và tập đi trong thanh song song.

- Té ngã có thể xảy ra trong quá trình người bệnh di chuyển trọng lượng cơ thể ra khỏi chân đế để tập thăng bằng đứng động. Người điều trị cần đứng gần người bệnh ở một bên hay phía trước để hỗ trợ người bệnh khi cần. Có thể để người bệnh tập thăng bằng đứng trong thanh song song trước nếu người bệnh cảm thấy không an toàn để tránh các cử động thay thế và phòng ngừa ngã

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

22 TẬP DÁNG ĐI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Đi (với nhiều hình thức khác nhau của nó: đi bộ, chạy, lên xuống cầu thang...) là một hoạt động điều hợp khéo léo và thăng bằng mà chúng ta đạt được trong quá trình phát triển từ nhỏ và có thể tập luyện để cải thiện. Đây là một hoạt động liên quan đến nhiều khớp và cơ nhưng được thực hiện mà không có bất kỳ một sự cố gắng có ý thức nào cho tới khi một trong những thành phần cơ hay khớp đó bị mất điều khiển.

- Khi đi, chúng ta di chuyển các thành phần cơ thể theo một trật tự nhất định thích nghi với loại mặt phẳng mà ta đi trên nó, với không gian và với những bất trắc bao quanh chúng ta. Tất cả các đường vào cảm giác đều liên quan đến hoạt động đi và khi có bất cứ phần nào trong hệ thống cảm giác bị mất kiểm soát, dáng đi cũng có thể bị ảnh hưởng.

- Chu kỳ đi: Một chu kỳ đi hoàn chỉnh bao gồm các giai đoạn sau:

+ Thì chạm gót (chiếm 0-15% chu kỳ đi): Sức nặng cơ thể được truyền qua chân trước, bàn chân hạ xuống mặt đất bằng chạm gót.

+ Giữa thì chống (từ 15%-30% chu kỳ đi): Trọng lượng cơ thể đặt trên bàn chân, thân mình và chân tiến về phía trước trên bàn chân đứng yên.

+ Thì đẩy (từ 30-45% chu kỳ đi): Gót chân của chân chịu sức nặng rời khỏi mặt đất, thân mình đẩy về phía trước bởi tác động của cơ gấp lòng bàn chân.

+ Cuối thì chống: (từ 45-60% chu kỳ đi): Khối lượng cơ thể được chuyển hoàn toàn sang chân đối bên để ngón chân nhấc lên khỏi sàn nhà

+ Thì đu đưa (chiếm 40% cuối cùng của chu kỳ đi): Bắt đầu từ giai đoạn gia tốc đến giữa thì đu đưa khi chân đu băng qua chân chống bên kia và cuối cùng là giai đoạn giảm tốc.

+ Cuối giai đoạn chống của chân này và đầu giai đoạn chống của chân kia có một thời gian cơ thể chịu sức nặng trên hai chân gọi là giai đoạn chống kép, giai đoạn này càng ngắn khi tốc độ đi càng nhanh và không còn khi chạy.

- Các nhóm cơ tham gia vào hoạt động đi

+ Các cơ đẩy là các cơ gập ngón chân, cơ gập mặt lòng bàn chân, cơ duỗi gối và háng.

+ Các cơ đu qua là các cơ duỗi của ngón chân, cơ gập mặt lưng bàn chân, cơ gập và duỗi gối, và cơ gập háng.

+ Các cơ dạng, xoay trong, xoay ngoài khớp háng, gập bên và xoay thân cũng hoạt động trong giai đoạn chuyển trọng lượng và cử động chậu hông. Nếu không có cử động thăng bằng của chậu trong cả hai cử động kéo và xoay khớp háng, không thể có dáng đi đúng được.

+ Các cơ xoay của thân trên và đầu cũng hoạt động, do vậy mặt và phần thân trên duy trì hướng về phía trước. Tầm độ hoạt động của mỗi nhóm cơ này tùy thuộc trên độ dài và chiều cao của bước chân.

+ Cần phải duy trì sức mạnh của những nhóm cơ liên quan để chúng hoạt động hiệu quả khi đi, đặc biệt là những nhóm cơ chịu sức nặng của chi. Những nhóm cơ phụ của thân cũng phải được tập mạnh và cũng không được quên sự đu đưa bình thường của cánh tay khi đi.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người do đột quỵ não, chấn thương sọ não, u não, viêm não…

- Người bệnh liệt hai chân do tổn thương tủy sống, viêm tủy cắt ngang, u tủy, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống tủy…

- Người bệnh bị các bệnh lý thần kinh như Parkinson, viêm đa dây đa rễ thần kinh, xơ cứng rải rác, xơ cứng cột bên teo cơ…

- Người bệnh bị bại não, chậm phát triển vận động tinh thần

- Người bệnh yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới, sau phẫu thuật cố định cột sống, sau thở máy kéo dài…

- Người bệnh sau phẫu thuật thay khớp toàn phần hay bán phần các khớp háng, gối…

- Người bệnh đoạn chi, lắp chân giả các loại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Bàn tập

- Gậy, nạng, đai nâng đỡ gối, cổ chân...

- Thanh song song, cầu thang tập.

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Giải thích mục đích bài tập và quy trình tập cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Xác định xem yếu tố nào hoặc khớp nào làm hạn chế hoặc là nguyên nhân làm giảm khả năng đi để chọn bài tập thích hợp.

- Đánh giá khả năng thăng bằng của người bệnh khi thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng, khi đứng, khi đi để đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình tập đi.

- Đánh giá sức mạnh cơ hai chân, cơ thân mình và khả năng kiểm soát đầu cổ trong vị thế ngồi, đứng (nếu là trẻ em).

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện : phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Những bài tập duy trì hay gia tăng lực cơ trên giường

Tất cả các bài tập này nên có đề kháng băng lò xo hay tạ khi có thể và không chống chỉ định, nên được tập trong suốt thời gian nằm viện.

Đối với tay: Gập các ngón, đối ngón cái, duỗi cổ tay, duỗi khuỷu, duỗi vai, xoay trong vai, hạ vai

Đối với thân: Xoay, duỗi, gập thân, gập bên chậu và kéo khớp háng

Đối với chân: Gập và duỗi các ngón và bàn chân, gập và duỗi gối, gập và duỗi háng, dang và khép háng, xoay trong và xoay ngoài khớp háng.

Những bài tập tăng tiến: Nếu người bệnh nằm lâu, khi chuẩn bị tập đi cần:

- Cần thời gian để thích nghi với tư thế thẳng đứng.

- Cần được hướng dẫn co cơ thành bụng, thở sâu để đảm bảo tuần hoàn tĩnh mạch sâu và cung cấp máu đầy đủ cho não trước khi ngồi thẳng dậy.

- Cần tập bài tập thăng bằng trong tư thế nửa nằm, ngồi trên giường, ngồi trên ghế cao, ngồi trên xe lăn với chân đặt trên sàn nhà hay trên dụng cụ nâng đỡ nếu người bệnh được dự đoán có phản ứng thăng bằng kém.

- Bàn nghiêng quay rất có giá trị cho những người bệnh cần được hướng dẫn lại cách chịu sức nặng sau chấn thương chi dưới. Bàn nghiêng quay được nghiêng dần từ vị thế nằm ngang sang vị thế đứng thẳng sao cho người bệnh có thể gia tăng dần chịu sức nặng trên phần bị thương.

6.2. Các bài tập luyện dáng đi

Bài tập với chân phải lên trước, chân trái chống chịu sức nặng

- Bài tập thì chạm gót (chân phải): Tập đầu và thân thẳng, tay thả lỏng giữa thân mình. Khung chậu xoay về phía trước một ít, gối phải duỗi, bàn chân phải gập mặt lưng và thẳng góc với cẳng chân.

- Bài tập giữa thì chống (chân phải): Tập đầu và thân thẳng đứng, hai tay gần đường giữa thân, khuỷu hơi gập. Khung chậu nghiêng bên trái một ít, chân phải xoay ngoài nhẹ khớp háng.

- Bài tập thì đẩy tới (chân phải): Tay phải ở trước đường giữa thân với khuỷu gập nhẹ, tay trái ở sau với khuỷu duỗi. Khung chậu xoay trước, gối phải gập nhẹ, cổ chân phải gập mặt lòng, các ngón chân phải duỗi quá ở bàn đốt.

- Bài tập giữa thì đu (chân phải): Khung chậu xoay trước ít, hai tay giữa thân mình. Hông và gối phải gập, bàn chân thẳng góc với cẳng chân và hơi nghiêng ngoài.

- Bài tập thì chống kép: Chân phải đặt trước, chân trái ở sau, khoảng cách hai bàn chân (từ điểm chạm gót chân này đến điểm chạm gót chân kia khoảng 75-78 cm, tập di chuyển trọng lượng từ chân phải sang chân trái và ngược lại.

Lặp lại như trên với chân trái lên trước, chân phải chống chịu sức nặng.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Người bệnh cảm thấy thoải mái, vững vàng khi di chuyển trọng lượng cơ thể, không có các cử động thay thế như nâng chậu thay thế gập hông, quét vòng chân thay thế gập gối trong thì đu đưa hay duỗi quá gối (khóa gối) trong thì chống, nâng hông một bên thay thế mất gập mặt lưng bàn chân ở cuối thì chống.

- Khi người bệnh đã có thực hiện dáng đi tốt với các thì chống và đu đưa hợp lý,

đúng mẫu, chuyển tiếp sang giai đoạn tập đi với hai tay cử động phối hợp bên thân và tập tăng dần tốc độ đi cho tới khi đạt được tốc độ đi bình thường.

- Người bệnh có thể té ngã nếu người bệnh không đủ thăng bằng khi đứng hoặc khi đi. Trong trường hợp này cho người bệnh tập dáng đi trong thanh song song trước khi tập ngoài thanh song song. Người điều trị luôn đứng một bên hoặc phía trước người bệnh để có thể trợ giúp kịp thời khi cần.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

23 TẬP ĐI VỚI THANH SONG SONG

1. ĐẠI CƯƠNG

Tập đi trong thanh song song thường được sử dụng trong giai đoạn đầu của quá trình tập đi cho người bệnh sau khi người bệnh đã tự đứng được, thăng bằng đứng tương đối tốt.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người do đột quỵ não, chấn thương sọ não, u não, viêm não...

- Người bệnh liệt hai chân do tổn thương tủy sống, viêm tủy cắt ngang, u tủy, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống tủy...

- Người bệnh bị các bệnh lý thần kinh như Parkinson, viêm đa dây đa rễ thần kinh, xơ cứng rải rác, xơ cứng cột bên teo cơ...

- Người bệnh bị bại não, chậm phát triển vận động, tâm thần

- Người bệnh yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới, sau thở máy kéo dài...

- Người bệnh sau phẫu thuật thay khớp toàn phần hay bán phần các khớp háng, gối...

- Người bệnh đoạn chi, lắp chân giả các loại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Liệt liệt hoàn toàn 2 chi trên

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Thanh song song, cầu thang tập.

- Bàn tập, ghế ngồi.

- Gậy, nạng, đai nâng đỡ gối, cổ chân...

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích mục đích bài tập và quy trình tập cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Xác định xem yếu tố nào hoặc khớp nào làm hạn chế hoặc là nguyên nhân làm giảm khả năng đi để chọn bài tập thích hợp.

- Đánh giá khả năng thăng bằng của người bệnh khi thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng, khi đứng, khi đi để đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình tập đi.

- Đánh giá sức mạnh cơ hai chân, cơ thân mình và khả năng kiểm soát đầu cổ trong vị thế ngồi, đứng (nếu là trẻ em).

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng, khu vực thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Tập đứng dậy

- Tốt nhất cho người bệnh tập luyện ở thanh song song có bước chân. Xe lăn được đặt giữa hai thanh song song, khóa lại và người bệnh di chuyển tới phía trước của xe, nâng chỗ đặt bàn chân của xe lên, hai tay người bệnh đặt trên hai bên thanh song song và kéo người đứng dậy (nếu người bệnh có thể làm như vậy).

- Với người bệnh có thể chịu sức nặng trên cả hai chân mà không có chống chỉ

định, có thể tập đứng dậy bằng hai phương pháp mà sự chọn lựa tùy thuộc vào:

+ Chiều cao của người bệnh và người điều trị.

+ Sự vạm vỡ của người bệnh.

+ Chiều dài của cánh tay người điều trị.

+ Khả năng thăng bằng của người bệnh.

Phương pháp 1:

Người thực hiện đứng sát bên phù hợp, kiểm soát bàn chân, gối, chậu và thân mình; hỗ trợ đứng dậy theo khả năng chịu tải. Dùng đai hỗ trợ chuyển tư thế khi phù hợp, không nâng hoặc kéo người bệnh qua nách hay tay bên liệt.

Phương pháp 2:

Người thực hiện bố trí tư thế bảo vệ gối và thân mình, hướng dẫn người bệnh chủ động phối hợp. Dùng đai hỗ trợ hoặc thêm nhân lực khi cần; không ép nâng hai nách hoặc kéo vai để dựng người bệnh.

6.2. Tập thăng bằng trong thanh song song

- Người bệnh được luyện tập thăng bằng bằng sử dụng kỹ thuật ổn định nhịp nhàng với một lực ép trên khớp vai hoặc trên chậu hoặc trên cả hai. Khuyến khích người bệnh thực hiện gập và duỗi của chân đứng trong tầm độ nhỏ, di chuyển tay ra trước và sau trên thanh song song.

- Nếu người bệnh có thể chịu trọng lượng trên cả hai chân, tập di chuyển trọng lượng sang hai bên trong vị thế đứng dang chân sang hai bên trước, sau đó di chuyển trọng lượng trước sau trong vị thế đứng chân trước chân sau.

- Lực ép của người điều trị trên chậu bên hướng người bệnh đưa qua sẽ khuyến khích người bệnh đẩy chậu về hướng trên chân đế do vậy có thể chuyển trọng lượng sang chân đế. Người bệnh cần có thời gian nghỉ theo yêu cầu.

6.3. Tập đi trong thanh song song

- Người bệnh được tập đi trong thanh song song tăng tiến khởi đầu với dáng đi đu tới bằng cách di chuyển hai bàn tay về phía trước, nhún thân mình đặt hai chân tới cùng mức với đoạn tiến của tay

- Tập dáng đi đu qua bằng di chuyển hai bàn tay về phía trước, nhún thân mình đặt hai chân tới quá mức với đoạn tiến của tay (xa hơn tay)

- Tập dáng đi bốn điểm: đưa tay phải lên trước, tiếp đến chân trái lên, tiếp đến tay trái và cuối cùng là chân phải lên

- Tập đi hai điểm: tay phải và chân trái đồng thời đưa lên phía trước, sau đó tay trái và chân phải tiến lên đồng thời.

Người bệnh cũng có thể sử dụng một thanh song song và một nạng, sau đó cả hai nạng nếu thanh song song đủ rộng. Người điều trị cần đi cạnh người bệnh.

Khoảng cách đi nên được xem xét và để người bệnh được nghỉ thường xuyên nếu người bệnh sợ hãi hay yếu. Khi người bệnh mạnh hơn, thực hiện tốt hơn thì nên tăng dần khoảng cách đi và giảm dần thời gian, số lần nghỉ.

Khi thanh song song quá dài thì cần đưa xe lăn hay ghế vào giúp người bệnh ở bất cứ khoảng nào trong thanh song song để người bệnh nghỉ khi có nhu cầu.

6.4. Tập xoay người trong thanh song song

- Bàn chân được đặt qua một bên với góc 45°, cánh tay gần cùng bên di chuyển trên thanh mà người bệnh xoay người đối mặt với nó, một loạt bước chân bước qua được thực hiện tiếp để xoay tới 90° và di chuyển cánh tay phía sau người bệnh theo hướng xoay, một lần bước nữa sẽ hoàn chỉnh sự xoay người.

6.5. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Người bệnh thấy thoải mái và vững vàng trong thanh song song. Cần kiểm soát dáng đi của người bệnh tốt để đảm bảo không có những cử động thay thế.

- Có thể sử dụng hai tay trợ giúp khi di chuyển trong thanh song song để đảm bảo thăng bằng và an toàn cho người bệnh.

- Nếu người bệnh chưa thăng bằng đứng tĩnh và động tốt, người bệnh có thể bị ngã.

- Hướng dẫn người bệnh di chuyển tay trên thanh song song để trợ giúp thăng bằng.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

24 TẬP ĐI VỚI KHUNG TẬP ĐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Khung tập đi là một loại dụng cụ trợ giúp di chuyển cần thiết để giúp người gặp khó khăn trong di chuyển đi lại. Có nhiều loại khung tập đi khác nhau: có bánh xe, không có bánh xe…

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người, liệt hai chi dưới, người bệnh tập sử dụng chân giả, nẹp chỉnh hình, trẻ bại não, bại liệt, một số bệnh lý chi dưới khác…

- Người có rối loạn thăng bằng, người già yếu.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Khung tập đi

- Kích thước của khung tập đi phải phù hợp với từng người bệnh vì vậy cần đo trước khi tập luyện.

+ Đo chiều cao:

Mức 1: đến thắt lưng

Mức 2: đến giữa thắt lưng và nách

Mức 3: có giá đỡ đến nách

+ Đo chiều rộng: bằng hai vai người bệnh

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở và tình trạng người bệnh trước khi tập

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng, khu vực thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Hướng dẫn người bệnh đứng thẳng, hai tay nắm lấy phần trên khung, hai chân đứng phần giữa khung, hơi nghiêng về phía trước để giữ trọng lượng.

- Hướng dẫn người bệnh đi như sau:

+ Người bệnh di chuyển khung lên phía trước bằng cách đẩy hoặc nâng khung lên.

+ Di chuyển một chân lên phía trước.

+ Tiếp tục di chuyển chân kia.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi tình trạng, mạch, nhiệt độ, huyết áp của người bệnh trong và sau khi làm kỹ thuật.

- Trong khi tập với khung tập đi người bệnh có thể bị ngã hoặc dụng cụ bị gãy.

- Xử trí: kiểm tra kỹ dụng cụ trước khi tập, phải luôn có một người đi cạnh để trợ giúp người bệnh.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

25 TẬP ĐI VỚI NẠNG (NẠNG NÁCH, NẠNG KHUỶU)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Nạng là một loại dụng cụ trợ giúp di chuyển cần thiết để giúp người gặp khó khăn trong di chuyển, đi lại. Có hai loại chính: nạng nách và nạng khuỷu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người, liệt hai chi dưới, người bệnh tập sử dụng chân giả, nẹp chỉnh hình, trẻ bại não, bại liệt, sau phẫu thuật thay khớp, kết hợp xương, dây chằng chi dưới...

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý cả 2 chi trên không có khả năng chịu lực: cơ yếu, gãy xương, bong gân, trật khớp...

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Nạng nách hoặc nạng khuỷu. Kích thước của nạng phải phù hợp với từng người bệnh vì vậy cần đo trước khi tập luyện.

+ Đo chiều cao nạng nách: Từ đất đến điểm cách hố nách 2-3 khoát ngón tay

+ Đo chiều cao nạng khuỷu: Từ sàn nhà đến cổ tay, đoạn tựa khuỷu từ khuỷu đến cổ tay.

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước

khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở và tình trạng người bệnh trước khi tập

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng, khu vực thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Cách đi ba điểm

Đầu tiên 2 nạng được di chuyển trước, sau đó đến chân bị bệnh (yếu hơn) đưa ra trước, rồi tiếp đến chân bình thường (chân bình thường được đặt ở phía trước nạng).

6.2. Cách đi bốn điểm luân phiên

Cách đi này tạo ra ít nhất là 3 điểm trợ giúp ở cùng một thời điểm. Nạng bên phải di chuyển trước tiên -> bàn chân trái -> nạng bên trái -> bàn chân phải.

6.3. Cách đi hai điểm luân phiên

Kiểu đi này nhanh hơn kiểu đi 4 điểm. Nó yêu cầu thăng bằng tốt hơn vì chỉ có 2 điểm trợ giúp cơ thể cùng một lúc. Nạng trái và chân phải di chuyển lên trước cùng một lúc. Nạng phải và chân trái di chuyển lên trước cùng một lúc.

6.4. Cách đi kiểu đu đưa

Kiểu này dùng cho những người bệnh không thể dồn trọng lượng lên một chân. Cả hai nạng đưa về phía trước cùng một lúc với bàn chân yếu. Chân khỏe hơn đưa về phía trước qua điểm tì của nạng để giữ thăng bằng.

6.5. Cách lên xuống cầu thang bằng nạng

- Đi lên cầu thang: Đặt chân lành lên bậc thang tiếp theo, dồn trọng lượng thân thể lên chân đó, hai nạng và chân yếu sẽ cùng di chuyển lên bậc thang đó.

- Xuống cầu thang: Đặt nạng và chân yếu xuống trước, sau đó bước chân lành xuống bậc thang đó. Chân yếu luôn luôn có nạng để trợ giúp.

6.6. Cách sử dụng 1 nạng

Cho nạng ở phía bên lành, cho chân liệt và một nạng bước lên cùng một lúc, tiếp theo sau là chân lành.

6.7. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi tình trạng, mạch, nhiệt độ, huyết áp của người bệnh trong và sau khi làm kỹ thuật.

- Trong khi tập với nạng, người bệnh có thể bị ngã hoặc dụng cụ bị gãy.

- Xử trí: kiểm tra kỹ dụng cụ trước khi tập, phải luôn có một người đi cạnh để trợ giúp người bệnh.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế, 2014, “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”, ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

26 TẬP ĐI VỚI GẬY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gậy là một loại dụng cụ trợ giúp di chuyển cần thiết để giúp người gặp khó khăn trong di chuyển, đi lại. Các loại gậy: gậy 01 chân đế và gậy nhiều chân đế.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người, người lớn tuổi.

- Người bệnh tập sử dụng chân giả, nẹp chỉnh hình.

- Trẻ bại não.

- Một số bệnh lý chi dưới khác (thoái hóa khớp gối,...).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý cả 2 chi trên không có khả năng chịu lực: cơ yếu, gãy xương, bong gân, trật khớp...

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

- Người bệnh không có khả năng kiểm soát thăng bằng

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Gậy 01 chân đế hoặc nhiều chân đế. Chiều cao của gậy: ngang gai chậu trước trên của người bệnh

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước

khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Đi giày hoặc nẹp (nếu có) cho người bệnh

- Giải thích cho bệnh nhi (bệnh nhi có khả năng hiểu) và gia đình bệnh nhi biết việc mình sắp làm.

- Hướng dẫn bệnh nhi (trẻ có khả năng hiểu) những điều cần thiết

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng, khu vực thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Cầm gậy đối bên: Người bệnh cầm gậy ở tay đối bên với chân yếu. Đầu tiên đưa gậy về phía trước, ra phía ngoài khoảng 5- 10 cm, kế đến bước chân yếu lên ngang hoặc băng gậy. Chân mạnh bước lên băng gậy.

- Cầm gậy cùng bên: Người bệnh cầm gậy cùng bên với chân yếu. Di chuyển gậy cùng lúc với chân yếu.

- Cách lên xuống cầu thang băng gậy

+ Đi lên cầu thang: đặt chân lành lên bậc thang tiếp theo, dồn trọng lượng thân thể lên chân đó, gậy và chân yếu sẽ cùng di chuyển lên bậc thang đó.

+ Xuống cầu thang: đặt gậy và chân yếu xuống trước, sau đó bước chân lành xuống bậc thang đó. Chân yếu luôn luôn có gậy để trợ giúp.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi tình trạng, mạch, nhiệt độ, huyết áp của người bệnh trong và sau khi làm kỹ thuật.

- Trong khi tập với gậy, người bệnh có thể bị ngã hoặc dụng cụ bị gãy.

- Xử trí: kiểm tra kỹ dụng cụ trước khi tập, phải luôn có một người đi cạnh để

trợ giúp người bệnh.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

27 TẬP ĐI VỚI BÀN XƯƠNG CÁ

1. ĐẠI CƯƠNG

Tập đi với bàn xương cá là biện pháp tập giúp cải thiện khả năng đi lại của người bệnh có biến dạng xoay của bàn chân.

2. CHỈ ĐỊNH

Bàn chân bị biến dạng xoay trong hoặc xoay ngoài.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Các biến dạng khác của bàn chân

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Bàn xương cá.

- Thanh song song

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Đi giày hoặc nẹp (nếu có) cho người bệnh

- Giải thích cho bệnh nhi (bệnh nhi có khả năng hiểu) và gia đình bệnh nhi biết việc mình sắp làm.

- Hướng dẫn bệnh nhi (trẻ có khả năng hiểu) những điều cần thiết

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Lượng giá các dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở và tình trạng người bệnh. Đọc kỹ phiếu điều trị.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng, khu vực thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Tập đi với bàn xương cá cho người bệnh bàn chân bị xoay trong

a) Người bệnh có khả năng tự đi

Thực hiện kỹ thuật:

- Đi mẫu trên bàn xương cá theo chiều xương cá hướng ra ngoài, giải thích cho người bệnh phải đặt chân sát với cạnh ngoài của xương cá để chân xoay ra ngoài.

- Để người bệnh tự đi, khi đi hết chiều dài của bàn xương cá thì đi lùi lại hoặc đi ra khỏi bàn xương cá quay vòng lại (nếu người bệnh không có khả năng đi lùi).

- Kỹ thuật y đi sau người bệnh để hỗ trợ nếu người bệnh mất thăng bằng.

- Tập đi cho người bệnh 20-30 phút, ngày 3 lần

b) Người bệnh không có khả năng tự đi nhưng có khả năng đi trong thanh song song

Thực hiện kỹ thuật:

- Đi mẫu trên bàn xương cá theo chiều xương cá hướng ra ngoài và 2 tay bám

vào thanh song song, giải thích cho người bệnh phải đặt chân sát với cạnh ngoài của xương cá để chân xoay ra ngoài.

- Để người bệnh tự đi bằng cách bám vào thanh song song, khi đi hết chiều dài của bàn xương cá thì đi lùi lại hoặc đi ra khỏi bàn xương cá quay vòng lại (nếu người bệnh không có khả năng đi lùi).

- Kỹ thuật y đi sau hoặc đi bên ngoài thanh song song để hỗ trợ nếu người bệnh mất thăng bằng.

- Tập đi cho người bệnh 20-30 phút, ngày 3 lần

6.2. Tập đi với bàn xương cá cho người bệnh bàn chân bị xoay ngoài.

a) Người bệnh có khả năng tự đi

Thực hiện kỹ thuật:

- Đi mẫu trên bàn xương cá theo chiều xương cá hướng vào trong, giải thích cho người bệnh phải đặt chân sát với cạnh trong của xương cá để chân xoay vào trong.

- Để người bệnh tự đi, khi đi hết chiều dài của bàn xương cá thì đi lùi lại hoặc đi ra khỏi bàn xương cá và quay vòng lại (nếu người bệnh không có khả năng đi lùi).

- Kỹ thuật y đi sau người bệnh để hỗ trợ nếu người bệnh mất thăng bằng.

- Tập đi cho người bệnh 20-30 phút, ngày 3 lần

b) Người bệnh không có khả năng tự đi nhưng có khả năng đi trong thanh song song

Thực hiện kỹ thuật:

- Đi mẫu trên bàn xương cá theo chiều xương cá hướng vào trong và 2 tay bám vào thanh song song, giải thích cho người bệnh phải đặt chân sát với cạnh trong của xương cá để chân xoay vào trong.

- Để người bệnh tự đi bằng cách bám vào thanh song song, khi đi hết chiều dài của bàn xương cá thì đi lùi lại hoặc đi ra khỏi bàn xương cá quay vòng lại (nếu người bệnh không có khả năng đi lùi).

- Kỹ thuật y đi sau hoặc đi bên ngoài thanh song song để hỗ trợ nếu người bệnh mất thăng bằng.

- Tập đi cho người bệnh 20-30 phút, ngày 3 lần.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Trong quá trình tập luyện cần theo dõi tránh tập quá sức

- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh.

- Trong khi tập, người bệnh có thể bị ngã.

- Xử trí: Phải luôn có một người đi cạnh để trợ giúp người bệnh.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

28 TẬP LÊN XUỐNG CẦU THANG

1. ĐẠI CƯƠNG

Tập lên xuống cầu thang là một bài tập chức năng quan trọng, giúp cải thiện và nâng cao chức năng đi lại của người bệnh. Bài tập này đặc biệt có ích cho những người bệnh có khó khăn trong di chuyển, những người bệnh yếu hoặc liệt. Tập lên xuống cầu thang có thể kết hợp với các dụng cụ trợ giúp (ví dụ: nạng, gậy...).

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người, chấn thương sọ não, Parkison

- Người bệnh tổn thương tủy sống không hoàn toàn, sau phẫu thuật cột sống, khớp háng, khớp gối…

- Người bệnh yếu hai chi dưới, người bệnh nằm lâu, sau ghép tạng, sau thở máy kéo dài…

- Người bệnh khó khăn trong di chuyển như đau thần kinh tọa, đau một chân, gãy xương chi dưới.,

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thể trạng quá yếu, đứng chưa vững

- Người bệnh không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức,

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Ghế ngồi

- Cầu thang tập

- Nạng các loại

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra

- Người bệnh trang phục gọn gàng

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng, khu vực thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Tập lên xuống cầu thang (Áp dụng cho người bệnh đau một chân, đau thần kinh tọa, khó khăn khi di chuyển…)

Tư thế người bệnh ban đầu: ngồi trên ghế

a) Lên cầu thang

- Kỹ thuật y đứng phía sau người bệnh

- Kỹ thuật y hướng dẫn người bệnh chuyển từ ngồi sang đứng

- Khi lên cầu thang, người bệnh bám tay vịn, bước chân khỏe lên trước; đưa chân yếu hoặc đau lên cùng bậc, phối hợp dụng cụ trợ giúp theo hướng dẫn. Chỉ thực hiện trong giới hạn chịu tải đã được chỉ định.

- Người bệnh tiếp tục thực hiện lên các bậc tiếp theo

b) Xuống cầu thang

- Kỹ thuật y đứng phía trước người bệnh

- Người bệnh bám tay lành vào thành cầu thang đồng thời bước chân đau xuống trước, sau đó đến chân lành bước xuống cùng bậc

- Người bệnh tiếp tục thực hiện xuống các bậc tiếp theo

- Người bệnh xoay người ngồi vào ghế

- Dặn dò người bệnh, thu dọn dụng cụ

6.2. Tập lên xuống cầu thang cho người bệnh liệt nửa người, chấn thương sọ não, Parkison

a) Lên cầu thang

- Kỹ thuật y đứng phía sau người bệnh

- Kỹ thuật y hướng dẫn người bệnh chuyển từ ngồi sang đứng

- Người bệnh bám tay lành vào thành cầu thang đồng thời bước chân lành lên trước, sau đó đến chân liệt bước lên cùng bậc chân lành

- Người bệnh tiếp tục thực hiện lên các bậc tiếp theo

b) Xuống cầu thang

- Kỹ thuật y đứng phía trước người bệnh

- Người bệnh bám tay lành vào thành cầu thang đồng thời bước chân liệt xuống trước, sau đó đến chân lành bước xuống cùng bậc chân liệt

- Người bệnh tiếp tục thực hiện xuống các bậc tiếp theo

- Người bệnh xoay người ngồi vào ghế

- Dặn dò người bệnh, thu dọn dụng cụ

6.3. Tập lên xuống cầu thang với nạng cho người bệnh yếu hai chân

a) Lên cầu thang

- Kỹ thuật y đứng phía dưới người bệnh

- Hướng dẫn người bệnh chuyển từ ngồi sang đứng (2 nạng đặt phía trước)

- Nếu người bệnh thăng bằng đứng tốt, kỹ thuật y chuyển nạng sang hai bên

- Di chuyển với nạng băng cách đi đu đưa đến gần cầu thang

- Người bệnh sử dụng hai nạng như một. Một tay chống nạng, một tay chống ở lan can

- Đu chân lên trước rồi đến hai nạng lên cùng bậc với hai chân

- Người bệnh đi tiếp lên các bậc thang

b) Xuống cầu thang

- Kỹ thuật y đứng phía trước người bệnh

- Người bệnh sử dụng hai nạng như một. Một tay chống nạng, một tay chống ở lan can

- Đưa nạng xuống trước rồi đu hai chân xuống sau cùng bậc với nạng

- Người bệnh đi tiếp xuống cầu thang

- Đi đu đưa đến gần ghế và ngồi xuống

- Người bệnh làm kỹ thuật y sửa sai.

- Dặn dò người bệnh, thu dọn dụng cụ

6.4. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Trong quá trình tập luyện cần theo dõi tránh tập quá sức
- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh.
- Chú ý xử trí các tai biến trong khi tập cũng như sau khi tập:
- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.
- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.
- Ngã khi tập: Chú ý cẩn thận, tránh ngã.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

29 TẬP ĐI TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH KHÁC NHAU (DỐC SỎI, GỒ GHỀ..)

1. ĐẠI CƯƠNG

Tập di chuyển trên các địa hình (dốc hoặc rải sỏi hoặc đường gồ ghề…) là một bài tập chức năng quan trọng, giúp cải thiện và nâng cao chức năng đi lại của người bệnh. Bài tập này đặc biệt có ích cho những người bệnh có khó khăn trong di chuyển và những người bệnh yếu hoặc liệt. Bài tập này giúp tạo thuận cho người bệnh tái hội nhập xã hội khi ra viện. Tập di chuyển trên các địa hình có thể kết hợp với các dụng cụ trợ giúp (ví dụ: nạng, gậy….)

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người, tổn thương tủy sống không hoàn toàn

- Người bệnh yếu hai chân

- Người bệnh khó khăn trong di chuyển như đau thần kinh tọa, đau hoặc chèn ép dây thần kinh, sau gãy xương chi dưới

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thể trạng quá yếu, đứng chưa vững

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có nguy cơ té ngã

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Nạng

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Ghế ngồi

- Địa hình (dốc hoặc rải sỏi hoặc đường gồ ghề…)

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Giải thích và hướng dẫn cách tập cho người bệnh

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng, khu vực thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Tập di chuyển lên xuống dốc, đường gồ ghề cho người bệnh liệt nửa người

a) Lên dốc

- Tư thế ban đầu người bệnh: ngồi trên ghế

- Tư thế kỹ thuật y: đứng phía sau người bệnh

- Kỹ thuật y hướng dẫn người bệnh chuyển từ ngồi sang đứng

- Người bệnh di chuyển đồng thời bước chân lành lên trước, sau đó đến chân liệt

- Người bệnh tiếp tục thực hiện khi lên hết dốc

b) Xuống dốc

- Tư thế kỹ thuật y: đứng phía trước người bệnh

- Người bệnh di chuyển đồng thời bước chân liệt xuống trước, sau đó đến chân lành

- Người bệnh tiếp tục thực hiện xuống cho tới khi hết dốc

- Người bệnh xoay người ngồi vào ghế

- Dặn dò người bệnh, thu dọn dụng cụ

6.2. Tập di chuyển lên xuống dốc, đường gồ ghề với nạng cho người bệnh yếu hai chân

a) Kỹ thuật y làm mẫu

b) Lên dốc

- Kỹ thuật y đứng phía dưới người bệnh

- Hướng dẫn người bệnh từ ngồi sang đứng (2 nạng đặt phía trước)

- Người bệnh giữ thăng bằng đứng tốt, kỹ thuật y chuyển nạng sang hai bên

- Di chuyển với nạng cách đi đu đưa đến gần dốc

- Người bệnh sử dụng hai nạng như một. Một tay chống nạng, một tay bám vào người nhà.

- Người bệnh đu chân lên trước rồi đến hai nạng

- Tiếp tục đi tiếp lên hết dốc

c) Xuống dốc

- Kỹ thuật y đứng phía trước người bệnh

- Người bệnh sử dụng hai nạng như một. Một tay chống nạng, một tay bám vào người nhà.

- Người bệnh đưa nạng xuống trước rồi đu hai chân xuống sau

- Người bệnh đi tiếp xuống cho tới hết dốc.

- Đi đu đưa đến gần ghế và ngồi xuống

- Người bệnh làm, kỹ thuật y sửa sai.

- Dặn dò người bệnh, thu dọn dụng cụ

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Trong quá trình tập luyện cần theo dõi tránh tập quá sức

- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh.

- Chú ý xử trí các tai biến trong khi tập cũng như sau khi tập:

+ Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.

+ Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

+ Ngã khi tập: Chú ý cẩn thận, tránh ngã.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí

theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

30 TẬP VẬN ĐỘNG THỤ ĐỘNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tập thụ động là hình thức tập được thực hiện bởi lực tác động bên ngoài do người tập hoặc các dụng cụ trợ giúp. Vận động thụ động nghĩa là phần cơ thể được vận động không có sự tham gia làm động tác vận động co cơ chủ động của người bệnh.

- Kỹ thuật này được làm khi người bệnh không tự thực hiện được động tác vận động của mình.

2. CHỈ ĐỊNH

Khi người bệnh không tự làm được động tác vận động.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Khi có nguy cơ biến chứng do vận động thụ động gây ra:

- Gãy xương, can xương độ I hoặc II

- Các chấn thương mới (1-2 ngày đầu)

- Viêm khớp nhiễm khuẩn, tràn máu, tràn dịch khớp tại vùng điều trị

- Các vết thương phần mềm quanh khớp chưa liền sẹo

4. THẬN TRỌNG

- Nguy cơ gãy xương, trật khớp

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Gậy, ròng rọc, nẹp, túi cát

- Ga trải giường

- Gối kê

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường tập, bàn tập

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-30 phút (ước tính 0,25-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Tư thế người bệnh thoải mái phù hợp với khớp cần tập.

- Không dùng lực bắt khớp cần tập vận động.

- Người làm kỹ thuật thực hiện vận động theo mẫu, theo tầm vận động bình thường của khớp, đoạn chi hoặc phần cơ thể đó.

- Thời gian tập 15-30 phút, 1- 2 lần/ ngày, tùy theo tình trạng thực tế của người bệnh.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Trong khi tập

- Phản ứng của người bệnh: khó chịu, đau.

- Các dấu hiệu chức năng sống: mạch, huyết áp, nhịp thở.

- Các thay đổi bất thường: nhiệt độ, màu sắc đoạn chi, tầm vận động, chất lượng vận động

- Đau: không tập vận động vượt quá tầm vận động bình thường của khớp hoặc chi đó.

- Hạ huyết áp, ngừng tim, ngừng thở, gãy xương, trật khớp: ngừng tập và xử trí cấp cứu ngay

Sau khi tập

- Các dấu hiệu sống: mạch, huyết áp, nhịp thở, tình trạng toàn thân chung.

- Khó chịu, đau kéo dài quá 3 giờ coi như tập quá mức.

- Nhiệt độ, màu sắc da, tầm vận động, chất lượng vận động của đoạn chi cần tập.

- xử trí phù hợp với tai biến xảy ra

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu và cộng sự, 2019, “Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng”, NXB Y học.

31 TẬP VẬN ĐỘNG CÓ TRỢ GIÚP (TẬP VẬN ĐỘNG VỚI CÁC DỤNG CỤ TRỢ GIÚP)

1. ĐẠI CƯƠNG

Vận động có trợ giúp là loại vận động chủ động do chính người bệnh thực hiện cùng với sự hỗ trợ của người khác hoặc các dụng cụ trợ giúp tập luyện để cho người bệnh hoàn thiện được động tác vận động.

2. CHỈ ĐỊNH

Trong mọi trường hợp người bệnh chưa tự thực hiện được hết tầm vận động của khớp, một phần động tác vận động của mình.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương mới

- Viêm khớp nhiễm khuẩn, khớp có tổn thương lao hoạt động, tràn máu, tràn dịch khớp

- Chấn thương mới (1-2 ngày đầu), bong gân, trật khớp chưa được nắn chỉnh.

4. THẬN TRỌNG:

Người bệnh không có khả năng hợp tác

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Các phương tiện cần thiết hỗ trợ thích hợp cho vận động trợ giúp.

- Ga trải giường

- Gối kê

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế :

- Giường tập

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước

khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra

- Người bệnh ở tư thế thuận lợi để thực hiện kỹ thuật.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa

- Chẩn đoán bệnh, chẩn đoán chức năng, phát hiện đánh giá và theo dõi kết quả tập.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Yêu cầu người bệnh vận động chủ động phần cơ thể cần vận động như tự thực hiện phần vận động chân, tay hoặc phần cơ thể cần phục hồi chức năng mà tự họ làm được.

-Người điều trị trợ giúp để người bệnh thực hiện được tối đa tầm vận động của khớp phần động tác mà họ không tự làm được. Có thể sử dụng các dụng cụ phục hồi chức năng trợ giúp vận động của người bệnh.

- Mỗi ngày tập 1 đến 2 lần.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Trong khi tập

- Xem người bệnh có đau, khó chịu.

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở và tình trạng toàn thân.

- Nếu người bệnh bị đau tăng thì ngừng tập và theo dõi thêm.

Sau khi tập

- Người bệnh có đau và khi đau kéo dài trên 3 giờ sau tập là tập quá mức.

- Theo dõi tiến triển của tầm vận động khớp.

- Nếu đau kéo dài và tình trạng toàn thân người bệnh có biểu hiện bất thường nếu do tập quá mức, phải xử trí tai biến và giảm cường độ tập các lần sau cho phù hợp thì ngừng tập và xử trí tai biến đó.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

32 TẬP VẬN ĐỘNG CHỦ ĐỘNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Là động tác vận động do chính người bệnh thực hiện mà không cần có sự trợ giúp. Đây là phương pháp phổ biến chủ động và có hiệu quả nhất, nhằm mục đích duy trì và tăng tầm vận động của khớp, tăng sức mạnh của cơ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đã tự thực hiện được vận động.
- Kết quả thử cơ từ bậc 3 trở lên, cần làm tăng sức mạnh của cơ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp.
- Khi vận động khớp sẽ làm tổn thương phần khác của cơ thể.
- Ngay sau phẫu thuật khớp, gân, cơ, dây chằng hoặc vá da ngang qua khớp.
- Gãy xương, trật khớp chưa xử trí.

4. THẬN TRỌNG

- Tình trạng tim mạch không ổn định

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Gậy, ròng rọc, túi cát, dây cao su, tạ tay.
- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn
- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, thời gian, mức độ tập luyện ...
- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Lượng giá người bệnh để xác định loại tập vận động cần áp dụng.

- Giải thích và hướng dẫn cách tập cho người bệnh

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Phiếu thử cơ bằng tay, phiếu theo dõi kết quả tập.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Người bệnh: tư thế thoải mái, phù hợp với mục đích, kỹ thuật và các phần của cơ thể cần tập, cho phép vận động các khớp, chi trong tầm vận động bình thường. Động viên người bệnh chủ động vận động hết tầm vận động.

- Người hướng dẫn tập: tư thế thoải mái thuận tiện cho các thao tác, làm động tác mẫu hướng dẫn người bệnh tập.

- Kỹ thuật: tập vận động theo các mẫu và tầm vận động bình thường của khớp, chi, phần cơ thể.

- Mỗi động tác lặp lại nhiều lần tùy theo khả năng người bệnh. Thời gian tập và mức độ vận động tăng dần, bắt đầu từ 5 đến 10 vận động. Vận động hết tầm là vận động bình thường cho phép. Mỗi ngày tập 1 đến 2 lần.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Trong khi tập:

- Chất lượng của vận động, phản ứng của người bệnh, mạch, huyết áp, nhịp thở.

- Đau: không vận động quá tầm vận động cho phép của khớp hoặc phần cơ thể cần tập.

- Gãy xương, trật khớp: ngừng tập, xử trí gãy xương, trật khớp.

- Hạ huyết áp, ngừng tim, ngừng thở: ngừng tập, cấp cứu hạ huyết áp, ngừng tim, ngừng thở.

Sau khi tập:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, chất lượng vận động và đáp ứng đau trong và sau tập.

- Đau tăng hoặc kéo dài sau tập: giảm hoặc ngừng tập, đánh giá và báo bác sĩ điều chỉnh. Đau cấp, sưng, biến dạng hoặc bất thường thần kinh mạch máu phải xử trí ngay.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

33 TẬP VẬN ĐỘNG TỰ DO TỨ CHI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Vận động tự do tứ chi là phương pháp tập mà lực tạo ra cử động do chính bởi lực cơ của người bệnh mà không có bất kỳ một ngoại lực nào hỗ trợ hay cản trở cử động, ngoại trừ trọng lực. Vận động tự do là bước tăng tiến từ giai đoạn tập chủ động có trợ giúp tới giai đoạn tập mà sự trợ giúp không còn cần thiết nữa.

- **Ưu điểm:**

Phương pháp này giúp cho người bệnh có thể tự tập bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu mà họ thích và thấy thuận tiện một khi họ đã hiểu rõ mục đích và nắm vững kỹ thuật thực hiện bài tập.

- **Nhược điểm:**

Người điều trị đôi khi không kiểm soát được sự hoạt động của nhóm cơ cần tập. Trong trường hợp lực cơ không cân bằng, người bệnh thường dùng các mẫu cử động thay thế cho các mẫu cử động bình thường nếu họ không nắm vững kỹ thuật tập.

2. CHỈ ĐỊNH

2.1. Tạo sự thư giãn

Những cử động tự do tứ chi nhịp nhàng giúp cho những cơ bị tăng trương lực được thư giãn, từ đó người bệnh có thể thực hiện cử động có chủ ý dễ dàng và hiệu quả hơn. Khi tập mạnh một nhóm cơ cá biệt sẽ tạo được sự thư giãn tại nhóm cơ đối vận. Sự co và dãn nghỉ xen kẽ nhau ở nhóm cơ đối vận sẽ làm giảm co cứng và phục hồi tình trạng thư giãn bình thường của cơ đối vận nhanh hơn.

2.2. Tăng tầm vận động khớp

Khi tầm vận động khớp bị hạn chế, những cử động tự do tứ chi nhịp nhàng phối hợp với lực tác động vào tầm hoạt động khớp bị giới hạn sẽ làm tăng thêm tầm vận động khớp.

2.3. Tăng lực cơ và sự bền bỉ của cơ

Lực cơ và sự bền bỉ của cơ được duy trì hay gia tăng thể hiện bằng lực căng tạo ra trong cơ. Lực căng này tùy thuộc vào: tốc độ co cơ (nhanh hay chậm hơn tốc độ vận động bình thường), thời gian tập, lực cản (trọng lực). Trong tình trạng bình thường, lực cơ có thể được duy trì bằng những hoạt động chức năng hàng ngày.

2.4. Cải thiện sự điều hợp thần kinh- cơ

Sự điều hợp thần kinh cơ sẽ được cải thiện do lặp đi lặp lại nhiều lần cử động. Lúc bắt đầu tập, người bệnh cần tập trung chú ý để thực hiện một cử động mới. Nhưng nhờ sự lặp lại cử động nhiều lần, cử động trở nên ít nhiều tự động và phát triển thành sự khéo léo.

2.5. Tăng sự tin tưởng, lạc quan

Khi thực hiện được các cử động có hiệu quả và điều hợp tốt, người bệnh sẽ tin tưởng vào khả năng điều khiển cử động của mình. Từ đó sẽ lạc quan và yên tâm

thực hiện chương trình điều trị đã được hướng dẫn.

2.6. Thay đổi tích cực trong hệ thống tuần hoàn và hô hấp

Khi tập mạnh hay tập lâu, người bệnh thở nhanh hơn và sâu hơn, tim đập nhanh hơn và mạnh hơn, nhiệt lượng phát sinh trong cơ thể nhiều hơn ảnh hưởng tốt cho hệ tim mạch và hô hấp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Sau nhồi máu cơ tim cấp, gãy xương, sai khớp chưa được nắn chỉnh cố định

- Tình trạng toàn thân nặng không cho phép tập

- Người bệnh rối loạn tri giác nhận thức, không phối hợp được với người hướng dẫn tập và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Bàn tập, đệm tập, cầu thang tập...

- Ghế ngồi

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế: không có

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Người thực hiện kỹ thuật ghi rõ trong hồ sơ bệnh án thời gian thực hiện, loại kỹ thuật vận động khớp sẽ thực hiện trên người bệnh.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Lựa chọn bài tập

Lựa chọn bài tập vận động tự do tứ chi phù hợp dựa trên vùng thân thể cần được tập luyện. Đây là loại bài tập liên quan đến nhiều khớp, nhiều cơ, những bài tập thường dùng trong thể loại này là tập trên đệm, đi bộ, chạy, lên xuống cầu thang...

6.2. Kiểm tra người bệnh

- Hướng dẫn, trình bày động tác tập để người bệnh hiểu, làm mẫu trước khi người bệnh tự thực hiện động tác. Mỗi cử động phải theo một trình tự đúng, từ vị trí khởi đầu, cử động đến hết tầm vận động của khớp, rồi lại trở về vị trí khởi đầu, thư giãn, xong lại tiếp tục lần lặp lại khác.

- Các động tác tập không quá dễ cũng không quá khó đối với khả năng thực hiện của người bệnh. Nếu có cử động thay thế là do động tác tập quá khó hoặc do người bệnh chưa đủ điều kiện để bước qua giai đoạn tập chủ động, cần phải xem lại

- Người thực hiện thường xuyên theo dõi, đảm bảo người bệnh thực hiện vận động nhịp nhàng qua suốt tầm vận động và tránh các cử động thay thế.

6.3. Thực hiện kỹ thuật

Bước 1: Chọn lựa tư thế khởi đầu thích hợp

Tư thế khởi đầu thích hợp là nền tảng cơ bản của bài tập, người thực hiện cần huấn luyện người bệnh chi tiết để đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Bước 2: Hướng dẫn người bệnh kỹ thuật tập

- Giải thích những cử động mà người bệnh cần thực hiện và mục đích của những cử động đó để người bệnh hiểu và có thể thực hiện hiệu quả bài tập.

- Sử dụng các động tác mẫu trên phần cơ thể của người thực hiện hay trên phần cơ thể bên đối diện không bị tổn thương của người bệnh.

- Sử dụng lời nói để động viên và hướng dẫn người bệnh trong suốt thời gian

tập.

- Thay đổi bài tập nếu cần để người bệnh hứng thú với chương trình tập mới và hợp tác tốt hơn.

Bước 3: Tốc độ của cử động

- Tốc độ của cử động tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu của bài tập.Trong giai đoạn hướng dẫn người bệnh, người điều trị thường cho phép cử động diễn ra với tốc độ chậm hơn để người bệnh hiểu rõ trình tự thực hiện cử động.

- Trình tự thực hiện cử động là từ vị trí khởi đầu, cử động đến hết tầm vận động, trở lại vị trí khởi đầu, thư giãn và bắt đầu lặp lại động tác.

- Khi người bệnh đã hiểu rõ trình tự bài tập, người hướng dẫn chỉ cho người bệnh biết tốc độ cần thiết của cử động để đạt được mục đích trị liệu và yêu cầu người bệnh thực hiện.

Thời gian tập: Thời gian tập tùy thuộc vào khả năng và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Cần cho người bệnh một khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa những lần tập.

6.4. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Ngày đầu tiên

Người bệnh thường cảm thấy thoải mái, các cơ được thư giãn, giảm đau.

Ngày thứ hai

- Nếu người bệnh mệt hơn, đau tăng lên, tăng nhạy cảm khớp, nên giảm bớt cường độ và thời gian tập.

- Nếu không đau, người bệnh thấy thoải mái, dễ chịu hơn, lặp lại bài tập với cường độ và thời gian như trước.

Những ngày tiếp theo

Theo dõi và tăng dần cường độ tập hoặc có thể kéo dài thời gian tập mà không làm người bệnh mệt mỏi hoặc đau tăng lên.

- Theo dõi huyết áp, chỉ số mạch an toàn trước và sau tập phòng ngừa người bệnh gắng sức quá mức gây tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp đột ngột biến, nhất là ở những người bệnh lớn tuổi, năm lâu, có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch não trước đó.

- Nếu sau tập xuất hiện mệt nhiều hoặc đau tăng, cần đánh giá và điều chỉnh chế độ tập; không chờ đủ 24 giờ mới báo bất thường.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh

ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

34 TẬP VẬN ĐỘNG CÓ KHÁNG TRỞ

1. ĐẠI CƯƠNG

Tập vận động có kháng trở là vận động chủ động trong đó sự co cơ động hay tĩnh bị kháng lại bằng một lực từ bên ngoài. Mục đích là làm tăng sức mạnh của cơ, tăng sức bền của cơ, tăng công của cơ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh cần tăng sức mạnh hoặc sức bền cơ, có khả năng vận động chủ động chống lại trọng lực và đã được lượng giá phù hợp để tập có kháng trở theo chỉ định.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Cơ lực bậc 0,1,2

- Trong bệnh lý teo cơ giả phì đại.

4. THẬN TRỌNG:

- Thận trọng trong một số trường hợp bệnh lý nội khoa, tim mạch nặng, suy hô hấp cấp tính, chấn thương chưa bình phục.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Túi cát

- Ròng rọc

- Tạ

- Dây chun

- Ga trải giường

- Gối kê

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện : mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra..., nguyên tắc kỹ thuật, kế hoạch tập, các vấn đề cần chú ý trong khi tập và theo dõi sau tập để phối hợp.

- Người bệnh ở tư thế thoải mái, phù hợp với vị trí cần tập, không làm hạn chế tầm vận động trong khi tập.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Phiếu theo dõi tiến triển và kết quả tập.

- Phiếu thử cơ bằng tay đánh giá tầm vận động của khớp để xác định sức kháng cản phù hợp.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-20 phút (ước tính 0,17-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Nguyên tắc kỹ thuật

- Lực kháng cản được đặt cố định ở đầu xa của cơ cần được làm mạnh hoặc ở điểm xa của khối cử động.

- Hướng kháng cản đối diện thẳng (vuông góc) với hướng vận động ở đầu và cuối tầm vận động lực kháng cản được sử dụng ít nhất.

- Người bệnh không được nín thở trong khi tập.

6.2. Kỹ thuật

- Tập vận động có kháng trở đẳng trương (isotonic).

- Bài tập vận động có kháng trở đẳng trường (isometric).

- Nguyên tắc chung:

+ Đúng kỹ thuật.

+ An toàn.

+ Hiệu quả.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Mạch, huyết áp, nhịp thở và các biểu hiện bất thường khác. Để xử trí kịp thời.

- Có mệt mỏi, đau kéo dài do tập quá sức phải báo cáo bác sỹ chuyên khoa để xử trí và điều chỉnh chương trình tập cho phù hợp.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

35 TẬP KÉO DÃN (TẬP KÉO GIÃN)

1. ĐẠI CƯƠNG

Kéo dãn là một kỹ thuật được sử dụng để kéo dài cấu trúc mô mềm bị co ngắn do giảm hay mất tính mềm dẻo, tính đàn hồi, làm gia tăng tầm vận động khớp. Có hai phương pháp để kéo dài các tổ chức co được (cơ) và tổ chức không co được (tổ chức liên kết), đó là kéo dãn thụ động và tự kéo dãn.

- **Kéo giãn thụ động:**

Là phương pháp có thể tác động kéo dài cả hai tổ chức co được và không co được.

+ Kéo giãn thụ động bằng tay

Sử dụng lực ngoại lai của người điều trị để kiểm soát hướng đi, tốc độ, cường độ, thời gian kéo dãn đối với các tổ chức mô mềm bị co rút làm hạn chế tầm vận động khớp. Kéo dãn thụ động bằng tay là phương pháp kéo dãn có thời gian ngắn, kết quả đạt được về tầm vận động là nhất thời.

+ Kéo giãn thụ động bằng cơ học dụng cụ

Kỹ thuật này phải sử dụng các loại dụng cụ bằng cơ học để cung cấp lực kéo dãn.

- Tự kéo giãn:

Tự kéo dãn là kỹ thuật mà người bệnh tự thực hiện để kéo dãn một cách thụ động những cơ co rút của chính họ bằng cách sử dụng trọng lượng cơ thể như lực để kéo dãn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tầm vận động khớp bị hạn chế do co rút, dính khớp và hình thành sẹo tổ chức, dãn đến các cơ, tổ chức liên kết, da bị co ngắn lại.

- Phòng ngừa các biến dạng cấu trúc, co rút phần mềm do hạn chế tầm vận động khớp

- Co cứng, co rút làm giới hạn các hoạt động chức năng hàng ngày.

- Yếu cơ và các tổ chức bị căng. Các tổ chức bị căng được kéo dài trước khi tập mạnh cơ yếu thì hiệu quả tập mạnh cơ sẽ tốt hơn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khi có khối xương (cơ hóa cốt, u xương...) làm giới hạn tầm vận động khớp.

- Người bệnh sau gãy xương mới.

- Viêm cấp tính, nhiễm trùng trong khớp hoặc quanh khớp.

- Bất cứ khi nào cơ đau nhói, đau cấp tính khi cử động khớp hoặc khi kéo dài cơ.

- Khi có khối máu tụ hoặc các dấu hiệu khác của chấn thương phần mềm.

- Khi sự co cứng hoặc co ngắn của các mô mềm tạo nên sự ổn định khớp vì lúc này không thể ổn định khớp bằng độ bền vững của cấu trúc và sức mạnh cơ bình thường.

- Khi co cứng hoặc co ngắn các mô mềm là cơ sở để tăng các khả năng chức năng, đặc biệt trong trường hợp người bệnh bị liệt nặng.

- Người bệnh không hợp tác

4. THẬN TRỌNG

- Không kéo dãn bắt buộc khớp vượt quá tầm vận động bình thường của khớp một cách thụ động.

- Trường hợp gãy xương mới, ổ gãy phải được bảo vệ băng cách cố định giữa nơi gãy và khớp vận động.

- Người bệnh có hay nghi ngờ loãng xương nặng do bệnh lý, do nằm lâu, do tuổi hay do sử dụng thuốc.

- Tránh kéo dãn các mô bị phù vì nó dễ tổn thương hơn mô bình thường, khi kéo dãn dễ gây đau và làm phù tăng lên.

- Tránh kéo dãn quá mức các cơ yếu đặc biệt các cơ nâng đỡ cơ thể trong mối tương quan với trọng lực

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Đai cố định cho kéo dãn thụ động băng tay.

- Bột

- Nẹp

- Ga trải giường

- Gối kê

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế:

- Bàn tập

- Máy kéo dãn nếu sử dụng kéo dãn thụ động băng dụng cụ cơ học kéo dài.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra.., nguyên tắc kỹ thuật, kế hoạch tập, các vấn đề cần chú ý trong khi tập và theo dõi sau tập để phối hợp

- Đặt người bệnh trong tư thế thoải mái, vững chắc và ổn định để cho phép mặt phẳng cử động là tốt nhất khi quy trình kéo dãn được thực hiện.

- Xác định xem tổ chức nào hoặc khớp nào hạn chế, nguyên nhân làm giảm vận động khớp và chọn kỹ thuật kéo dãn thích hợp hoặc kết hợp vận động và kéo dãn.

- Đánh giá độ trượt của khớp, trước khi kéo dãn có thể sử dụng các kỹ thuật di động khớp để lập lại độ trượt khớp.

- Đánh giá sức mạnh cơ vùng có hạn chế vận động khớp và cân nhắc kỹ giá trị kéo dãn cho các cấu trúc bị hạn chế.

- Dùng các kỹ thuật thư giãn, nhiệt nóng đối với tổ chức mô mềm trước khi kéo dãn để làm tăng khả năng duỗi dài và giảm chấn thương.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Người thực hiện kỹ thuật ghi rõ trong hồ sơ bệnh án thời gian thực hiện, loại kỹ thuật kéo dãn sẽ thực hiện trên người bệnh.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-20 phút (ước tính 0,17-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện kỹ thuật kéo dãn bằng tay

- Cử động chi thể chậm rãi qua phạm vi tự do của điểm bị hạn chế. Hướng kéo dãn sẽ ngược lại với hướng cơ bị co ngắn.

- Cầm nắm ở đoạn gần và đoạn xa đối với khớp tạo ra cử động. Nên sử dụng những miếng đệm lót ở vùng có tổ chức dưới da ít, trên mặt xương, nơi giảm cảm giác và sử dụng mặt phẳng rộng của bàn tay khi tạo lực.

- Khi kéo dãn cơ trên nhiều khớp, kéo dãn khớp gần trước, tiếp đến là khớp xa.

- Kéo dãn cơ qua một khớp ở một thời điểm, sau đó qua toàn bộ các khớp một cách đồng thời cho đến khi độ dài tối ưu của tổ chức mô mềm đạt được.

- Lực vừa đủ để tạo sức căng ở các cấu trúc của mô mềm nhưng không quá mạnh để gây đau hay tổn thương các cấu trúc này.

- Tránh các cử động giật cục, tránh để rơi tay chân đột ngột ở cuối tầm.

- Để lực kéo dãn kéo dài ít nhất 15-30 giây, trong thời gian này sức căng ở tổ chức sẽ giảm xuống, cử động của khớp và chi sẽ xa hơn một ít.

- Giảm dần lực kéo dãn để người bệnh nghỉ một lúc, sau đó lặp lại kỹ thuật.

- Chú ý đừng cố gắng đạt được hết tầm trong một hay hai đợt điều trị. Tăng tính mềm dẻo là một quá trình chậm và từ từ.

6.2. Thực hiện kéo dãn thụ động băng dụng cụ cơ học

a) Kéo dãn thụ động băng dụng cụ cơ học thời gian dài kéo dài

Dùng dụng cụ cơ học (máy, nẹp, bột nhiều lần, ròng rọc...) cung cấp một lực bên ngoài với cường độ thấp trong một thời gian dài. Thời gian kéo dãn có thể từ 10-20 phút hoặc lâu hơn trong một vài giờ. Độ dài tổ chức được duy trì sau khi lực kéo dãn đã được loại bỏ..

b) Kéo dãn thụ động băng dụng cụ cơ học có chu kỳ

Sử dụng dụng cụ cơ học tạo ra tầm vận động tự động thực hiện theo chu kỳ và điều chỉnh được cường độ, độ dài của từng chu kỳ và số chu kỳ kéo dãn trong một phút.

6.3. Thực hiện kỹ thuật tự kéo dãn

Là bài tập linh hoạt mà người bệnh tự thực hiện. Người bệnh kéo dãn một cách thụ động những cơ co rút của chính họ bằng cách sử dụng trọng lượng cơ thể như lực để kéo dãn.

- **Lưu ý**

+ Các bài tập kéo dãn cơ cường độ cao trong thời gian ngắn thường làm chấn thương và hậu quả là làm yếu các mô mềm.

+ Bổ sung các bài tập tăng cường sức mạnh vào chương trình kéo dãn để người bệnh có thể phát triển sự cân bằng thích hợp giữa độ mềm dẻo và sức mạnh.

6.4. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Ngày đầu tiên điều trị:

- Để khớp nghỉ ngơi hoặc thư giãn tối đa để giảm đau và làm mềm khớp.

- Đau khớp hoặc nhức cơ tăng, kéo dài sau kéo giãn có thể là dấu hiệu quá tải; đánh giá sớm, không chờ đủ 24 giờ.

Ngày thứ hai:

Nếu đau tăng lên và kéo dài quá 6 giờ, chứng tỏ kéo dãn đã quá liều, cần giảm cường độ và thời gian kéo xuống. Nếu không đau hay khớp dễ chịu hơn, lặp lại kỹ thuật như ngày đầu.

Những ngày tiếp theo:

Khi tầm vận động khớp đã khá lên hoặc vận động khớp hết tầm vận động, tổ chức cơ và mô mềm đã mềm dẻo hơn, xem xét thời gian lặp lại kỹ thuật và xác định thời gian kết thúc.

- Rách mô cơ, dây chằng, bao khớp hay trật khớp có thể xảy ra nếu kéo dãn khớp quá mức hay kỹ thuật kéo dãn không đúng, giật cục. Khớp sưng to hơn, đau kéo dài hơn có thể là những dấu hiệu xấu, cần điều chỉnh lại kỹ thuật chỉ điểm.

- Dừng kéo giãn, đánh giá tổn thương và báo bác sĩ. Bất động, giảm đau và thời điểm tập lại tùy chẩn đoán; không áp dụng cố định ít nhất 21 ngày cho mọi tổn thương phần mềm.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

36 TẬP VẬN ĐỘNG TRÊN BÓNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Tập vận động trên bóng là bài tập cải thiện vận động hiệu quả cho trẻ bại não. Các bài tập vận động trên bóng bao gồm:

- Tập kiểm soát đầu cổ, thăng bằng tư thế nằm sấp, nằm ngửa, lẫy.

- Tập thăng bằng ngồi trên bóng.

- Tập đứng với bóng.

2. CHỈ ĐỊNH

Trẻ bại não, chậm phát triển tinh thần, vận động. Chưa có hoặc có khả năng kiểm soát đầu cổ, lẫy, ngồi, đứng, đi kém.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ sợ, khóc nhiều sau khi tập.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Bóng tập đường kính 80 cm.

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

- Thảm tập

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước

khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra

- Giải thích cho bệnh nhi (bệnh nhi có khả năng hiểu) và gia đình bệnh nhi biết việc mình sắp làm.

- Hướng dẫn bệnh nhi (trẻ có khả năng hiểu) những điều cần thiết.

- Đi giày hoặc nẹp (nếu có) cho người bệnh

- Để trẻ làm quen với bóng trước khi tập

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa: Chẩn đoán bệnh, chẩn đoán chức năng, phát hiện đánh giá và theo dõi kết quả tập.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Tập kiểm soát đầu cổ, thăng bằng tư thế nằm sấp, nằm ngửa, lẫy:

+ Kỹ thuật y hoặc cha/mẹ trẻ giữ bóng

+ Kỹ thuật y đặt trẻ nằm sấp trên bóng.

+ Kỹ thuật y đứng hoặc ngồi trên ghế phía sau người bệnh 2 tay cố định 2 khớp gối hoặc cố định tại hông.

+ Đưa bóng ra trước, ra sau, sang 2 bên hoặc lẫy trên bóng.

+ Mỗi lần tập 15-20 phút, ngày tập 2-3 lần.

- Tập thăng bằng ngồi trên bóng:

+ Kỹ thuật y hoặc cha/mẹ trẻ giữ bóng

+ Đặt trẻ ngồi trên bóng

+ Kỹ thuật y đứng hoặc ngồi trên ghế sau người bệnh 2 tay cố định tại hông trẻ.

+ Đu đưa bóng nhẹ nhàng ra trước, ra sau và sang 2 bên.

+ Mỗi lần tập 15-20 phút, ngày tập 2-3 lần.

- Tập đứng với bóng:

+ Kỹ thuật y hoặc cha/mẹ trẻ giữ bóng

+ Kỹ thuật y đặt trẻ đứng bám vào bóng

+ Kỹ thuật y đứng hoặc ngồi trên ghế phía sau người bệnh 2 tay cố định tại hông trẻ và đẩy bóng tiến ra trước rồi lùi lại hoặc sang 2 bên.

+ Mỗi lần tập 15-20 phút, ngày tập 2-3 lần.

- Tập đi với bóng:

+ Kỹ thuật y hoặc cha/mẹ trẻ giữ bóng

+ Kỹ thuật y đặt trẻ đứng bám vào bóng

+ Đặt trẻ đứng và đẩy bóng tiến dần về phía trước, trẻ sẽ bám theo bóng tiến về phía trước.

+ Mỗi lần tập 15-20 phút, ngày tập 2-3 lần.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Sau mỗi buổi tập, cần kiểm tra: khả năng kiểm soát đầu cổ, thăng bằng tư thế nằm sấp, nằm ngửa, lẫy, thăng bằng ngồi trên bóng, đứng với bóng.

- Trẻ bị rơi khỏi bóng nếu cố định không tốt khi tập kiểm soát đầu cổ, tập lẫy, tập ngồi

- Trẻ bị ngã khi tập đứng, đi nếu đu đưa bóng, đẩy bóng quá nhanh.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

37 TẬP VỚI THANG TƯỜNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thang tường là dụng cụ tập khớp vai, các cơ thân mình và chi trên có tác dụng giãn cơ vùng vai gáy, lồng ngực và lưng hông từ đó giúp tăng thông khí phổi, điều chỉnh tư thế ở một số bệnh lý liên quan tới thần kinh - cơ - xương.

- Trong phục hồi chức năng hô hấp: tập với thang tường là bài tập giãn cơ được tiến hành trước và sau các bài tập tăng sức mạnh và sức bền các cơ hô hấp, cơ chi trên.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau, hạn chế vận động khớp vai do nhiều nguyên nhân: viêm quanh khớp vai, chấn thương khớp vai, liệt nửa người, di chứng sau bó bột, bất động.

- Yếu các cơ thân mình, chi trên

- Các bệnh hô hấp - tim mạch: Tràn dịch, dày dính màng phổi, bệnh phổi kẽ, xẹp phổi, bệnh bụi phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, suy tim, ung thư phế quản phổi…

- Các bệnh có tổn thương thần kinh - cơ - xương: lao cột sống giai đoạn ổn định, tổn thương tuỷ sống giai đoạn ổn định, gù vẹo cột sống, biến dạng lồng ngực, đột quỵ não, sau phẫu thuật lồng ngực...

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh không có khả năng hợp tác

- Các bệnh có tổn thương xương cột sống giai đoạn cấp tính

4. THẬN TRỌNG

- Người thăng băng kém

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Thang tường

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Tư thế người bệnh phải thoải mái

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Tư thế người bệnh: đứng

- Tư thế kỹ thuật y: đứng cạnh người bệnh

- Kỹ thuật y làm mẫu, người bệnh làm theo

- Kỹ thuật y kiểm tra và điều chỉnh cho người bệnh

6.1. Tập khớp vai

- Cử động gập khớp vai: Người bệnh đứng quay mặt vào thang tường, 2 tay bám vào thang tường khuỵu gối, 2 tay bám vào thang tường đu người xuống.

- Cử động duỗi khớp vai: Người bệnh đứng xoay lưng lại 2 tay bám vào thang tường ngả người ra trước

- Cử động dạng khớp vai: Người bệnh đứng nghiêng người lại với thang tường, tay nắm vào thang rồi ngả người ra

- Cử động khép khớp vai: Người bệnh đứng đối diện với thang tường, 2 tay dạng và bám vào thang tường, ngả người về phía thang tường

6.2. Giãn cơ hô hấp

Động tác 1

- Bước 1: Đứng quay mặt vào thang tường. Hai chân mở rộng bằng vai, các ngón chân sát vào chân thang tường. Hai tay nắm vào thanh phù hợp ngang tầm vai.

- Bước 2: Hít vào từ từ bằng mũi thật tối đa kết hợp với đẩy hông ra sau và xuống

dưới đến hết khả năng, hai đầu gối thẳng sau đó giữ tư thế này một lúc để các cơ vùng vai, lưng, hông được giãn căng ra.

- Bước 3: Chúm môi thở ra từ từ bằng miệng cho thật hết, kết hợp với dùng tay kéo thang tường để cơ thể đứng thẳng trở lại vị trí ban đầu.

- Lặp lại động tác 10-20 lần.

Động tác 2:

- Bước 1: Đứng vuông góc với thang tường. Hai chân mở rộng bằng vai. Tay người bệnh cạnh thang tường nắm vào thanh ngang hông, tay kia vòng qua đầu nắm vào thanh ngay phía trên đỉnh đầu.

- Bước 2: Hít vào từ từ bằng mũi thật tối đa kết hợp với đẩy hông ra phía xa thang tường, giữ tư thế này một lúc để toàn bộ các cơ vùng vai, cơ liên sườn được giãn căng

- Bước 3: Chúm môi thở ra từ từ bằng miệng cho thật hết đồng thời từ từ đứng thẳng trở lại vị trí ban đầu.

- Tập 10 - 20 lần sau đó đổi bên.

Động tác 3:

- Bước 1: Đứng quay mặt vào thang tường. Hai chân mở rộng bằng vai. Hai tay nắm vào thanh ngang tầm vai.

- Bước 2: Hít vào từ từ bằng mũi thật tối đa kết hợp với đẩy hông xuống dưới và chếch bên trái 45° đến hết khả năng, giữ tư thế này một lúc để toàn bộ cơ vùng vai, cơ liên sườn, cơ lưng được giãn căng.

- Bước 3: Chúm môi thở ra từ từ bằng miệng cho thật hết đồng thời dùng tay kéo thang tường cho cơ thể đứng thẳng trở lại vị trí ban đầu.

- Lặp lại động tác 10-20 lần.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.

- Theo dõi không để người bệnh làm các cử động thay thế

- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh

- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

- Ngã khi tập: Chú ý cẩn thận, tránh ngã.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh

ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

38 TẬP VỚI GIÀN TREO CÁC CHI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Giàn treo là phương tiện cần thiết để nâng đỡ và trợ giúp các phần chi thể cử động chủ động, nhằm giảm tác động của trọng lực lên các cơ suy yếu khi người bệnh không đủ sức mạnh tập luyện và tự điều khiển cử động cho hết tầm vận động.

2. CHỈ ĐỊNH

- Dùng cho những người bệnh trong giai đoạn đầu của chương trình tập luyện cơ.

- Những trường hợp người bệnh vận động không đúng mẫu.

- Những trường hợp giới hạn tầm vận động của khớp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Những trường hợp đau làm ngăn cản cử động chủ động.

- Người bệnh hoàn toàn không hợp tác tập luyện.

- Khi các vị thế được lựa chọn: nằm ngửa, nằm nghiêng và ngồi là chống chỉ định.

- Trật khớp

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Các đai và dây treo nâng đỡ các chi.

+ Đai lớn phải dùng đai kép treo máng vào mỗi đầu của đai

+ Đai nhỏ chỉ cần dây treo là đủ

+ Đai nâng đỡ đầu cần hai dây treo (dây chiếc)

+ Đai nâng đỡ cổ tay bàn tay hay cổ chân - bàn chân cần dây treo.

- Móc khóa chữ S

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giàn treo và phụ kiện đi kèm

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Tư thế thoải mái và được nâng đỡ an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Lượng giá tổng quát và khả năng tập của người bệnh.

- Có chỉ định được tập luyện vận động trợ giúp

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Kỹ thuật y xác định tầm vận động khớp và sức cơ của người bệnh.

- Chọn tư thế khởi đầu sao cho người bệnh thực hiện đúng mẫu động tác mong muốn, đồng thời đảm bảo sự vững chắc và thoải mái cho người bệnh.

- Lựa chọn dụng cụ cần thiết như móc, dây treo, đai v.v...

- Buộc dụng cụ vào giàn treo.

- Buộc dụng cụ vào người bệnh: từ phần gần đến phần xa.

- Xác định điểm treo bằng cách thả cho dây rơi theo đường trọng lực.

+ Nếu nhằm mục đích thực hiện cử động, điểm treo phải nằm trên đường thẳng đứng trên trục cử động.

+ Nếu nhằm mục đích nâng đỡ, điểm treo phải nằm trên đường thẳng đứng trên trọng tâm của phần chi thể được treo

- Chỉ gắn dây treo vào đai khi đã buộc đai chính xác vào vùng cơ thể cần điều trị.

- Giải thích cho người bệnh rõ cử động mẫu mà họ phải làm

- Giữ vững chắc xương nơi có điểm bám của cơ được tập.

- Khi tháo gỡ: tháo từ xa tới gần, sau đó tháo dụng cụ trên giàn.

Kỹ thuật treo:

Khớp	Cử động	Vị thế người bệnh	Điểm treo	Nâng đỡ	Giữ vững
VAI	Gập Duỗi	Nằm nghiêng	Dưới mỏm cùng vai 2,5 cm	Cổ tay - bàn tay, khuỷu	Vai
	Dạng khép	Nằm ngửa	Mỏm cùng vai xuống 2,5cm	Cổ tay - bàn tay, khuỷu	Vai
	Xoay trong Xoay ngoài	Ngồi, khuỷu gập 0º	Mỏm cùng vai vào 2,5cm	Cổ tay - Bàn tay	Cánh tay
		Nằm nghiêng, vai dạng 0º	Dưới mỏm cùng vai 2,5cm	Cổ tay - Bàn tay	Vai
KHUỶU	Gấp Duỗi	Nằm nghiêng	Ngay tại khớp khuỷu	Cánh tay, cổ tay &bàn tay	Cánh tay
		Ngồi, vai dạng 0º	Ngay tại khớp khuỷu	Cánh tay, cổ tay & bàn tay	Cánh tay
HÁNG	Gấp Duỗi	Nằm nghiêng	- Mấu chuyển lớn lên 2,5cm - Mào chậu xuống 4 ngón tay	Gối, cổ chân & bàn chân	Chân
	Dạng khép	Nằm ngửa	Điểm giữa đường xếp háng xuống 2,5cm	Gối, cổ chân & bàn chân	Chân
GỐI	Gấp Duỗi	Nằm nghiêng	Ngay tại khớp	Đùi, cổ chân & bàn chân	Đùi

- Kết thúc kỹ thuật:

+ Dụng cụ phải được giữ trong tình trạng tốt bằng cách kiểm tra và cất ngay khi sử dụng.

+ Dùng xong treo từng dây và đai treo lên móc theo từng loại riêng biệt để tránh xoắn vặn.

+ Giữ sạch đai và dây treo bằng cách giặt thường xuyên.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Trong tất cả mọi trường hợp nên đặt 2 đầu của đai cách khoảng bằng nhau ở 2 bên phần chi thể hay thân mình để duy trì đai đúng vị thế.

- Kiểm tra các đầu móc, dây và đai treo phải chắc chắn, an toàn. Tránh xoắn vặn khi treo.

- Buộc hai đầu móc chắc chắn phòng ngừa tai nạn.

- Dây và đai treo bị đứt hay xơ rách không được sử dụng cho người bệnh.

- Phần chi thể gần cần được nâng lên trước rồi đến phần xa.

- Khi treo toàn thân: Đầu được nâng lên trước, rồi đến cánh tay - cẳng tay, đến đùi - cẳng chân rồi đến ngực và cuối cùng là chậu.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

39 TẬP VỚI RÒNG RỌC

1. ĐẠI CƯƠNG

- Ròng rọc là dụng cụ tập giúp tăng tầm vận động của khớp vai, giãn cơ vùng cổ, vai, gáy.

- Trong các bệnh hô hấp mạn tính, quá trình hô hấp thường có sự tham gia của các cơ hô hấp phụ vùng cổ, vai, gáy dẫn tới sự đau mỏi, co kéo cơ ảnh hưởng tới sự hô hấp của người bệnh.

- Trong phục hồi chức năng hô hấp: tập với ròng rọc là bài tập giãn cơ được áp dụng trước và sau các bài tập tăng sức mạnh, sức bền cơ hô hấp, cơ chi trên như tập thở với dụng cụ, tập thở có kháng trở….

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau hạn chế vận động khớp vai do nhiều nguyên nhân: Viêm quanh khớp vai, chấn thương khớp vai, liệt nửa người, di chứng sau bó bột, bất động...

- Điều chỉnh tư thế trong trường hợp gù vẹo cột sống nguyên phát hoặc thứ phát.

- Trước và sau các bài tập tăng sức mạnh, sức bền cơ hô hấp cho các bệnh hô hấp, các bệnh có yếu cơ hô hấp: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tràn dịch - dày dính màng phổi, viêm phổi kẽ, bụi phổi, ung thư phổi, nhược cơ, người bệnh trước và sau phẫu thuật lồng ngực...

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có khó khăn về nhận thức, không hiểu mệnh lệnh, không hợp tác

- Trật khớp vai

4. THẬN TRỌNG

- Liệt mềm hoàn toàn

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

- Hệ thống ròng rọc

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Tư thế người bệnh ngồi thoải mái.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Tập khớp vai

- Tư thế kỹ thuật y: Đứng bên cạnh khớp vai được treo và:

Bước 1: Tập vận động gấp duỗi khớp vai

- Tư thế người bệnh: ngồi trên ghế tựa, quay lưng lại ròng rọc, hai tay người bệnh nắm lấy hai tay cầm của ròng rọc.

+ Xác định điểm treo: ngay tại đỉnh đầu (cho dây rơi theo trọng lực).

+ Nâng đỡ: cổ tay, bàn tay.

+ Thực hiện cử động gấp - duỗi khớp vai: Dùng tay lành kéo xuống, điều này giúp tay bên bệnh được nâng lên trên đầu, kéo càng cao càng tốt cho đến khi vai duỗi tối đa.

+ Giữ 5-10 giây. Thư giãn, và lặp lại động tác: 10-20 lần

Bước 2: Tập vận động dạng, khép khớp vai

- Tư thế người bệnh: ngồi trên ghế tựa, ngồi nghiêng, bên vai bệnh sát với ròng rọc, hai tay nắm lấy hai tay cầm.

- Tư thế kỹ thuật y: Đứng bên khớp vai được treo của người bệnh

+ Xác định điểm treo: ngay tại đỉnh đầu (cho dây rơi theo trọng lực).

+ Nâng đỡ: cổ tay, bàn tay.

+ Thực hiện cử động dạng - khép khớp vai: Dùng tay lành kéo xuống, kéo tay bên bệnh được nâng lên trên đầu càng cao càng tốt.

+ Giữ 5-10 giây. Thư giãn và lặp lại động tác: 10-20 lần

Bước 3: Tập vận động xoay trong khớp vai

- Tư thế người bệnh: đứng, quay lưng vào ròng rọc. Tay lành đưa lên trên đầu, nắm lấy tay cầm. Tay bệnh đưa ra sau lưng (sao cho ngón cái chạm vào cột sống) và nắm lấy tay cầm kia

- Tư thế kỹ thuật y: Đứng bên khớp vai được treo

+ Xác định điểm treo: phía bên vai bệnh (cho dây rơi theo trọng lực).

+ Nâng đỡ: cổ tay, bàn tay.

+ Thực hiện cử động xoay trong khớp vai: Dùng tay lành kéo xuống, điều này giúp kéo tay bên bệnh được nâng lên cao ở phía sau lưng.

+ Giữ 5-10 giây. Thư giãn và lặp lại động tác: 10-20 lần

6.2. Tập giãn cơ hô hấp

Tư thế người bệnh

- Ngồi trên ghế thoải mái, lưng thẳng

- Hai chân mở rộng bằng vai

- Hai tay nắm vào hai tay nắm của ròng rọc, duỗi thẳng ra phía trước.

Kỹ thuật y:

- Làm mẫu kỹ thuật đồng thời nhấn mạnh từng bước để người bệnh hiểu

- Quan sát người bệnh thực hiện và sửa sai (nếu có)

Động tác 1:

- Bước 1: Hít vào sâu từ từ bằng mũi, đồng thời dang hai tay sang 2 bên đến hết tầm vận động.

- Bước 2: Chúm môi từ từ thở ra bằng miệng hai tay đưa về phía trước.

- Lặp lại động tác 10-20 lần.

Động tác 2:

- Bước 1: Hít vào sâu từ từ bằng mũi đồng thời đưa tay phải lên cao hết tầm tay với, tay trái hạ xuống hết theo tầm vận động.

- Bước 2: Chúm môi từ từ thở ra bằng miệng đưa tay trái lên cao hết tầm tay với, tay phải hạ xuống hết theo tầm vận động.

- Lặp lại động tác 10-20 lần.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.
- Theo dõi không để người bệnh làm các cử động thay thế
- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh
- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.
- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

40 TẬP VỚI DỤNG CỤ QUAY KHỚP VAI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Là dụng cụ tập xoay khớp vai

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau, hạn chế vận động khớp vai do nhiều nguyên nhân:

+ Viêm quanh khớp vai

+ Chấn thương khớp vai

+ Liệt nửa người

+ Di chứng sau bó bột, bất động

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có khó khăn về nhận thức, không hiểu mệnh lệnh, không hợp tác

- Trật khớp vai

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Khung quay khớp vai

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế: không có

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Giải thích và hướng dẫn cách tập cho người bệnh

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

Bước 1: Kỹ thuật y hướng dẫn làm mẫu

- Kỹ thuật y đứng bên cạnh dụng cụ tập

- Tay của vai cần tập nắm vào tay cầm của dụng cụ tập xoay

- Xoay khớp vai từ từ theo chiều kim đồng hồ

- Xoay khớp vai ngược chiều kim đồng hồ

Bước 2: Người bệnh tập, kỹ thuật y giám sát và điều chỉnh

- Người bệnh đứng, vai cần tập bên cạnh dụng cụ tập xoay.

- Tay nắm vào tay cầm của dụng cụ tập

- Xoay khớp vai theo chiều kim đồng hồ

- Xoay khớp vai ngược chiều kim đồng hồ

- Làm đúng quy trình với thời gian 3-5 phút cho mỗi chiều quay

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.

- Theo dõi không để người bệnh làm các cử động thay thế

- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh

- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

41 TẬP VỚI DỤNG CỤ CHÈO THUYỀN

1. ĐẠI CƯƠNG

- "Chèo thuyền" là dụng cụ để tập mạnh cơ và các bài tập cho tim mạch. Dụng cụ chèo thuyền giúp làm mạnh tất cả các cơ thân mình, chi trên và chi dưới.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tập mạnh cơ thân mình, các cơ chi trên và chi dưới.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Cứng khớp, hạn chế tầm vận động các khớp chi trên và chi dưới

- Trật khớp vai

4. THẬN TRỌNG

- Cơn tăng huyết áp, suy tim

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Dụng cụ (máy) chèo thuyền

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Kiểm tra huyết áp trước khi tập

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-15 phút (ước tính 0,17-0,25 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Tư thế người bệnh: ngồi lên ghế của máy (dụng cụ) chèo thuyền

- Tư thế kỹ thuật y: đứng cạnh người bệnh

Bước 1 : Tư thế bắt đầu

- Hướng dẫn người bệnh ngồi trên ghế của dụng cụ chèo thuyền, đặt hai chân lên chỗ đặt chân và 2 bàn tay nắm chặt ở vị trí tay cầm.

- Duỗi cánh tay thẳng hướng về bánh quay, giữ cổ tay duỗi.

- Trượt ghế ngồi ra trước cho đến khi khung chậu vuông góc

- Khớp háng hơi nghiêng ra trước

Bước 2: Tư thế chèo thuyền

- Bắt đầu bằng cách duỗi chân và đạp vào chỗ để chân

- Giữ thân mình thẳng, tay giữ thẳng và lưng vững để truyền lực vào tay cầm

- Khi gối duỗi thẳng, từ từ gấp tay và ngả phía trên thân mình ra sau.. Kết thúc với tư thế hơi nghiêng ra sau.

Bước 3: Tư thế kết thúc

- Gấp khuỷu tay và kéo tay cầm vào bụng

- Duỗi chân

- Khớp háng hơi nghiêng ra sau.

Bước 4: Trở lại tư thế ban đầu

- Duỗi tay bằng cách duỗi thẳng khuỷu và đưa tay cầm hướng về bánh quay

- Nghiêng nửa trên thân mình về phía trước tại khớp háng đi theo tay.

- Từ từ gấp gối và trượt ghế ngồi ra trước để về vị trí ban đầu.

- Chuẩn bị cho lần tập tiếp theo

- Thời gian tập: Những buổi đầu không vượt quá 10 phút, sau đó tăng dần thời gian tập tùy theo người bệnh

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.

- Theo dõi huyết áp.

- Theo dõi các sai lầm thường gặp khi tập với dụng cụ chèo thuyền:

+ Ngả ra sau quá mức ở tư thế kết thúc

+ Ngả người ra trước quá mức ở tư thế khởi đầu

+ Giật mạnh vào tay cầm

+ Bắt đầu chèo thuyền bằng cột sống thắt lưng thay vì bằng chân

- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

42 TẬP THĂNG BẰNG VỚI BÀN BẬP BÊNH

1. ĐẠI CƯƠNG

- Bàn bập bênh là một trong những dụng cụ tập thăng bằng cho người bệnh.

- Tập với bàn bập bênh là bài tập thăng bằng ở mức độ khó.

- Với bàn bập bênh có thể tập thăng bằng cho người bệnh ở tư thế ngồi hoặc đứng.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh chuẩn bị quay trở lại công việc hay những hoạt động kiểm soát các cử động điều hợp nhanh hay chậm trong các bệnh:

- Liệt nửa người

- Liệt hai chân

- Parkinson

- Viêm đa dây đa rễ thần kinh

- Xơ cứng rải rác

- Xơ cứng cột bên teo cơ

- Bại não

- Chậm phát triển vận động tinh thần

- Yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật chi dưới, sau thở máy kéo dài, ghép phổi…

- Đoạn chi, lắp chân giả các loại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh không hợp tác

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

5. CHUẨN BỊ

Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

Thuốc

5.1. Người thực hiện: kỹ thuật viên PHCN có phạm vi hành nghề, năng lực và phân công phù hợp; bác sĩ chỉ định, đánh giá. Bố trí thêm người hỗ trợ theo nguy cơ ngã.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này.

5.3. Vật tư:

- Bàn bập bênh thăng bằng ngồi với kích thước bằng gỗ có chiều dài 100cm và rộng 40cm, cao 40cm, chân đế được uốn cong trông giống như bập bênh.

- Bàn bập bênh thăng bằng đứng với kích thước bằng gỗ có chiều dài 200cm và rộng 60cm, cao 5cm, đáy cong ở giữa trông giống như bập bênh.

- Máy đo huyết áp

- Ghế ngồi

- Găng tay

- Mũ giấy

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Kiểm tra huyết áp, chỉ số mạch an toàn, tình trạng sức khỏe tổng quát đối với những người bệnh nằm lâu tại giường.

- Giải thích mục đích bài tập và quy trình tập cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

- Đặt người bệnh trong tư thế thoải mái, vững chắc và ổn định để cho phép người bệnh thực hiện được bài tập tốt nhất khi thực hiện quy trình.

- Dùng các kỹ thuật thư giãn trước khi tập ngồi thăng bằng tĩnh và động nếu người bệnh co co cứng cơ ở các chi hay thân mình

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Lựa chọn bài tập và kỹ thuật phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh để có thể đạt được mục đích tốt nhất.

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-15 phút (ước tính 0,17-0,25 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Tập thăng bằng ngồi:

+ Người bệnh ngồi, người điều trị đứng phía sau hay phía trước người bệnh, giữ khung chậu, yêu cầu người bệnh dang hai tay ra, dồn trọng lượng sang từng bên hông hoặc thay đổi tư thế tay và đầu ở các hướng trong không gian. Một khi phản ứng thăng bằng của người bệnh được tạo thuận thì nhiều cử động chi thể sẽ được thực hiện. Những cử động này liên quan đến mức độ cố gắng của người bệnh để duy trì thăng bằng.

+ Nếu phản ứng thăng bằng thất bại thì phản ứng duỗi bảo vệ của cánh tay là một trong những phản ứng quan trọng nhất cần được tập để người bệnh chống đỡ khi mất thăng bằng.

- Tập thăng bằng đứng:

+ Người bệnh đứng trên bàn bập bênh, chân để rộng bằng vai. Người điều trị đứng phía sau hay phía trước người bệnh; giữ người bệnh ở khung chậu, khớp vai, khớp gối hay đầu.

+ Yêu cầu người bệnh nâng hai tay ra phía trước, dồn trọng lượng sang từng bên chân hoặc thay đổi tư thế đầu ở các hướng trong không gian. Một khi phản ứng thăng bằng của người bệnh được tạo thuận thì nhiều cử động chi thể sẽ được thực hiện. Những cử động này liên quan đến mức độ cố gắng của người bệnh để duy trì thăng bằng.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Kiểm tra tình trạng huyết áp, chỉ số mạch an toàn đối với những người bệnh nằm lâu trước đó. Nếu người bệnh chóng mặt, mệt thì nên ngừng tập và để người bệnh nằm nghỉ.

- Tăng huyết áp: Nghỉ ngơi, thuốc hạ áp

- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

- Ngã khi cử động tay, thân và đầu để tập thăng bằng động đặc biệt ở những người bệnh tai biến mạch não, chấn thương sọ não hay liệt hai chân do tổn thương tủy. Người điều trị cần đứng gần người bệnh ở phía trước hay bên liệt để hỗ trợ người bệnh kịp thời khi cần.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

43 TẬP VỚI MÁY TẬP THĂNG BẰNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Thăng bằng là phản ứng của cơ thể nhằm duy trì tư thế trong các hoạt động hàng ngày. Tập với máy tập thăng bằng là người bệnh thực hiện các động tác tập trên máy nhằm cải thiện khả năng kiểm soát tư thế và phối hợp thăng bằng vận động.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương sọ não.
- Đột quỵ não.
- Parkinson.
- Tổn thương tủy sống.
- Xơ cứng rải rác.
- Một số bệnh lý cơ xương khớp có ảnh hưởng chức năng thăng bằng.
- Người bệnh thăng bằng kém

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh không hợp tác

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Máy đo huyết áp
- Máy đo SpO_2
- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn
- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Máy tập thăng bằng: các chương trình tập luyện.

- Tay vịn.

- Máy tính và màn hình hiển thị bài tập.

5.5. Người bệnh

- Giải thích mục đích bài tập và quy trình tập cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

- Kiểm tra huyết áp, chỉ số mạch an toàn, tình trạng sức khỏe tổng quát đối với những người bệnh nằm lâu tại giường.

- Người bệnh đứng đúng vị trí trên máy tập, tư thế thoải mái, có thể vịn tay hoặc không trong khi thực hiện bài tập.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

Bước 1: Lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh để có thể đạt được mục đích tốt nhất.

Bước 2: Tiến hành tập

- Người bệnh đứng thẳng, hai bàn chân đặt đúng vị trí trên bề mặt cảm biến của máy tập, giữ đầu thăng bằng trên hai vai, hai tay thả lỏng hai bên thân hoặc có thể nắm vào tay vịn trong những lần tập đầu để giữ thăng bằng.

- Người điều trị đứng ở phía trước hoặc phía sau người bệnh để hỗ trợ khi cần thiết (sai tư thế hoặc có thể bị ngã). Có thể giữ nhẹ ở khung chậu hoặc khớp vai của người bệnh để người bệnh cảm thấy yên tâm và giữ được tư thế đúng.

- Người bệnh mắt nhìn thẳng vào màn hình trước mặt để quan sát hình ảnh và tình huống diễn biến của bài tập, thực hiện bài tập bằng cách lần lượt chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia tùy theo tình huống diễn biến của bài tập trên màn hình trong khi vẫn giữ ổn định tư thế đứng. Thực hiện bài tập theo tốc độ và thời gian quy định.

Bước 3: Kết thúc tập

- Kết thúc bài tập lưu dữ liệu tập của người bệnh vào máy tính.

- Tắt máy và bảo quản theo chế độ quy định.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Kiểm tra tình trạng huyết áp, chỉ số mạch an toàn đối với những người bệnh năm lâu trước đó. Nếu người bệnh chóng mặt, mệt mỏi thì nên ngừng tập và để người bệnh về nghỉ.

- Ngã có thể xảy ra trong quá trình tập luyện. Người điều trị cần đứng gần người bệnh ở một bên hay phía trước hoặc phía sau để hỗ trợ người bệnh khi cần.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

44 TẬP VỚI GHẾ TẬP MẠNH CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Là kỹ thuật dùng để người bệnh tập mạnh cơ tứ đầu đùi và tam đầu đùi. Ghế đặt cố định, có thể điều chỉnh được lực kháng trở tùy theo khả năng và sự tiến triển của người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

Tập mạnh cơ tứ đầu đùi, tam đầu đùi có bậc thử cơ từ bậc 3 trở lên trong một số bệnh thần kinh trung ương, ngoại biên và bệnh lý hô hấp, tim mạch mạn tính:

- Đột quỵ não, suy tim độ 1, 2
- Chấn thương sọ não
- Chấn thương tủy sống
- Tổn thương thần kinh ngoại biên
- Trước khi lắp chân giả
- Sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
- Các bệnh lý cơ xương khớp
- Bệnh hô hấp, tim mạch
- Trước và sau phẫu thuật lồng ngực

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhồi máu cơ tim cấp
- Cơn đau thắt ngực không ổn định

4. THẬN TRỌNG

- Trong cơn tăng huyết áp
- Suy tim độ 3, 4

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Ghế tập cơ tứ đầu đùi.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Kiểm tra huyết áp trước khi tập

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Đặt người bệnh ngồi ngay ngắn trên ghế tập, giữ thân mình thẳng, hai vai cân đối, để chân định tập vào đúng vị trí (tập lần lượt từng chân đối với những trường hợp cần tập 2 chân).

- Kỹ thuật y điều chỉnh kháng lực phù hợp với người bệnh.

- Tiến hành tập gấp duỗi gối 10-20 lần, nghỉ 2-3 phút sau đó tiếp tục tập cho đến khi hết thời gian.

- Thời gian tập từ 15-20 phút tùy theo tình trạng sức khỏe cũng như khả năng của người bệnh.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.

- Theo dõi huyết áp.

- Theo dõi không để người bệnh làm các cử động thay thế, như gập háng, nhấc mông….

- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh để tăng hoặc giảm lực kháng trở.

- Tăng huyết áp: Nghỉ ngơi, thuốc hạ áp

- Đau cơ: thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

45 TẬP VỚI XE ĐẠP TẬP

1. ĐẠI CƯƠNG

Xe đạp tập là dụng cụ tập luyện trong phục hồi chức năng để làm tăng sức mạnh của cơ cũng như tầm vận động các khớp chi dưới, tăng khả năng giữ thăng bằng của người bệnh. Thiết bị đặt cố định, có cấu trúc như xe đạp, có thể điều chỉnh được lực kháng trở tùy theo khả năng và sự tiến triển của người bệnh. Một số xe đạp tập có cấu tạo để tập cả chi trên.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đột quỵ não, suy tim độ 1, 2
- Chấn thương sọ não
- Chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống
- Sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
- Các bệnh lý cơ xương khớp
- Các bệnh hô hấp, tim mạch
- Trước và sau phẫu thuật lồng ngực

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhồi máu cơ tim cấp.
- Cơn đau thắt ngực không ổn định

4. THẬN TRỌNG

- Trong cơn tăng huyết áp
- Suy tim độ 3, 4

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Máy đo SpO_2
- Ghế ngồi
- Mũ giấy
- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Xe đạp tập có gắn lực kế

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Kiểm tra huyết áp trước khi tập

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Giúp người bệnh ngồi lên yên xe, hai tay cầm vào tay nắm ghi đông của xe (với người bệnh liệt chi trên dùng băng dán cố định tay người bệnh vào ghi đông).

- Thực hiện động tác như đạp xe, thời gian từ 20-30 phút tùy theo tình trạng sức khỏe, khả năng của người bệnh. Trong thời gian tập có thể nghỉ 1-2 lần, mỗi lần 2-3 phút

- Kỹ thuật y theo dõi cử động của người bệnh, tình trạng toàn thân, mức độ khó thở, SpO2, mạch, kịp thời phát hiện các tai biến xảy ra để xử trí.

- Trường hợp người bệnh nặng (như mất thăng bằng) người chăm sóc có thể đứng bên cạnh hỗ trợ.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.

- Theo dõi huyết áp.

- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh để tăng hoặc giảm lực kháng trở.

- Tăng huyết áp hoặc triệu chứng bất thường: dừng tập, cho nghỉ ở tư thế an toàn, đo lại và báo bác sĩ; thuốc chỉ dùng theo y lệnh.

- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế, 2019, “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng” (đợt 3), ban hành theo Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

46 TẬP VỚI BÀN NGHIÊNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Bàn nghiêng được sử dụng như một phương tiện trợ giúp cho người bệnh thực hiện các thay đổi tư thế từ nằm sang đứng thẳng. Kỹ thuật này được áp dụng rộng rãi không chỉ trong phục hồi chức năng mà còn trong nhiều chuyên khoa khác nhau với mục đích cung cấp cho người bệnh bài tập chịu trọng lượng giai đoạn sớm trước khi có thể tự mình đứng lên, đặc biệt trong những bệnh lý thần kinh, cơ xương khớp. Đồng thời bàn nghiêng còn được sử dụng trong phòng và điều trị hạ huyết áp tư thế (huyết áp hạ đột ngột khi chuyển từ tư thế nằm sang ngồi).

- Tác dụng sinh lý

+ Phòng ngừa và điều trị co cứng/ co rút các khớp háng, gối, cổ chân.

+ Tăng sức mạnh cơ chi dưới.

+ Phòng chống loãng xương thông qua các bài tập chịu trọng lực.

+ Phòng chống huyết khối tĩnh mạch, ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

+ Tăng cường cảm giác, cảm thụ bản thể.

+ Chức năng nhận thức được cải thiện khi người bệnh ở tư thế đứng thẳng.

+ Tăng thông khí, cải thiện chức năng hô hấp.

+ Tạo thuận lợi cho người bệnh thực hiện các bài tập vận động vùng đai vai, hai tay và tập hô hấp.

+ Nếu đặt người bệnh ở tư thế nằm sấp hoặc đầu dốc xuống trên bàn nghiêng, có tác dụng trợ giúp thực hiện các kỹ thuật dãn lưu tư thế và kéo dãn cơ vùng cột sống.

+ Phòng tránh loét do giảm áp lực tì đè lên vùng da nếu người bệnh phải ngồi lâu.

+ Phòng và điều trị tình trạng hạ huyết áp tư thế. Kỹ thuật này giúp người bệnh thay đổi tư thế từ từ, do đó các mạch máu co và dãn nở đáp ứng một cách thích hợp với sự thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi hoặc đứng dậy.

+ Tạo thuận cho hoạt động bài xuất nước tiểu của thận, bàng quang.

2. CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý thần kinh: các bệnh lý gây liệt vận động như liệt nửa người, liệt tủy, viêm đa rễ, dây thần kinh, xơ cứng rải rác…hoặc các bệnh lý gây rối loạn thăng bằng.

- Bệnh lý cơ xương khớp: co cứng hoặc co rút cơ khớp ở chi dưới, gãy xương đã bó bột hoặc phẫu thuật…

- Bệnh lý hô hấp: viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính…

- Bệnh lý tim mạch: hạ huyết áp tư thế...

- Người bệnh mắc các bệnh mạn tính, nằm bất động lâu.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh suy đa phủ tạng.

- Người bệnh đang trong giai đoạn cấp của các bệnh như thiếu máu cơ tim.

- Các chấn thương cấp chưa được xử trí như gãy xương, trật khớp, tổn thương phần mềm cấp.

4. THẬN TRỌNG

- Kiểm tra đai cố định và khóa bàn, nâng từng mức theo dung nạp; theo dõi tụt huyết áp tư thế và nguy cơ ngã.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Dây đai cố định

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Hệ thống trục quay

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Kiểm tra các thông tin về tình trạng bệnh lý, đo mạch, huyết áp, nhịp thở, đánh giá tri giác nhận thức.

- Lượng giá trước điều trị bao gồm tình trạng đau, mức độ co cứng, tầm vận động khớp, cơ lực…

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-45 phút (ước tính 0,17-0,75 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bước 1: Đặt người bệnh nằm ngửa trên bàn nghiêng, hai bàn chân đặt sát giá đỡ phía cuối. Cố định người bệnh chắc chắn trên bàn bằng cách sử dụng các dây đai vòng qua ngang qua ngực, hông và cẳng chân. Lưu ý không cố định quá chặt gây đau cho người bệnh hoặc cản trở lưu thông tuần hoàn máu.

- Bước 2: Từ từ nâng bàn nghiêng theo hướng cho người bệnh từ từ đứng thẳng. Những lần đầu thực hiện kỹ thuật chỉ nâng bàn nghiêng dốc khoảng 0°-20°, sau đó trong những lần sau tăng dần lên 30°- 45° - 60° -75° cho đến khi người bệnh có thể đứng thẳng. Thời gian thực hiện kỹ thuật cũng tăng dần từ 10 phút cho đến 30-45 phút tùy thuộc vào khả năng chịu đựng (thích nghi) của người bệnh nhưng không quá 45 phút.

- Bước 3: Trong suốt quá trình thực hiện kỹ thuật này phải theo dõi huyết áp, mạch, đồng thời nhận định sự thích ứng hoặc phản ứng của người bệnh. Nếu người bệnh cảm thấy đau, khó chịu, chóng mặt hoặc nghi ngờ có hạ huyết áp tư thế thì phải giảm độ nâng của bàn nghiêng (góc quay).

- Bước 4: Hết thời gian điều trị, từ từ hạ bàn nghiêng xuống trở lại vị trí nằm ngang. Lưu ý vẫn phải theo dõi phản ứng của người bệnh.

- Bước 5: Tháo các dây đai cố định, để người bệnh tiếp tục nằm ngửa trên bàn nghiêng trong vòng 5 phút, sau đó mới đưa người bệnh trở lại vào giường nằm. Kết thúc một quy trình điều trị.

- Bước 6: Lượng giá lại thông số về mạch, huyết áp, nhịp thở, tình trạng đau, mức độ co cứng, tầm vận động khớp, cơ lực…sau điều trị

- Bước 7: Ghi chép hồ sơ, phiếu theo dõi điều trị. Có thể sử dụng kỹ thuật này 1- 2 lần/ ngày.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Trong suốt quá trình thực hiện kỹ thuật này phải theo dõi huyết áp, mạch, nhịp thở, sắc mặt, tình trạng tri giác của người bệnh nhằm phát hiện sớm các biến chứng hoặc tác dụng phụ không mong muốn xảy ra cho người bệnh.

- Nghi tụt huyết áp tư thế: dừng nâng, đưa bàn về tư thế nằm ngang an toàn, đo lại sinh hiệu và báo bác sĩ. Không tự đặt tư thế đầu thấp hoặc truyền dịch thường quy; xử trí theo tình trạng và y lệnh.

- Người bệnh đau: kiểm tra lại hệ thống dây đai cố định, tư thế người bệnh trên bàn nghiêng, vị trí hai bàn chân đặt trên giá đỡ có đúng không. Nêu không có sai sót gì, có thể hạ thấp bàn nghiêng xuống một chút.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

47 TẬP CÁC KIỂU THỞ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tập thở là kỹ thuật làm giãn nở lồng ngực nhờ tăng cường các cơ hô hấp và nhằm tạo được kiểu thở đúng, có hiệu quả.

- Tập thở là kỹ thuật được áp dụng rộng rãi để điều trị ở bất cứ nơi nào mà người bệnh có yêu cầu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Các bệnh hô hấp, tim mạch

- Các bệnh toàn thân ảnh hưởng tới hoạt động hô hấp: tổn thương tủy sống, gù vẹo cột sống, đột quỵ não, xơ cứng cột bên teo cơ, Guillain-barre, béo bệu, người bệnh thở máy trong giai đoạn cai máy và sau thở máy, phụ nữ có thai, người bệnh nằm lâu...

- Người bệnh trước và sau phẫu thuật lồng ngực, ổ bụng, cột sống….

- Căng thẳng, lo âu, suy nhược thần kinh.

- Dùng thuốc mê hoặc dùng thuốc quá liều.

- Rối loạn chuyển hóa còn đáp ứng bù trừ.

- Người có nhịp thở không bình thường vì bất cứ lý do gì.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mảng sườn di động

- Chấn thương lồng ngực, cơ hoành chưa được xử trí

- Người bệnh hôn mê, không hợp tác

4. THẬN TRỌNG

- Lao phổi hoạt động

- Tràn khí màng phổi chưa xử trí.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

- Điều dưỡng

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Gương soi

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Tinh thần thư giãn, thoải mái, sãn sàng tập thở

- Quần áo nới rộng.

- Chuẩn bị tư thế: năm ngửa, ngồi - đứng - đi, lên xuống cầu thang.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng, khu vực thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thở băng cơ hoành

* Tư thế năm ngửa: đầu gối gập 45°, khớp háng xoay ngoài:

- Kỹ thuật y làm mẫu, người bệnh quan sát

- Kỹ thuật y đặt một hoặc hai tay lên bụng trên người bệnh.

- Người bệnh hít vào từ từ bằng mũi đồng thời bụng phình lên tối đa đẩy tay kỹ thuật y lên. Không làm di chuyển lồng ngực, không ưỡn lưng

- Người bệnh thở ra, bụng từ từ hóp lại. Gần cuối thì thở ra kỹ thuật y ấn tay vào bụng người bệnh để thở ra thật hết.

- Lặp lại như vậy 20-30 nhịp thở cho mỗi lần tập.

- Khi người bệnh đã thực hiện thành thạo: Để người bệnh tự đặt tay lên bụng, tự ép nhẹ khi thở ra, khi người bệnh hít vào ổ bụng đẩy lên. Kỹ thuật y theo dõi, đánh giá kết quả.

- Những lần tập tiếp theo: sau khi hít vào người bệnh tập nín thở với thời gian tăng dần tùy khả năng của người bệnh

* Tư thế ngồi: người bệnh thư giãn, ngồi thăng bằng, tay đặt lên bụng, tiếp tục

tập thở.

* Tư thế đứng: tập thở trước gương soi để người bệnh tự kiểm tra việc thở của mình.

* Người bệnh thực hiện theo hướng dẫn của kỹ thuật y, quan sát và điều chỉnh cho đến khi người bệnh thực hiện thành thạo

6.2. Thở chúm môi

- Kỹ thuật y làm mẫu, người bệnh quan sát

- Hít vào từ từ bằng mũi cho đến khi phổi căng đầy không khí.

- Chúm môi chậm rãi thở ra từ từ qua miệng, bụng từ từ thóp lại. Chú ý thời gian thở ra ít nhất gấp 2 lần thời gian hít vào.

- Lặp lại như vậy 20-30 nhịp thở cho mỗi lần tập

- Người bệnh thực hiện theo hướng dẫn của kỹ thuật y, quan sát và điều chỉnh cho đến khi người bệnh thực hiện thành thạo

- Kỹ thuật này áp dụng cho người bệnh có tăng thể tích khí cặn, người bệnh có nguy cơ đóng hay xẹp đường thở

6.3. Tập thở phân thùy hoặc cạnh sườn:

- Tùy theo vị trí vùng tổn thương mà kỹ thuật y đặt tay lên thành ngực tương ứng: cạnh sườn một hoặc hai bên, phía trước hạ sườn…

- Ở cuối thì thở ra tay kỹ thuật y ấn đẩy lồng ngực, lồng ngực người bệnh kháng lại tay kỹ thuật y ở thì hít vào.

- Yêu cầu người bệnh hít sâu vào và nín thở trong một thời gian, sau đó thở ra chậm, đều.

- Kỹ thuật y đánh giá áp lực khi ấn đẩy lồng ngực, điều chỉnh kỹ thuật cho phù hợp để việc tập thở có hiệu quả cao nhất.

- Khi người bệnh tự thực hiện thành thạo: khuyến khích người bệnh thực hiện nhiều lần trong ngày.

6.4. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tình trạng toàn thân, sắc mặt, màu sắc da, huyết áp, nhịp thở, kiểu thở.

- Di động của lồng ngực, cơ hoành (nâng lên khi hít vào).

- Theo dõi tính độc lập chủ động tự tập thở của người bệnh, nhịp thở, kiểu thở.

- Kỹ thuật y theo dõi kết quả luyện tập: thở đúng.

- Mệt mỏi, mất cân bằng, choáng váng, mạch tăng: ngừng tập, báo cáo ngay cho bác sỹ chuyên khoa phục hồi chức năng để kịp thời xử trí.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

48 TẬP HO CÓ TRỢ GIÚP

1. ĐẠI CƯƠNG

- Ho là một phản xạ bảo vệ khi có kích thích đường hô hấp (dị vật, nước...)

- Ho chia làm 3 kỳ:

+ Kỳ 1: Chuẩn bị ho - ở thì thở vào (1-2 giây)

+ Kỳ 2: Khép thanh môn và co thắt các cơ hô hấp (0,25 giây)

+ Kỳ 3: Khi bị thở mạnh, thanh môn mở ra áp lực lồng ngực hạ xuống, giai đoạn này quyết định cường độ ho và kiểu ho.

- Ho có trợ giúp là kỹ thuật tác động để người bệnh tăng khả năng tống thải đờm dịch ra ngoài.

2. CHỈ ĐỊNH

- Khi cần tống thải các chất lắng đọng trong đường hô hấp ra ngoài.

- Bệnh lý có nguy cơ gây xẹp phổi.

- Người bệnh thở máy liên tục hoặc nằm bất động lâu ngày

- Những người bệnh mất phản xạ ho do tổn thương thần kinh chi phối các cơ quan hô hấp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trường hợp cần can thiệp ngoại khoa: Chảy máu lồng ngực, ổ bụng, chấn thương ngực có gãy xương sườn

4. THẬN TRỌNG

- Ho ra máu đỏ tươi

- Nhồi máu cơ tim cấp

- Thoát vị hoành, ổ bụng...

- Tràn khí màng phổi chưa xử trí

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Máy đo SpO_2

- Máy đo huyết áp, ống nghe…

- Khay quả đậu

- Cốc đựng đờm

- Giường, ghế

- Ống thông các loại.

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Máy hút đờm

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Giải thích và hướng dẫn cách tập cho người bệnh

- Tư thế thoải mái, dễ chịu, thuận tiện và phù hợp.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-15 phút (ước tính 0,17-0,25 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

* Trợ giúp ho

- Tay nhân viên y tế đặt lên lồng ngực ở vị trí cần tác động

- Ở thì thở ra của người bệnh, nhân viên y tế dùng tay ép vào lồng ngực người bệnh

- Lặp lại nhiều lần cho tới khi đạt hiệu quả

- Theo dõi nhịp thở của người bệnh hoặc hoạt động của máy thở để tác động vào đúng thì thở ra của người bệnh.

* Phản xạ khí quản

- Đầu ở tư thế duỗi

- Một tay nhân viên y tế đặt ở gáy để nâng đầu lên.

- Nhân viên y tế tìm vị trí hõm ức.

- Sờ tìm khí quản.

- Nhân viên y tế đặt ngón tay trượt ngang khí quản theo nhịp thở rồi ấn xuống dưới, ấn ra sau và vào trong.

* Đường hô hấp trên.

- Dùng máy hút kích thích cơ quan nhận cảm: rãnh mũi, vòm miệng.

- Dùng ngón tay sạch kích thích họng.

Lưu ý: tay nhân viên y tế ấn, đẩy phải ở thì thở ra.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi tình trạng toàn thân, sắc mặt, tím tái, kiểu thở, người bệnh mệt, mạch, huyết áp, SpO_2

- Dùng máy hút, hút dịch tiết (nếu không khạc được)

- Cần theo dõi số lượng, máu sắc, độ quánh, mùi vị dịch tiết.

- Mệt, sắc da tím, nôn mửa, thở nhanh: Ngừng tập và báo cáo bác sỹ chuyên khoa để xử trí ngay.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

49 KỸ THUẬT VỖ RUNG LỒNG NGỰC

1. ĐẠI CƯƠNG

- Võ, rung lồng ngực có tính chất cơ học làm long dịch tiết, long đờm, sau đó dẫn ra các phế quản rộng hơn để thoát ra ngoài nhờ phản xạ ho và khạc, hoặc dùng máy hút nếu người bệnh không tự ho được.

- Kỹ thuật võ, rung lồng ngực được tiến hành xen kẽ trong thời gian dẫn lưu tư thế và kết hợp tập thở và ho.

2. CHỈ ĐỊNH

- Các bệnh có ứ đọng, tăng tiết đờm dịch trong đường hô hấp: Viêm phổi, áp xe phổi, giãn phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, xẹp phổi, người bệnh thở máy...

- Người bệnh nằm một chỗ lâu ngày do bất động.

- Các bệnh tắc nghẽn dịch trong khi hôn mê…

- Trước phẫu thuật lồng ngực, trước và sau rửa phổi…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Những trường hợp có nguy cơ chảy máu trong lồng ngực.

- Chấn thương lồng ngực chưa xử trí.

- Có gãy hoặc rạn xương sườn mới

- Người bệnh suy kiệt nặng.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh loãng xương

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Gối kê lót

- Cốc đựng đờm có nắp

- Phấn rôm

- Máy đo huyết áp, ống nghe.

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường thủ thuật đa năng

- Máy hút dịch liên tục.

- Đèn đọc phim

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Kiểm tra mạch, huyết áp, nhịp thở, kiểu thở.

- Chuẩn bị vùng tập trung nhiều ứ đọng dịch tiết.

- Lưu ý đến các ống thông, các dây nối trên người bệnh.

- Nới rộng quần áo và tiến hành võ, rung khi người bệnh không ăn no.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-20 phút (ước tính 0,17-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng tư thế dẫn lưu, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Kỹ thuật võ lồng ngực

- Bước 1: Người thực hiện khum hai bàn tay, cổ tay mềm mại, các ngón tay khép tạo thành một đệm khí giữa lòng bàn tay và thành ngực người bệnh.

- Bước 2: Võ trên thành ngực tương ứng với vùng tổn thương, từ trên xuống dưới và ngược lại. Chú ý không đi thẳng vào vùng tổn thương ngay mà tiến từ xa đến gần, không gây đỏ da hoặc khó chịu cho người bệnh.

- Bước 3: Thực hiện kỹ thuật 10 - 20 phút hoặc đến khi đạt được hiệu quả tống thải đờm

- Cần lưu ý việc võ với các người bệnh:

+ Gầy, béo.

+ Người bệnh nữ (vùng vú).

+ Có vùng da dễ bị mãn cảm.

+ Người bệnh là trẻ em, cụ già.

6.2. Kỹ thuật rung lồng ngực

- Bước 1: Đặt hai bàn tay kỹ thuật y chồng lên nhau trên thành ngực người bệnh tương ứng với vùng tổn thương, cánh tay và cẳng tay thẳng, vuông góc với bàn tay.

- Bước 2: Khi người bệnh thở ra ấn đẩy và rung lên thành ngực tạo một lực rung cơ học. Chú ý chỉ làm ở cuối thì hít vào và kéo dài cho đến khi kết thúc thì thở ra của người bệnh.

- Bước 3: Thực hiện kỹ thuật 5 - 10 phút hoặc đến khi đạt được hiệu quả tống thải đờm

- Rung kết hợp trong dẫn lưu tư thế, người bệnh phải hít vào thật sâu, thở ra mạnh và dài. Rung kết hợp với việc ho và khạc để tống chất dịch ra ngoài.

- Lưu ý: khi làm rung đối với các người bệnh là trẻ em phải điều chỉnh các đầu ngón tay để tạo ra áp lực thích hợp, luôn luôn kết hợp dẫn lưu tư thế và dùng máy hút để lấy dịch ứ đọng ra ngoài.

- Khi thực hiện kỹ thuật rung lồng ngực, kỹ thuật y rất mệt và người bệnh cũng mệt do tư thế dẫn lưu, do phải thở ra mạnh và do phải ho khạc đờm ra ngoài.

6.3. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tình trạng người bệnh, sắc mặt, mạch, nhịp thở, SpO_2

- Theo dõi giãn nở lồng ngực và cơ hoành.

- Theo dõi ho, khạc đờm và dịch tiết ra (số lượng, màu sắc, độ quánh…)

- Theo dõi vùng da ở gần các xương.

- Tổn thương lồng ngực: da, xương sườn…do kỹ thuật vỗ, rung sai.

- Nếu nhịp thở không đều, huyết áp thay đổi thất thường, sắc màu da kém…phải dừng vận động, báo cáo cho bác sỹ chuyên khoa về để kịp thời xử trí.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó

thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

50 KỸ THUẬT DẪN LƯU TƯ THẾ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Dẫn lưu tư thế là kỹ thuật dùng tư thế thích hợp tùy theo vị trí tổn thương ở phổi để dẫn các dịch tiết trong đường hô hấp ra ngoài.

- Thường kết hợp với các kỹ thuật khác trong phục hồi chức năng như võ, rung, ho có trợ giúp…

2. CHỈ ĐỊNH

- Sau phẫu thuật lồng ngực, ổ bụng.

- Tràn dịch màng phổi.

- Người bệnh thở máy liên tục nhiều ngày.

- Người bệnh nằm bất động lâu ngày.

- Người bệnh bị giãn phế quản, bệnh xơ nang, tăng tiết dịch, đờm dãi.

- Xẹp phổi do ứ đọng.

- Áp xe phổi, viêm phổi.

- Tắc nghẽn dịch trong hôn mê, u não.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Hậu phẫu cắt một bên phổi

4. THẬN TRỌNG

- Lựa chọn tư thế theo bệnh nền, khả năng dung nạp và nguy cơ trào ngược, hít sặc; không mặc định tư thế đầu thấp cho mọi người.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Máy đo huyết áp, ống nghe.

- Gối kê lót

- Cốc đựng đờm có nắp

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường thủ thuật đa năng

- Máy hút dịch liên tục.

- Đèn đọc phim

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ... để người bệnh hiểu và hợp tác

- Kiểm tra mạch, huyết áp, nhịp thở, kiểu thở.

- Chuẩn bị vùng tập trung nhiều ứ đọng dịch tiết.

- Lưu ý đến các ống thông, các dây nối trên người bệnh.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng tư thế dẫn lưu...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bước 1: Xác định vị trí tổn thương cần điều trị

- Bước 2: Hướng dẫn và trợ giúp người bệnh và điều chỉnh giường hoặc kê gối cho người bệnh để đạt tư thế đúng tương ứng vùng tổn thương theo bảng dưới đây:

Thùy dẫn lưu	Phân thùy	Tư thế dẫn lưu
Thùy trên	Phân thùy đỉnh	Ngồi lưng thẳng hoặc nằm đầu cao
	Phân thùy sau	Nằm sấp hơi nghiêng 45 º về bên đối diện
	Phân thùy trước	Nằm ngửa
Thùy giữa phải, phân thùy 4,5 trái	Phân thùy sau-ngoài	Nằm sấp hơi nghiêng 45º về bên đối diện, chân giường kê cao 25cm
	Phân thùy trước-trong	
Thùy dưới	Phân thùy đỉnh	Nằm sấp
	Phân thùy đáy trong	Nằm ngửa chân giường kê cao 50cm
	Phân thùy đáy trước	Nằm ngửa chân giường kê cao 30cm

Thùy dẫn lưu	Phân thùy	Tư thế dẫn lưu
	Phân thùy đáy bên	Nằm sấp hơi nghiêng 45 độ về bên đối diện chân giường kê cao 30cm
	Phân thùy đáy sau	

- Bước 3: Nhân viên y tế luôn quan sát, theo dõi người bệnh trong quá trình dẫn lưu.

- Bước 4: Thay đổi tư thế: mỗi tư thế dẫn lưu từ 5 đến 10 phút. Tổng thời gian của các tư thế không quá 40 phút.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Trong khi làm cần phải theo dõi sắc mặt, tình trạng khó thở, mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO_2

- Theo dõi chất dịch khạc ra: màu sắc, độ đậm đặc, mùi vị, số lượng.

- Đánh giá kết quả dẫn lưu tư thế.

- Tai biến: người bệnh mệt mỏi nhiều, khó thở, da tím tái, mạch, huyết áp không ổn định…

- Xử trí: phải dừng ngay kỹ thuật và báo cáo cho bác sỹ chuyên khoa để kịp thời xử trí.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

51 KỸ THUẬT KÉO NẮN TRỊ LIỆU (KÉO NẮN, KÉO DÃN, CỘT SỐNG, CÁC KHỚP)

Kéo nắn có xung lực, đặc biệt vùng cổ, chỉ thực hiện khi có quy trình chuyên biệt được duyệt và người có năng lực, phạm vi hành nghề phù hợp. Mô tả tổng hợp này không thay thế sàng lọc nguy cơ và huấn luyện thao tác.

1. ĐẠI CƯƠNG

- Kéo nắn trị liệu là thao tác bằng tay do người thầy thuốc tiến hành để phát hiện sự tắc nghẽn khớp, đồng thời dùng thao tác để loại bỏ sự tắc nghẽn của khớp đó.

- Tắc nghẽn khớp là sự hạn chế độ trượt các diện của mỗi khớp lên nhau:

+ Nguyên nhân: do rối loạn điều hòa cơ; sau chấn thương; một số bệnh khớp; kích thích phản xạ bệnh lý nội tạng

+ Triệu chứng của tắc nghẽn khớp: đau khớp đột ngột, hạn chế động tác, đau có thể tái phát khi có sự thay đổi trạng thái như hành kinh, thời tiết thay đổi, dùng các thuốc giảm đau chỉ giảm tạm thời. Chụp Xquang và các xét nghiệm bình thường.

- Stoddart phân ra mức độ tắc nghẽn khớp như sau:

+ Độ 0: Cứng khớp, do nguyên nhân bệnh lý nào đó làm cho 2 đầu xương của khớp bị dính lại. Trong trường hợp này không thể kéo nắn được, không những không có kết quả mà còn gây tai biến.

+ Độ I: Tắc nghẽn nặng, trong trường hợp này người bệnh đau nhiều và hạn chế cử động. Vì vậy không nên kéo nắn trực tiếp mà phải chuẩn bị tốt bằng điều trị vật lý như nhiệt nóng trị liệu, xoa bóp trị liệu, di động khớp sau đó mới tiến hành kéo nắn.

+ Độ II: Tắc nghẽn khớp thực sự, chỉ định kéo nắn là tốt nhất.

+ Độ III: Khớp hoạt động bình thường không cần kéo nắn

+ Độ IV: Khớp bị lỏng không cần kéo nắn

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có tắc nghẽn khớp độ II

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương, trật khớp, đứt dây chằng khớp

- Các khối u lành tính và ác tính

- Các trường hợp có nguy cơ chảy máu

- Bệnh lý cột sống: viêm tủy, lao cột sống, chấn thương cột sống, hội chứng rễ…

- Thoái hóa khớp mức độ nặng

4. THẬN TRỌNG

- Khi kéo nắn cột sống cổ vì có thể gây chấn thương đốt sống và tủy sống dẫn đến liệt tứ chi.

- Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Dây đai

- Ga trải giường

- Gối kê

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Bàn tập chắc chắn, ổn định, có thể điều chỉnh độ cao, cao 60 cm, rộng 60 cm, dài 200 cm.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Để người bệnh năm ở tư thế thoải mái, phù hợp

- Kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, các xét nghiệm liên quan

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoChẩn đoán bệnh, chẩn đoán chức năng, phát hiện đánh giá và theo dõi kết quả tập.

- Chuẩn bị các xét nghiệm liên quan

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-20 phút (ước tính 0,17-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Kéo nắn là thao tác "ép" khớp ở cuối tầm vận động trượt cố lên nhau theo tầm độ và hướng vận động bình thường của khớp; hoặc trượt lên nhau theo hướng trước - sau hoặc bên - bên.

- Có thể kéo nắn để giải phóng tắc nghẽn các khớp ở chi, cột sống.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp và tình trạng người bệnh trước và sau thực hiện kỹ thuật kéo nắn.

- Theo dõi người bệnh có bị chấn thương hay không.

- Tai biến: chấn thương khớp, gãy xương, đau.

- Xử trí: giảm đau, xử trí theo mức độ chấn thương.

- Rất thận trọng khi kéo nắn cột sống cổ vì có thể gây chấn thương tủy sống dẫn đến liệt tứ chi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

52 KỸ THUẬT DI DỘNG KHỚP

1. ĐẠI CƯƠNG

- Di động khớp là các vận động cần thiết cho các chức năng thông thường của khớp qua tầm vận động mà người bệnh không thể tự thực hiện được như kéo, tách, trượt, ép, lăn và xoay tròn của các mặt khớp. Đây là loại vận động phụ trợ của khớp.

- Các loại kỹ thuật di động khớp gồm trượt khớp, kéo nắn khớp, lăn khớp, xoay tròn khớp, kéo dãn khớp khi trượt, kéo tách khớp, ép khớp

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau, giảm co cứng cơ và co thắt cơ

- Điều trị sự giảm vận động khớp hai chiều

- Điều trị các giới hạn tầm vận động khớp tiến triển

- Điều trị khi người bệnh phải bất động chức năng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khớp vận động lỏng lẻo do bị hoại tử, rách, đứt các dây chằng và bao khớp.

- Tràn dịch khớp do chấn thương, do bệnh gây ra. Hạn chế vận động khớp do dịch tăng lên và phản ứng cơ gây đau chứ không phải do co ngắn các tổ chức quanh khớp.

- Nhiễm trùng khớp: khi khớp bị viêm nhiễm, di động khớp sẽ làm tăng đau, co cơ phản xạ bảo vệ làm các mô bị tổn thương nặng thêm.

4. THẬN TRỌNG

- U ác tính, lao tại vị trí khớp điều trị

- Loãng xương

- Người bệnh bị gãy xương chưa lành (tuỳ thuộc vào vị trí gãy và kỹ thuật cố định)

- Người bệnh đau quá mức (xác định nguyên nhân gây đau)

- Khớp tăng động trong phản ứng liên hợp của các khớp. Các khớp khác phải được cố định đúng để lực vận động của khớp đang điều trị không truyền đến chúng.

- Người bệnh đã được phẫu thuật thay khớp toàn bộ.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Phấn rôm.

- Ga trải giường

- Gối kê

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Bàn tập

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra

- Người bệnh và các chi được điều trị ở trong tư thế thư giãn, chắc chắn. Các bài tập thư giãn có thể sử dụng trước và trong khi áp dụng các kỹ thuật di động khớp.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoChẩn đoán bệnh, chẩn đoán chức năng, phát hiện đánh giá và theo dõi kết quả tập.

- Người thực hiện kỹ thuật ghi rõ trong hồ sơ bệnh án thời gian thực hiện, loại kỹ thuật di động khớp sẽ thực hiện trên người bệnh.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 10-20 phút (ước tính 0,17-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.4. Lựa chọn kỹ thuật

- Để điều trị tình trạng đau kéo dài: nên sử dụng các kỹ thuật lắc khớp

- Để điều trị tình trạng mất vận động trượt khớp làm hạn chế vận động: nên sử dụng các kỹ thuật trượt khớp

- Để duy trì tầm vận động khớp: nên sử dụng các kỹ thuật lắc khớp hoặc trượt

khớp ở mức độ 2

- Để duy trì sự trượt khớp: khi không thể sử dụng các kỹ thuật tập theo tầm vận động hoặc khớp không được cử động trong một khoảng thời gian thì sử dụng kỹ thuật lắc khớp ở mức độ 2 hay kéo dãn khớp ở mức độ 2

- Nên sử dụng kỹ thuật trượt khớp cùng với các kỹ thuật kéo dãn khớp mức độ 1. Tránh sử dụng kỹ thuật kéo dãn khớp mức độ 2 hoặc 3 cùng lúc với kỹ thuật trượt khớp mức độ 3 vì sẽ gây tổn thương thêm cho khớp.

- Khi sử dụng các kỹ thuật kéo dãn khớp: đầu tiên cử động phần xương chung qua tầm trượt khớp cho phép để làm mềm khớp, khi cảm thấy kháng trở thì áp dụng kỹ thuật kéo dãn hoặc tách khớp để vượt qua sự kháng trở đó.

6.5. Vị trí của khớp

Khớp được đặt trong vị trí được nghỉ ngơi, bao khớp được thư giãn tối đa để ít gây đau nhất.

6.6. Thực hiện cố định tốt:

Có thể cố định băng băng, đai, băng tay của người điều trị. Phương pháp cố định phải chắc chắn nhưng thoải mái đối với các khớp có liên quan, thường là cố định ở phần gần trung tâm xương.

6.7. Cung cấp lực điều trị

Lực điều trị dù mạnh hay nhẹ nhưng cần phải được tác động ở càng gần mặt khớp càng tốt. Bề mặt tiếp xúc càng lớn thì các thao tác càng dễ dàng và thoải mái.

Thay bằng sử dụng lực tác động của các đầu ngón tay, người điều trị sử dụng phần mặt phẳng của bàn tay để cung cấp lực tác động.

6.8. Xác định hướng của vận động

- Người điều trị phải xác định được hướng của vận động là vuông góc trong kỹ thuật kéo dãn khớp và tách khớp hay là song song với mặt phẳng điều trị trong kỹ thuật trượt khớp.

- Mặt phẳng điều trị là mặt phẳng vuông góc với đường thẳng từ trục của xương xoay vòng đến điểm giữa mặt lõm của bề mặt khớp. Mặt phẳng điều trị là phần mặt lõm do đó vị trí của nó được xác định bởi vị trí của xương lõm.

6.9. Tốc độ, nhịp điệu và thời gian thực hiện kỹ thuật di động khớp

a) Đối với kỹ thuật lắc khớp

Áp dụng nhịp nhàng, lắc đều từ 2-3 lần trong một giây trong thời gian 1-2 phút. Có thể thực hiện với biên độ thấp và tốc độ cao để ức chế đau hay biên độ thấp và tốc độ chậm để thư giãn cơ bảo vệ.

b) Đối với kỹ thuật kéo dãn khớp

Nếu các khớp đau nhiều, áp dụng kỹ thuật kéo ngắt quãng trong 10 giây, nghỉ vài giây giữa các lần kéo dãn. Nếu các khớp có hạn chế vận động, sử dụng kỹ thuật kéo dãn khớp với lực nhỏ trong 6 giây, sau đó giảm lực một phần đến mức độ 1 hoặc 2 rồi lặp lại trong khoảng 3-4 giây.

6.10. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Ngày đầu tiên điều trị

Để khớp nghỉ ngơi hoặc thư giãn tối đa để giảm đau và làm mềm khớp.

Ngày thứ hai

- Nếu đau tăng lên, tăng nhạy cảm khớp, giảm xuống vận động lắc mức độ 1

- Nếu không đau hay khớp dễ chịu hơn, làm lại kỹ thuật kéo dãn khớp mức độ 2 nếu mục đích điều trị để duy trì trượt khớp hoặc sử dụng bài tập kéo dãn mức độ 3, trượt khớp mức độ 3 nếu mục đích điều trị là tăng cường trượt khớp.

Những ngày tiếp theo

- Khi tầm vận động khớp đã khá lên hoặc vận động khớp hết tầm vận động, sử dụng các kỹ thuật kéo dãn mức độ 3, trượt khớp mức độ 3

- Tăng tiến điều trị bằng sử dụng kỹ thuật xoay một phần ở cuối tầm vận động trước khi trượt hay kéo dãn khớp mức độ 3

- Rách mô cơ, dây chằng, bao khớp hay trật khớp có thể xảy ra nếu thực hiện kỹ thuật di động khớp quá mức hay không đúng, giật cục. Khớp sưng to hơn, đau kéo dài hơn có thể là những dấu hiệu chỉ điểm. Cần sử dụng những biện pháp điện trị liệu như sóng ngắn, hồng ngoại, chườm lạnh... để giảm sưng đau và tạm nghỉ kéo dãn, cố định khớp ít nhất 2 ngày nếu xác định có tổn thương phần mềm quanh khớp.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

53 KỸ THUẬT TẬP CHUỖI ĐÓNG VÀ CHUỖI MỞ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Vận động chuỗi là chuỗi liên kết hoạt động giữa các hệ thống để tạo ra cử động của con người, các hệ thống đó bao gồm hệ thống cơ, thần kinh và hệ thống xương với sự phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng. Các bài tập vận động chuỗi là các bài tập sử dụng sự liên kết hoạt động giữa thần kinh, cơ, khớp và xương của một phần hay toàn cơ thể. Các bộ phận này phải hoạt động đồng thời cùng nhau tạo ra các cử động có mục đích. Ví dụ khi co cơ nhị đầu cánh tay, cử động gập khuỷu hình thành do sự phối hợp hoạt động của cơ, thần kinh vùng vai và cánh tay chứ không chỉ riêng của cơ nhị đầu vốn là mối quan tâm ban đầu của chúng ta.

- Có hai loại bài tập chuỗi là bài tập chuỗi đóng và bài tập chuỗi mở

+ Các bài tập chuỗi đóng (Closed Kinetic Chain Exercises - CKCE): là các bài tập được thực hiện khi bàn chân (đối với cử động của chân) hay bàn tay (đối với cử động của tay) ở trong vị thế cố định, không di chuyển trong suốt bài tập, bàn tay hay bàn chân duy trì sự tiếp xúc hăng định với một mặt phẳng, thông thường là mặt đất, bàn đạp chân của xe đạp hay tay cầm của máy tập. Những bài tập này là bài tập chịu sức nặng bao gồm cả sức nặng cơ thể hay sức nặng ngoại lai như tạ, lò xo.

+ Các bài tập chuỗi mở (Opened Kinetic Chain Exercises - OKCE): là các bài tập được thực hiện khi bàn chân (đối với cử động của chân) hay bàn tay (đối với cử động của tay) cử động tự do và được thực hiện trong vị thế không chịu sức nặng. Sức đề kháng thông thường được đặt ở đoạn xa của chi thể và cử động thường xuất hiện trên một khớp bản lề như khớp khuỷu hay khớp gối.

- Các đặc điểm của bài tập vận động chuỗi đóng và chuỗi mở

Đặc điểm	Bài tập chuỗi đóng	Bài tập chuỗi mở
Mẫu tác động lực	Đường thẳng, lực ép	Xoay, lực cắt
Số khớp trục	Nhiều khớp	Một khớp chính
Trạng thái phân đoạn khớp	Cả hai đoạn đều cử động đồng thời	Một đoạn cố định, một đoạn cử động
Số lượng khớp di chuyển	Cử động nhiều khớp	Cử động một khớp phân lập
Mặt phẳng cử động	Đa chiều	Một chiều
Sự liên quan hoạt động của các cơ	Đồng co cơ rõ rệt	Co một cơ phân lập hay động co cơ tối thiểu
Mẫu cử động	Cử động chức năng	Thông thường cử động trục

2. CHỈ ĐỊNH

- Cả hai loại bài tập chuỗi đóng và bài tập chuỗi mở đều có vai trò quan trọng trong giai đoạn cuối của chương trình phục hồi chức năng.

- Các bài tập chuỗi đóng cho phép khởi động chương trình tập nhanh hơn và ít tạo sức căng trên mô vùng xung quanh hơn.

- Các bài tập chuỗi mở cho phép tầm vận động lớn hơn và có thể sử dụng trong các hoạt động khởi động trong thể thao.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Thảm tập

- Tạ các loại

- Ga trải giường

- Gối kê

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Bàn tập, cầu thang tập, xe đạp tập, máy tập tay...

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra

- Trình bày động tác tập để người bệnh hiểu, có thể làm mẫu nhiều lần trước khi người bệnh tự thực hiện động tác. Mỗi cử động phải theo một trình tự đúng, từ vị trí khởi đầu, cử động đến hết tầm hoạt động của khớp, rồi lại trở về vị trí khởi đầu, xong lại tiếp tục lần lặp lại khác.

- Các động tác tập không quá dễ cũng không quá khó đối với khả năng thực hiện của người bệnh. Nếu có cử động thay thế là do động tác tập quá nặng, tạ quá trọng lượng hoặc do người bệnh chưa thể thực hiện bài tập một cách chủ động.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa chẩn đoán bệnh, chẩn đoán chức năng, phát hiện đánh giá và theo dõi kết quả tập.

- Người thực hiện kỹ thuật ghi rõ trong hồ sơ bệnh án thời gian thực hiện, loại bài tập chuỗi đóng hay chuỗi mở sẽ thực hiện trên người bệnh.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.4. Lựa chọn bài tập

Lựa chọn bài tập vận động bài tập chuỗi đóng hay chuỗi mở dựa trên quy mô vùng thân thể cần được tập luyện, mục đích tập. Đây là loại bài tập thường liên quan đến nhiều khớp, nhiều cơ trong cơ thể.

6.5. Thực hiện kỹ thuật

a) Các bài tập chuỗi đóng

- Đối với chi trên: Chống đẩy (hít đất, đẩy tường), chống trên hai tay trong vị thế quỳ, kéo xà, tập mạnh các cơ vai, cánh tay bằng máy tập có tay cầm...

- Đối với chi dưới: Ngồi xổm đứng dậy, đạp xe đạp, đạp hai chân trên bàn tập đứng...

b) Các bài tập chuỗi mở

- Đối với chi trên: Các bài tập chủ động tự do hai tay có cầm tạ tay hay không...

- Đối với chi dưới: Nằm ngửa nâng chân lên háng gập gối duỗi thẳng, đạp xe trên không, nằm sấp nâng chân với háng duỗi gối gập..

6.6. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Nếu người bệnh mệt tăng lên, đau tăng lên, tăng nhạy cảm khớp, giảm cường độ tập và thời gian tập xuống.

- Nếu không đau hay khớp dễ chịu hơn, lặp lại bài tập với cường độ và thời gian

như trước.

- Theo dõi và tăng dần cường độ tập hoặc có thể kéo dài thời gian tập mà không làm người bệnh mệt mỏi hoặc đau tăng lên.

- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

54 KỸ THUẬT XOA BÓP VÙNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xoa bóp là một thủ thuật có tính khoa học được thực hiện bằng các tác động lên mô, cơ, vùng phản xạ và các đường kinh lạc trên cơ thể để nhằm mục đích chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng.

- Xoa bóp bằng tay là những thủ thuật xoa nắn các mô một cách có khoa học và hệ thống nhằm tác động lên các cơ, hệ thần kinh, hệ tuần hoàn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Làm giãn cơ, giảm đau

- Tổn thương mô mềm, sau bất động gãy xương

- Co thắt cơ gây đau, sẹo và những kết dính

- Tổn thương thần kinh dẫn đến co cơ, liệt cơ

- Cao huyết áp, đau đầu mất ngủ, suy nhược thần kinh

- Trước khi thực hiện các kỹ thuật vận động khác hoặc kỹ thuật kéo nắn

- Kích thích hoặc làm êm dịu hệ thần kinh.

- Điều trị dính của các mô.

- Cải thiện tuần hoàn, tăng bài tiết các chất cặn bã

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng toàn thân

- Viêm tĩnh mạch cấp, huyết khối tại vị trí điều trị

- Nhiễm trùng da, ung thư da tại vị trí điều trị

- Phụ nữ có thai không xoa bóp bụng, đau bụng chưa rõ nguyên nhân

4. THẬN TRỌNG

- Da quá mẫn cảm

- Vùng gãy xương

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Dầu xoa, thuốc mỡ hoặc phấn rôm

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường xoa bóp

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh ở tư thế thoải mái, dễ chịu, thuận tiện tùy xùng cần điều trị xoa bóp

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- **Bước 1:** Xoa dầu hoặc thuốc mỡ lên vùng xoa bóp

- **Bước 2**: Xoa vuốt nông: dùng hai bàn tay trượt nhẹ nhàng lên phần cơ thể được xoa bóp, xoa vuốt theo chiều dọc hay xoa thành vòng tròn. Xoa vuốt sâu: trong trường hợp cơ bị co, làm tăng tuần hoàn máu và bạch huyết.

- **Bước 3**: Bóp nắn cơ

- **Bước 4:** Nhào cơ

+ Nhào bóp nhẹ để làm cho cơ chùng xuống và thư giãn cơ.

+ Nhào bóp sâu: làm tăng sức mạnh của cơ.

- **Bước 5:** Day cơ, miết cơ

- **Bước 6:** Chà xát.

- **Bước 7:** Rung, lắc cơ.

- **Bước 8**: Ấn day các điểm đau hoặc các huyệt.

Yêu cầu kỹ thuật

- Tư thế kỹ thuật y tốt, thoải mái, cạnh người bệnh

- Bàn tay kỹ thuật y mềm mại, thả lỏng thích hợp với vị trí điều trị

- Nhịp điệu xoa bóp đều đặn

- Không gây đau cho người bệnh.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tình trạng người bệnh: mức độ đau, mạch, huyết áp...

- Màu sắc vùng da điều trị

- Nếu có những diễn biến bất thường cần ngừng xoa bóp ngay và báo cáo với bác sỹ chuyên khoa Phục hồi chức năng.

- Hoa mắt, chóng mặt...: dừng xoa bóp

- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Học viện Quân Y, 2003, "Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học", Nhà xuất bản Quân đội nhân dân

55 XOA BÓP ÁP LỰC HƠI (KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ BẰNG MÁY ÉP KHÍ NGẮT QUÃNG)

1. ĐẠI CƯƠNG

Kỹ thuật điều trị bằng máy ép khí ngắt quãng hay còn gọi là kỹ thuật xoa bóp áp lực hơi là kỹ thuật sử dụng thiết bị nén khí ngắt quãng nhằm phục hồi hoặc ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau, hệ thống nén khí ngắt quãng được chứng minh là phù hợp cho hoạt động lưu thông, tuần hoàn máu, giảm phù nề, chống đông máu, cải thiện tình trạng thiếu máu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Dự phòng huyết khối tĩnh mạch.

- Phù nề do bạch huyết: sau phẫu thuật cắt bỏ mạch bạch huyết (ví dụ: do cắt bỏ tuyến vú...).

- Phù nề cấp tính: sau phẫu thuật, sau bỏng tiểu đường.

- Phù nề sau liệt thần kinh trung ương: tổn thương tuỷ sống, đột quỵ não.

- Phù nề sau liệt thần kinh ngoại biên.

- Phù nề sau chấn thương, bong gân...

- Xơ cứng tĩnh mạch, bệnh giãn tĩnh mạch, suy tĩnh mạch mạn tính, suy động mạch.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Suy tim, tăng huyết áp.

- Tiền sử huyết khối tĩnh mạch (DVT), tắc mạch phổi (PE).

- Lở loét vùng da điều trị, bỏng.

- Hoại tử cấp tính kèm theo sốt và phát ban đỏ.

- Viêm vùng ngoại vi nghiêm trọng.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá tuần hoàn, da và nguy cơ huyết khối trước dùng ép khí; điều chỉnh áp lực theo chỉ định, không dùng khi chưa loại trừ chống chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

- Điều dưỡng

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế : Máy ép khí ngắt quãng

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện : mục đích, các bước tiến hành ...

- Đặt người bệnh ở tư thế thuận lợi cảm thấy thư giãn, không căng thẳng ; kỹ thuật y dễ thao tác trong lúc điều trị. Thông thường, chọn tư thế nằm.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh : Đánh giá tính chính xác của người bệnh : đúng người bệnh, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- **Bước 1 :** bật công tắc nguồn ON/OFF → Đợi 2 - 3 giây → máy hoạt động.

- **Bước 2 :** cắm các ống nối với bao cuốn sao cho các đầu dây tạo thành 1 đường thẳng.

- **Bước 3 :** đưa bao cuốn vào ống chân, tay người bệnh.

- **Bước 4 :** đặt người bệnh ở tư thế nằm, đeo bao cuốn vào chân hẹn thời gian 15-20 phút, tăng áp lực đến mức vừa phải, thường xuyên phải thăm hỏi cảm giác người bệnh, nếu thấy đau thì phải hạ áp lực hoặc nhẹ có thể tăng thêm áp lực.

- **Bước 5 :** khi hết thời gian điều trị, máy sẽ báo tín hiệu âm thanh tháo bao cuốn để gọn vào 1 vị trí.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn

phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Luôn kiểm tra và hỏi thăm xem người bệnh có thấy khó chịu hay không.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế, 2017, “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng” (đợt 2), ban hành theo Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

56 KỸ THUẬT XOA BÓP TOÀN THÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Xoa bóp bằng tay là những thủ thuật xoa nắn các mô của cơ thể một cách khoa học và hệ thống, nhằm mục đích tác động lên hệ cơ, hệ thần kinh và trên hệ tuần hoàn tổng thể.

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau và di động các lớp mô co thắt.
- Kích thích hoặc làm êm dịu hệ thần kinh.
- Cải thiện tuần hoàn, tăng bài tiết các chất cặn bã và giảm phù nề.
- Chống mệt mỏi, thư giãn, giảm stress.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng nhiễm trùng.
- Nhiễm trùng da.
- Viêm tĩnh mạch huyết khối.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh suy yếu

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Gối các loại.
- Dầu xoa, thuốc mỡ, bột tan, phấn rôm.
- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn
- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường, bàn xoa bóp (có kích thước phù hợp với người thực hiện xoa bóp).
- Ghế ngồi

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh phải được thư giãn và thoải mái, áo quần không quá chật, sao cho các thao tác thực hiện dễ dàng.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Kỹ thuật y nắm vững nguyên nhân và quá trình diễn biến của người bệnh

- Lượng giá và lập kế hoạch điều trị

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30-60 phút (ước tính 0,50-1,00 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Xoa dầu hoặc thuốc mỡ lên vùng xoa bóp.

- Kỹ thuật xoa vuốt:

+ Dùng hai bàn tay trượt nhẹ nhàng, dịu dàng lên phần cơ thể được xoa bóp, xoa vuốt theo chiều dọc hay xoa thành vòng tròn.

+ Lực vuốt khởi đầu từ xa tiến tới phần gần để tạo thuận cho sự lưu thông máu.

+ Hai bàn tay có thể rời khỏi phần cuối của động tác và trở lại điểm khởi đầu.

+ Có thể vẫn duy trì hai bàn tay tiếp xúc trên da khi trở lại điểm khởi đầu nhưng không tạo sức ép.

+ Trong xoa vuốt nông hướng của lực không quan trọng vì áp suất quá nhẹ không tạo được hiệu quả cơ học.

+ Trong xoa vuốt sâu hướng của lực rất quan trọng vì mục tiêu chính là tạo thuận cho sự lưu thông tuần hoàn máu và bạch huyết. Do đó lực vuốt về luôn luôn phải hướng tâm.

- Kỹ thuật nhào bóp: sự nhào bóp bao gồm xoa, ép và chà xát.

+ Xoa là một cử động nhấc mô mềm lên giữa các ngón tay và thực hiện một cách luân phiên tạo cử động trong giới hạn của chính cơ đó nhằm kéo giãn các kết dính.

+ Ép được thực hiện ở vùng cơ rộng hơn. Ép vùng điều trị hoặc giữa hai bàn tay hoặc giữa bàn tay và một vật cứng như mặt bàn tay mặt xương.

+ Chà xát là cử động vòng tròn thực hiện bằng cách đặt một phần nhỏ của bàn tay trên vùng điều trị, thực hiện nhanh với gia tăng áp suất.

- Kỹ thuật võ (gõ): là cử động luân phiên nhằm tạo sự kích thích.

+ "Giần" thường được thực hiện với bề ngoài của bàn tay hay với các ngón tay thư giãn, với hai bàn tay nẩy lên luân phiên từ vùng điều trị.

+ "Võ" được thực hiện với hai gan bàn tay theo cùng một cách. Nếu hai bàn tay úp âm thanh tạo ra gây lên được một hiệu quả tâm lý.

+ "Đập" được thực hiện với hai bàn tay nắm theo cùng một cách.

+ "Rung" bằng cách đặt các đầu ngón tay tiếp xúc với mặt da và lay toàn cánh tay, truyền một cử động rung tới người bệnh.

- Trong xoa bóp toàn thân các kỹ thuật nhào bóp được dùng để di chuyển các chất tích đọng trong mô và để kéo giãn sự kết dính, tiếp theo là kỹ thuật vuốt vê nhằm chuyển di các chất dịch tích động hay phù nề. Các cử dộng võ thường dùng cuối chương trình điều trị.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tình trạng người bệnh.

- Màu sắc vùng da nơi xoa bóp.

- Nếu có những diễn biến xấu cần ngừng xoa bóp ngay và báo cáo với bác sĩ chuyên khoa phục hồi chứcnăng.

- Đau cơ: thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.

- Quá sức: nghỉ ngơi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối

chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

57 KỸ THUẬT KIỂM SOÁT ĐẦU, CỔ VÀ THÂN MÌNH

1. ĐẠI CƯƠNG

Trẻ bại não hay gặp các bất thường trong hoạt động kiểm soát đầu cổ và thân mình. Điều này dẫn đến việc trẻ chậm phát triển về vận động ở các mốc lẫy, ngồi, bò, đứng, đi.

2. CHỈ ĐỊNH

Trẻ kiểm soát đầu cổ và thân mình kém.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Gối tam giác, bóng tròn

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho cha mẹ trẻ về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra

- Mặc quần áo rộng thoải mái khi thực hiện thao tác

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật; Buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.4. Kỹ thuật 1: Điều chỉnh đầu về vị trí trung gian ở tư thế nằm ngửa

- Mục đích: giúp trẻ không bị ưỡn đầu cổ ra sau quá mức.

- Thực hiện kỹ thuật

+ Tư thế: Trẻ nằm ngửa, kỹ thuật y ngồi phía dưới chân trẻ.

+ Đặt 2 tay đỡ lấy đầu trẻ phần sau chẩm. Nâng đầu trẻ lên đồng thời ấn 2 cẳng tay xuống 2 vai trẻ.

+ Hướng dẫn người nhà cách làm và ghi hồ sơ.

- Tiêu chuẩn đạt

+ Cổ trẻ mềm hơn, đỡ ưỡn ra sau.

+ Gia đình tự làm được.

6.5. Kỹ thuật 2: Tạo thuận nâng đầu bằng tay ở tư thế nằm sấp

- Mục đích: Làm khoẻ nhóm cơ duỗi cổ và thân mình.

- Tiến hành

+ Tư thế: Trẻ nằm sấp có 1 gối nhỏ dưới ngực, kỹ thuật y ngồi bên cạnh

+ Một tay cố định trên mông trẻ. Tay kia dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn day dọc các gai ngang các đốt sống từ C7 - S1.

+ Hướng dẫn người nhà cách làm và ghi hồ sơ.

- Tiêu chuẩn đạt

+ Trẻ nâng đầu và ngực cao hơn, giữ được tư thế đó 30 giây đến 1 phút.

+ Gia đình tự làm được.

6.6. Kỹ thuật 3: Tạo thuận nâng đầu bằng sử dụng gối kê trước ngực

- Mục đích: Làm khoẻ nhóm cơ duỗi cổ và thân.

- Tiến hành

+ Tư thế: Trẻ nằm sấp với một gối tam giác nhỏ kê ở ngực, 2 tay hướng ra trước

với cánh tay chống vuông góc với khớp vai, khuỷu gập vuông góc với cẳng tay quay sấp. Kỹ thuật y ngồi cạnh trẻ.

+ Một tay kỹ thuật y cố định chắc ở mông trẻ, tay kia dùng đồ chơi kích thích phía trước trên đầu trẻ để trẻ với về phía trước.

+ Hướng dẫn người nhà cách làm và ghi hồ sơ.

- Tiêu chuẩn đạt

+ Trẻ nâng đầu và ngực cao hơn, giữ được tư thế đó 30 giây - 1 phút.

+ Gia đình tự làm được.

6.7. Kỹ thuật 4: Điều chỉnh đầu cổ về vị trí trung gian ở tư thế nằm sấp trên bóng

- Mục đích: Làm khoẻ nhóm cơ duỗi cổ và thân mình.

- Tiến hành

+ Tư thế: Trẻ nằm sấp trên bóng tròn, hai chân dạng, duỗi khớp gối và xoay ngoài.

+ Kỹ thuật y ngồi hoặc quỳ phía chân trẻ. Hai tay kỹ thuật y giữ hai khớp gối của trẻ. Từ từ lăn bóng ra trước, lùi lại và sang hai bên. Đặt đồ chơi phía trước mặt trẻ để khuyến khích trẻ ngẩng đầu, nâng thân và với hai tay về phía trước.

+ Hướng dẫn người nhà cách làm và ghi hồ sơ.

- Tiêu chuẩn đạt

+ Trẻ có thể nâng đầu cổ, duỗi thân mình và với tay về phía trước.

+ Gia đình tự làm được.

6.8. Kỹ thuật 5: Bài tập thăng bằng ngồi trên bóng/bàn nghiêng

- Mục đích: Tăng khả năng thăng bằng ngồi.

- Tiến hành

+ Tư thế: trẻ ngồi trên bóng/bàn nghiêng.

+ Kỹ thuật y đứng hoặc ngồi phía sau trẻ. Hai tay kỹ thuật y giữ chắc 2 bên hông trẻ,đẩy bóng/bàn nghiêng sang phải, trái, trước, sau để trẻ tập quen với việc điều chỉnh tư thế khi mất thăng bằng. Khi trẻ quen dần và có khả năng điều chỉnh thì giảm dần lực trợ giúp 2 bên hông của trẻ.

+ Hướng dẫn người nhà cách làm và ghi hồ sơ.

- Tiêu chuẩn đạt

+ Trẻ có thể giữ thăng bằng khi bị nghiêng sang các phía.

+ Tăng tiến mức độ thăng bằng.

+ Gia đình tự làm được.

6.9. Kỹ thuật 6: Bài tập thăng bằng trên sàn

- Mục đích: Tăng khả năng thăng bằng của trẻ.

- Tiến hành

+ Tư thế: trẻ ngồi thoải mái trên sàn.

+ Kỹ thuật y ngồi phía sau trẻ, hai tay hoặc 1 tay của kỹ thuật y đẩy vào vai trẻ từ trước ra sau hoặc ngược lại, từ phải sang trái hoặc ngược lại, xoay trẻ từ phải sang trái hoặc ngược lại.

+ Hướng dẫn người nhà cách làm và ghi hồ sơ.

- Tiêu chuẩn đạt

+ Trẻ có thể giữ thăng bằng khi bị nghiêng sang các phía.

+ Tăng tiến mức độ thăng bằng.

+ Gia đình tự làm được.

Lưu ý: Mỗi buổi tập 1-2 động tác tùy vào khả năng tập của trẻ

6.10. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Trẻ khóc, tím tái.

- Đau cơ: thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lí trị liệu

- Nghỉ ngơi, các biện pháp vật lí trị liệu

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Michael A. Alexander. Dennis J. Matthews (2015) “Pediatric Rehabilitation Principles and Practice”, Fifth Edition, Demos Medical Publishing.

58 TẬP ĐIỀU HỢP VẬN ĐỘNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Điều hợp vận động là kết quả của quá trình hoạt động phối hợp của một số cơ trong mẫu đồng co cơ và là chuỗi cử động co và thư giãn cơ một cách mềm mại, uyển chuyển, chính xác trong điều kiện bình thường (không bị các bệnh lý thần kinh tháp và ngoại tháp).

- Nguyên tắc tập điều hợp vận động

+ Bài tập phải được chia ra từng giai đoạn nhỏ đơn giản để người bệnh thực hiện chính xác và loại bỏ những sai sót. Bài tập càng phức tạp thì càng cần chia nhỏ nhiều bước.

+ Mỗi bước nhỏ trong bài tập phải được người bệnh thực hiện với sự kiểm soát có ý thức và người điều trị phải chắc chắn người bệnh thực hiện độc lập và chính xác trước khi chuyển qua bước khác.

+ Trong giai đoạn đầu, người bệnh cần luyện tập từ từ để có đủ thời gian suy nghĩ và cảm nhận đáp ứng cơ của mẫu vận động.

+ Lực đề kháng chỉ đủ để tạo ra sự cố gắng trong khi vẫn duy trì được tính chính xác của cử động.

+ Người bệnh cần được nghỉ ngắn mỗi 2-3 lần lặp lại của động tác để không thực hiện mẫu sai do mệt mỏi bởi vì duy trì tính chính xác của cử động trong suốt thời gian tập luyện rất quan trọng để hình thành các mẫu vận động điều hợp và chính xác cho người bệnh sau này.

+ Để hình thành và phát triển cử động điều hợp và chính xác, người bệnh cần lặp lại cử động nhiều lần.

+ Khi gia tăng tốc độ, lực, sự phức tạp của cử động thì mức cố gắng của người bệnh cũng gia tăng theo, tuy nhiên mức cố gắng này chỉ được phép vừa đủ để duy trì tính chính xác của cử động. Do vậy tốc độ, lực, sự phức tạp của động tác phải tăng dần dần trong mức cho phép và chỉ đến mức gần đỉnh của khả năng mà thôi. Lặp lại nhiều lần động tác ở gần mức tối đa sẽ tạo ra và duy trì điều hợp.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh liệt nửa người do đột quỵ não, chấn thương sọ não, u não, viêm não...

- Người bệnh bị các bệnh lý thần kinh tổn thương hệ thống ngoại tháp

- Người bệnh bị bại não, chậm phát triển vận động tinh thần.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị rối loạn tri giác nhận thức không hiểu hướng dẫn điều trị.

- Người bệnh không duy trì được tư thế cần thiết trong suốt quá trình tập

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động

vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Bàn tập, ghế tập, thảm tập, thanh song song, bục đi...

- Ghế ngồi

- Phấn rôm

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Đặt người bệnh trong tư thế thoải mái, vững chắc và ổn định để cho phép người bệnh thực hiện tốt nhất bài tập

- Xác định nguyên nhân làm giảm vận động chi thể, điều hợp kém và chọn kỹ thuật tập thích hợp.

- Đánh giá khả năng thăng bằng trong các vị thế của người bệnh để chọn lựa tư thế tập phù hợp, vững chắc.

- Đánh giá sức mạnh cơ vùng có hạn chế vận động để cân nhắc về số lần lặp lại của động tác.

- Dùng các kỹ thuật thư giãn, nhiệt nóng đối với tổ chức mô mềm trước khi tập để làm tăng khả năng duỗi dài cơ và tạo sự mềm dẻo, dịu dàng, nhịp nhàng cho động tác.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.4. Lựa chọn kỹ thuật

Lựa chọn kỹ thuật tập và số lần lặp lại của động tác để có thể đạt được mục đích tốt nhất

6.5. Thực hiện kỹ thuật tập điều hợp

Bước 1: Những hoạt động điều hợp của bàn tay và cánh tay

- Các hoạt động cần cử động đồng thời của cổ tay, khuỷu, vai để bàn tay thực hiện các hoạt động chức năng. Các bài tập nắm bằng các đầu ngón tay, dạng, khép và xoay các khớp bàn đốt với sự thay đổi đa dạng tầm độ gấp của các khớp liên đốt. Mức đóng mở hay số lượng các ngón tay sẽ tạo ra lực cầm nắm khác nhau.

- Ngón cái với sự linh động ở khớp cổ bàn là ngón tay cử động đa dạng nhất và do vậy cũng khó tập luyện điều hợp nhất. Do vậy nếu điều hợp của ngón cái không phát triển thì nó sẽ trở thành chướng ngại vật cho các hoạt động của các ngón khác.

- Những ngón tay khác vận động linh hoạt ở khớp bàn đốt trong nhiều mặt phẳng xoay, dạng-khép, gấp-duỗi. Mỗi cử động ở mỗi khớp này phải được điều hòa bởi sự co thích hợp của những cơ chủ vận và ức chế tất cả các cơ khác.

- Chỉ sau khi đã hình thành được điều hợp thì những chức năng hữu dụng của bàn tay mới được biểu lộ. Đối với một người bệnh bị mất điều hợp, nếu những hoạt động phức tạp như kẹp vật không được chia nhỏ thành các bước để luyện tập chính xác và được kiểm soát trực tiếp bởi ý chí thì sự điều hợp cử động sẽ không bao giờ xuất hiện.

- Khi người bệnh bị tổn thương hệ thống ngoại tháp làm mất điều hợp cử động thì quan trọng là luyện tập để thực hành mẫu chính xác nhiều lần mỗi ngày bằng cách tập với các dụng cụ ghi điểm như dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, máy đánh chữ, chơi game...

Bước 2: Những hoạt động di chuyển của cánh tay và cẳng tay

- Tập các cử động như với, di chuyển vào các vị thế của vai, khuỷu, cổ tay.

- Ở những người bệnh bại não thể múa vờn rất khó có thể thực hiện được các

mẫu chính xác. Những trẻ em chưa phát triển nội trình tự động thường có những cử động dị thường không tiên lượng được ở cả mặt phẳng ngang và đứng dọc, những cử động này vượt quá khả năng kiểm soát của hệ thống não bộ - tuỷ sống.

Bước 3: Rèn luyện điều hợp để duy trì thăng bằng đứng và đi

- Điều hợp giúp tăng khả năng thăng bằng tư thế và trợ giúp kháng trọng lực cũng như các hoạt động phối hợp của các chi.

- Tập để thành lập một chân đế chắc chắn trong mối tương quan với trọng lực bởi sự co điều hợp thích đáng của các cơ đầu và thân.

- Khi cánh tay di chuyển, phải có điều chỉnh tư thế để duy trì thăng bằng. Hiệu quả của việc co cơ này được kiểm soát bằng phản hồi cảm giác từ các khớp, các điểm nối gân cơ, cân mạc, da tới hệ thống thần kinh trung ương.

Các hoạt động điều hợp chi dưới khi đứng và đi

- Tập đi được bắt đầu bằng luyện tập các nội trình cơ bản của thăng bằng và lấy lại thăng bằng. Cần phải hỗ trợ an toàn để người bệnh tập trung vào các cử động chủ ý được yêu cầu mà không bị phân tán vào hoạt động của các cơ khác để duy trì thăng bằng.

- Tập thăng bằng tĩnh cơ bản bắt đầu với đứng trên hai chân và thăng bằng bằng hai tay, sau đó chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia và tiến đến trọng lượng dồn hoàn toàn trên một chân trong khi tay dùng chỉ để giữ thăng bằng.

- Tập thăng bằng động trong thanh song song bằng cách đưa người về phía trước, ra sau, sang hai bên.

- Tập thăng bằng động tăng tiến trên những chân đế nhỏ hơn bằng gậy bốn chân hỗ trợ, cho đến khi người bệnh có thể chịu trọng lượng trên một chân hoàn toàn với thăng bằng trên một tay hỗ trợ.

- Chuyển trọng lượng và thăng bằng về trước một bước, ra sau một bước, quay sang bên này và bên kia phải được tập cho đến khi người bệnh thực hiện một cách tự động.

- Tập với nhạc nhịp điệu hàng ngày như nâng một chân, nâng một tay, nâng tay và chân đồng thời, bước về phía trước, bước ra sau, gấp gối, thẳng gối sẽ tạo ra nội trình điều hợp cơ bản trong mẫu đi.

- Khi đi, thăng bằng được di chuyển và tái thành lập trong mỗi bước. Duy trì thăng bằng đòi hỏi sự phối hợp một cách tự động các hoạt động điều hợp của nhiều cơ không chỉ ở các khớp của các chi mà còn của cổ và thân nữa.

- Nếu người bệnh sử dụng hai nạng hay hai gậy thì chân đế được kéo rộng, nhu cầu thăng bằng sẽ giảm xuống, nhưng điều hợp phải hiện diện để điều hòa tứ chi và thân khi đi.

6.6. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Không để người bệnh bị mỏi cơ và xuất hiện các cử động thay thế hoặc sai mẫu.

- Ngã nếu người bệnh thăng bằng kém: Cần đặt người bệnh trong tư thế thoải mái và vững chắc khi tập

- Đau cơ: thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

59 TẬP MẠNH CƠ ĐÁY CHẬU (CƠ SÀN CHẬU, PELVIC FLOOR)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tập cơ đáy chậu là tập luyện sự siết chặt và thư giãn lặp lại một cách chủ động có chọn lọc các cơ vùng đáy chậu. Phục hồi chức năng cơ vùng đáy chậu là một phương pháp quan trọng để kiểm soát rỉ tiểu.

- Bài tập làm mạnh cho các cơ vùng đáy chậu hay còn gọi là bài tập Kegel có thể đem lại lợi ích cho cả nam giới và phụ nữ, đặc biệt với những người không kiểm soát được tiểu tiện. Ở nữ giới bài tập Kegel hay được áp dụng hơn nhằm kiểm soát tốt hơn khi tăng áp lực trong ổ bụng ví dụ khi ho, hắt hơi, cười và giúp phụ nữ lấy lại tự tin, nhất là sau khi sinh con. Tuy nhiên, việc tập luyện chương trình Kegel cần thực hiện một cách chính xác và đều đặn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau hoặc có cảm giác bị sa âm đạo

- Sa sinh dục ở nữ giới

- Tiểu không tự chủ

- Rối loạn tiểu tiện sau tổn thương não

- Rối loạn tiểu tiện sau tổn thương tuỷ sống

- Rỉ tiểu gắng sức, rỉ tiểu gấp

- Rỉ tiểu sau phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến, sau phẫu thuật vùng tiểu khung, sau xạ trị

- Rỉ tiểu do bệnh lý đái tháo đường

- Hội chứng đuôi ngựa

- Người bệnh đi tiểu nhiều lần

- Người bệnh đại tiện không tự chủ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh bị bệnh tim nặng

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ

ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang y tế
- Ga trải giường, gối kê
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn
- Khăn lau tay
- Bông, gạc y tế
- Tấm lót

5.4. Thiết bị y tế

- Giường tập,
- Ghế ngồi

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện : mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ... người bệnh hiểu và tích cực tham gia tập luyện kiên trì theo chương trình tập.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án, phiếu chỉ định của bác sĩ

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 30-60 phút (ước tính 0,50-1,00 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

Người bệnh có thể tiến hành bài tập ở bất kỳ đâu, thời gian nào trong ngày, nhưng người bệnh thường tập trên ghế, trong nhà vệ sinh hay trên giường. Bài tập cơ đáy chậu chia làm hai phần: giai đoạn làm chậm và giai đoạn làm nhanh. Sau khi người bệnh làm các động tác chậm tốt sẽ chuyển sang giai đoạn làm nhanh.

6.1 Bài tập chậm cơ vùng đáy chậu với người hướng dẫn

- Siết chặt và kéo nhóm cơ vùng lưng lên, động tác này giúp người bệnh có thể tự

kiểm soát trung tiện được. Lưu ý hướng dẫn người bệnh tránh co thắt nhóm cơ vùng mông, đùi và nhóm cơ bụng trong khi tập động tác này.

- Tiếp theo, người bệnh sẽ siết chặt và kéo nhóm cơ quanh âm đạo và niệu đạo, động tác này giúp cho người bệnh có thể tự ngừng đi tiểu. Để xác định đúng cơ, đưa ngón tay trỏ vào trong âm đạo cho đến khi cảm nhận được áp lực vào ngón tay khi người bệnh tập bài tập này. Nếu chưa rõ người bệnh cố nhịn tiểu hoặc nhịn tiểu giữa dòng để cảm nhận rõ hơn.

- Giữ ở tư thế này và yêu cầu người bệnh đếm chậm từ 1 đến 5, nhớ không nhịn thở trong khi làm động tác này, điều này rất quan trọng giúp người bệnh thở bình thường

- Sau khi đếm đến 5, người bệnh từ từ thư giãn hoàn toàn

- Lặp lại động tác này 5 lần

6.2 Bài tập nhanh cơ vùng đáy chậu với người hướng dẫn

- Siết chặt và kéo nhanh nhóm cơ đáy chậu như đã làm trên

- Giữ tư thế này khoảng 1 đến 2 giây sau đó từ từ thư giãn

- Lặp lại các động tác của giai đoạn chậm và nhanh ít nhất 5-10 lần hoặc cho đến khi người bệnh thấy mỏi cơ

Những điểm lưu ý

- Trong khi thực hiện bài tập người bệnh thường quá tập trung theo người hướng dẫn để có thể làm đúng các bài tập nên nhóm cơ đáy chậu rất dễ mỏi. Tuy nhiên, nếu người bệnh tập đều đặn sau một thời gian sẽ thấy làm đơn giản và nhẹ nhàng hơn, không cần bất kỳ sự gắng sức nào. Người bệnh phải nhớ thư giãn và thở bình thường khi thực hiện bài tập với các cơ vùng đáy chậu.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Theo dõi và hướng dẫn người bệnh làm đúng động tác, kiểm tra từng giai đoạn để sửa những sai sót của người bệnh tránh thành thói quen xấu, không có hiệu quả

- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lí trị liệu.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

60 KỸ THUẬT TẬP SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KHIỂN XE LĂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Xe lăn là phương tiện để nâng đỡ cơ thể và giúp cho người bệnh di chuyển được dễ dàng, giảm thiểu hậu quả của việc bất động hay nằm lâu và tạo điều kiện cho người bệnh phấn khởi trở lại các sinh hoạt hàng ngày, giúp đỡ họ có cơ hội bình đẳng, tái hội nhập tham gia vào các hoạt động trong gia đình, xã hội

2. CHỈ ĐỊNH

- Liệt tứ chi
- Liệt hai chân.
- Vết thương chưa lành.
- Thời kỳ dưỡng sức (bệnh tim).
- Thời kỳ không chịu sức nặng (gãy xương).
- Cụt hai chân

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Loét ở vùng mông.
- Tư thế bị biến dạng (vẹo cột sống hay gù lưng).
- Thoát vị đĩa đệm cấp.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Tấm ván lướt
- Đai thắt lưng an toàn
- Khẩu trang y tế
- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn
- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Xe lăn tay

- Thanh song song.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành... để người bệnh hợp tác

- Trang phục gọn gàng.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Lượng giá tổng quát và khả năng tập của người bệnh.

- Có chỉ định tập sử dụng và di chuyển bằng xe lăn.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15-30 phút (ước tính 0,25-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng, khu vực thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.4. Cách xếp xe lăn

- Đẩy miếng nâng đỡ gót chân ra trước trên chỗ tựa chân.

- Dựng tấm tựa chân lên cho thẳng góc với mặt sàn nhà.

- Kéo tấm đệm ngồi lên cho đến khi xe lăn xếp lại gọn gàng.

- Xếp gọn tấm đệm ngồi giữa hai thanh hai bên chỗ ngồi.

6.5. Cách mở xe lăn

Đẩy hai thanh hai bên chỗ ngồi xuống cho đến khi mặt ghế được căng hoàn toàn.

Nếu cố gắng mở xe bằng cách kéo hai thanh bên chỗ ngồi ra hai bên sẽ gây hư hại cho phần gắn tấm tựa tay (ở loại tháo rời ra được).

6.6. Cách điều khiển xe lăn

a) Cách đẩy xe lăn

- Cầm hai tay nắm và ấn chân vào cần nâng để hai bánh xe nhỏ rời khỏi mặt sàn.

- Tiếp tục cầm hai tay nắm và lăn xe trên hai bánh xe lớn.

b) Cách đẩy xe lên xuống lề đường

- Đẩy lên:

+ Xe lăn hướng mặt về phía lề đường.

+ Cầm hai tay nắm, ấn chân lên cần nâng xe để xe nghiêng ra sau trên hai bánh xe lớn.

+ Đặt hai bánh xe nhỏ lên bậc thềm.

+ Cầm tay nắm, nâng và lăn xe về phía trước lên lề đường.

- Đẩy xuống :

+ Đặt mặt xe hướng về phía lề đường.

+ Cầm hai tay nắm và ấn chân lên cần nâng xe để cho xe nghiêng ra sau trên hai bánh xe lớn.

+ Lăn chậm xe xuống khỏi lề đường.

+ Hạ hai bánh xe nhỏ xuống lòng đường.

c) Cách lên xuống đường dốc

- Với 1 độ dốc trung bình = độ cao/chiều dài = 1/12 thì không có cách di chuyển đặc biệt.

- Với những người bệnh yếu, khi xuống dốc có thể bị ngã ra trước. Trường hợp này nên đề nghị người bệnh xuống hướng lưng (đi lùi). Nếu xe lăn có loại thắng xe từng nấc, nên đặt ở vị thế cho phép xe lăn xuống từ từ.

6.4. Kết thúc điều trị: Kiểm tra tình trạng người bệnh, hướng dẫn người bệnh, ghi chép hồ sơ bệnh án.

6.7. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Dùng dây thắt lưng an toàn giúp cho người bệnh khỏi ngã về phía trước trong trường hợp cơ duỗi lưng bị yếu.

- Xe lăn bị trượt vì người bệnh không dùng phanh hay phanh bị hư.

- Xe lăn bị chổng là tai nạn thường xảy ra khi người bệnh ngồi vào xe lăn hay ra khỏi xe lăn. Nguyên nhân là do người bệnh bước chân lên miếng tựa chân. Do đó, để an toàn cần phải xoay miếng tựa chân qua một bên khi người bệnh bước vào hay rời khỏi xe lăn, hoặc có người giữ chỗ phía sau lưng xe.

- Đau cơ: Thuốc giảm đau, nghỉ ngơi, các biện pháp vật lý trị liệu.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

61 TẬP CÁC VẬN ĐỘNG THÔ CỦA BÀN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Bàn tay là công cụ đặc biệt giúp chúng ta thực hiện được các hoạt động sống hàng ngày. Chính vì vậy khi mất hoặc giảm chức năng bàn tay, hơn tất cả các vùng khác trên cơ thể, bàn tay cần phải được chú ý, điều trị và phục hồi chức năng sớm và tốt nhất.

2. CHỈ ĐỊNH

- Bàn tay mất hoặc giảm chức năng vận động.Thường ở giai đoạn sớm sau khi bị bệnh, những khiếm khuyết vận động ở tay khiến có rất ít cử động của tay. Do vậy, những bài tập sử dụng các hoạt động có lựa chọn để tăng cường cơ lực với những cử động nhắc lại, nhằm vào những cơ yếu sẽ giúp xuất hiện các cử động mới ở tay.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang trong giai đoạn cấp của bệnh.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Bóng mềm

- Ly/Cốc

- Khối gỗ hình trụ…

- Khay đựng đồ vật

- Gương tập

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế: Bàn tập

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành...

- Tư thế người bệnh phải thoải mái, tốt nhất là ở tư thế ngồi.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

Bước 1: Lượng giá khiếm khuyết bàn tay của người bệnh

Bước 2: Phân tích ảnh hưởng của khiếm khuyết bàn tay lên chức năng:

- Mất hoặc giảm khả năng đưa tay với đồ vật?

- Có cầm nắm, buông đồ vật bằng bàn tay?

- Có thực hiện được các chức năng sinh hoạt hàng ngày không ?

Bước 3: Lập mục tiêu điều trị tổng quát thích hợp

- Đưa tay với được đồ vật: trợ giúp hoàn toàn hoặc 1 phần

- Cầm nắm và buông đồ vật: trợ giúp hoàn toàn hoặc 1 phần

- Buông đồ vật ra: trợ giúp hoàn toàn hoặc 1 phần

Bước 4: Lập chương trình điều trị theo mục tiêu.

Bước 5: Thực hiện chương trình điều trị:

- Đưa tay với đồ vật cần lấy

- Cầm nắm bằng cách móc đồ vật (quai túi, quai vali…)

- Cầm nắm dọc theo đồ vật hình trụ (cán búa, miếng gõ hình trụ…)

- Cầm kẹp bên (quyển sách, thẻ ngân hàng…)

- Cầm đồ vật hình cầu (bóng, trái cây, bóng đèn….)

- Tập buông đồ vật như đã kể trên

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Theo dõi

a) Trong khi tập

- Xem người bệnh có đau, khó chịu.

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở và tình trạng toàn thân.

- Theo dõi hàng ngày và ghi vào hồ sơ bệnh án theo dõi.

- Báo cho bác sĩ những diễn biến bất thường.

b) Sau khi tập

- Người bệnh có đau và đau kéo dài.

- Theo dõi tiến triển của tầm vận khớp.

- Theo dõi hàng ngày và ghi vào hồ sơ bệnh án theo dõi.

- Báo cho bác sĩ những diễn biến bất thường…

Xử trí tai biến

- Trong khi tập: kết quả làm người bệnh bị mệt, đau thì ngừng tập và theo dõi sát người bệnh.

- Sau khi tập: mệt, đau kéo dài và tình trạng toàn thân người bệnh có biểu hiện bất thường thì ngừng tập và xử trí tai biến đó.

- Nếu đau chi trên nhiều thì sử dụng thuốc và các biện pháp vật lý giảm đau.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu và cộng sự, 2019, “Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng”, NXB Y học.

62 TẬP CÁC VẬN ĐỘNG KHÉO LÉO CỦA BÀN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Bàn tay là công cụ đặc biệt giúp chúng ta thực hiện được các hoạt động sống hàng ngày. Chính vì vậy khi giảm chức năng bàn tay, hơn tất cả các vùng khác trên cơ thể, bàn tay cần phải được chú ý, điều trị và phục hồi chức năng sớm và tốt nhất.

2. CHỈ ĐỊNH

- Mất hoặc giảm chức năng khéo léo của bàn tay.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang trong giai đoạn cấp của bệnh

4. THẬN TRỌNG:

- Đánh giá đau, thăng bằng, nhận thức, khả năng chịu tải và giới hạn sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bố trí người hỗ trợ theo nguy cơ ngã; không ép vận động vượt mức được chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện:

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Đồ vật có các hình dạng kích thước khác nhau: Đồ vật có các hình dạng kích thước nhỏ, nhẹ, hình dạng dẹt: Chìa khóa, miếng vải, cán thìa, bút có nắp, nút bấm của điện thoại, quyển sách dày, kim chỉ, hạt đỗ, hạt gạo, kẹp giấy….

- Giường tập.

- Khay đựng đồ vật.

- Gương tập

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Bàn tập

- Ghế tập

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành...

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

Bước 1: Lượng giá khiếm khuyết bàn tay của người bệnh

Bước 2: Phân tích ảnh hưởng của khiếm khuyết bàn tay lên chức năng:

- Mất hoặc giảm khả năng đưa tay với đồ vật?

- Có cầm nắm, buông đồ vật bằng bàn tay?

- Có thực hiện được các chức năng sinh hoạt hàng ngày không?

Bước 3: Lập mục tiêu điều trị tổng quát thích hợp.

- Tách rời ngón.

- Cầm nắm đồ vật bằng các cách.

- Kẹp đồ vật.

Bước 4: Lập chương trình điều trị theo mục tiêu.

Bước 5: Thực hiện chương trình điều trị

- Tách rời các ngón tay (ấn số lên bảng số của máy điện thoại, gõ lên bàn phím máy vi tính...)

- Cầm lấy đồ vật ở khe ngón (kẹp một điếu thuốc lá...)

- Kẹp một bên hoặc cầm nắm với ngón cái và ngón trỏ (cầm một chìa khóa, cắt thịt...)

- Đối chiếu ngón cái ngón trỏ (sờ lên vải, lật trang sách...)

- Kẹp tròn (nhặt hạt, xâu chỉ vào lỗ kim, lấy kẹp giấy trên bàn...)

- Kẹp ba ngón (Viết, cuốn điếu thuốc lá...)

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Theo dõi

a) Trong khi tập

- Xem người bệnh có đau, khó chịu.

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở và tình trạng toàn thân.

- Theo dõi hàng ngày và ghi vào hồ sơ bệnh án theo dõi

- Báo cho bác sĩ những diễn biến bất thường.

- Theo dõi tiến triển về cơ lực, sức bền.

b) Sau khi tập

- Người bệnh có đau và đau kéo dài.

- Theo dõi tiến triển của tầm vận khớp.

- Theo dõi hàng ngày và ghi vào hồ sơ bệnh án theo dõi

- Báo cho bác sĩ những diễn biến bất thường...

- Theo dõi tiến triển về cơ lực sức bền.

Xử trí tai biến

a) Trong khi tập: kết quả làm người bệnh bị đau thì ngừng tập và theo dõi sát người bệnh.

b) Sau khi tập: đau kéo dài và tình trạng toàn thân người bệnh có biểu hiện bất thường thì ngừng tập và xử trí tai biến đó.

- Nếu đau chi trên nhiều thì sử dụng thuốc và các biện pháp vật lý giảm đau.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

63 LƯỢNG GIÁ LAO ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP

1. ĐẠI CƯƠNG

- Theo Tổ chức Lao động quốc tế, lượng giá hướng nghiệp là nhằm xác định mối quan tâm, khả năng, thái độ và kỹ năng của một cá nhân để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, nhu cầu và tiềm năng trong công việc của cá nhân đó.

- Lượng giá hướng nghiệp có thể sử dụng các kỹ thuật đã được chuẩn hóa (các bài kiểm tra) hoặc các cách tiếp cận thông thường (qua phỏng vấn, quan sát). Đây là một phần của quá trình hướng dẫn nghề nghiệp và thường dẫn đến các khuyến nghị cho đào tạo nghề hoặc tuyển dụng.

- Lượng giá hướng nghiệp giúp người khuyết tật lựa chọn nghề nghiệp hoặc học nghề phù hợp, giúp các nhà tư vấn, các chuyên gia phục hồi chức năng và cán sự việc làm thực hiện hiệu quả hơn, giúp cho các giáo viên dạy nghề điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của người khuyết tật, giúp các nhân viên hành chính sử dụng nguồn lực thông minh hơn và giúp các nhà tuyển dụng có lực chọn tốt hơn.

- Lượng giá hướng nghiệp được thực hiện khi người khuyết tật còn ở trong độ tuổi lao động, có khả năng độc lập trong sinh hoạt và có khả năng giao tiếp ở mức hiểu người khác hoặc thể hiện được nhu cầu tình cảm mà người khác hiểu được. Lượng giá hướng nghiệp giúp cho phục hồi chức năng có mục tiêu cụ thể hơn và là cơ sở để tư vấn hướng nghiệp trước khi người bệnh ra khỏi chương trình can thiệp.

2. CHỈ ĐỊNH

Lượng giá hướng nghiệp có thể được thực hiện tại các cơ sở y tế hoặc tại cộng đồng.

* Tại các cơ sở y tế: lượng giá hướng nghiệp được thực hiện nhằm chuẩn bị cho người khuyết tật trưởng thành, người bệnh tâm thần tái hòa nhập/hòa nhập xã hội.

* Tại cộng đồng: lượng giá hướng nghiệp là bước đầu tiên để giúp người khuyết tật trưởng thành tìm được việc làm phù hợp, hòa nhập cộng đồng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người không ở trong độ tuổi lao động

4. THẬN TRỌNG

- Chọn công cụ phù hợp nhận thức, ngôn ngữ, học vấn và nghề nghiệp; không dùng một kết quả đơn lẻ để kết luận khả năng lao động.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ

ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Khẩu trang y tế

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người nhà về cuộc lương giá và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc làm (như bằng cấp văn hóa, chứng chỉ, hồ sơ sức khỏe...)

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30-60 phút (ước tính 0,50-1,00 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, cộng đồng

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

Theo quy trình lượng giá hướng nghiệp của tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã giới thiệu, gồm 10 bước như sau:

1. Phỏng vấn người khuyết tật

2. Xem xét giấy tờ về kinh nghiệm làm việc. Xem xét việc học hành hoặc các giấy tờ liên quan tới giáo dục hoặc các khóa tập huấn đã tham gia

3. Khám sức khỏe chứng nhận đủ sức khỏe làm việc

4. Sử dụng các trắc nghiệm về năng lực và năng khiếu và, nếu có thể, các trắc nghiệm tâm lí.

5. Tìm hiểu một cách chắc chắn hoàn cảnh cá nhân và gia đình

6. Tìm hiểu năng khiếu và sự phát triển khả năng qua kinh nghiệm làm việc và qua các cách khác

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn

phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. Các trắc nghiệm công việc, hoặc bằng lời hoặc bằng cách khác khi cần thiết.

8. Phân tích khả năng thể chất trong mối tương quan với yêu cầu của công việc và khả năng cải thiện năng lực đó.

9. Cung cấp thông tin liên quan đến các cơ hội việc làm và đào tạo nghề liên quan đến trình độ, khả năng về thể chất, năng khiếu, sự ưa thích và kinh nghiệm của cá nhân, nhu cầu của thị trường việc làm.

10. Thảo luận cùng người khuyết tật về những việc phù hợp với họ để họ là người ra quyết định

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Không cần theo dõi sau khi lượng giá. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh tâm lí làm người khuyết tật thất vọng.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

64 THỬ CƠ BẰNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Định nghĩa

Thử cơ bằng tay **(Mannual Muscle Testing)** là phương pháp dùng tay người khám để đánh giá khả năng co cơ chủ động hay cơ lực của một cơ hoặc một nhóm cơ cụ thể của người bệnh.

1.2. Bảng phân độ cơ lực bằng phương pháp thử cơ bằng tay

Bậc cơ	Tiêu chí đánh giá
5	Người bệnh co cơ thực hiện hết tầm vận động khớp ở tư thế kháng trọng lực, thắng được lực đề kháng tối đa từ phía người khám
4	Người bệnh co cơ thực hiện hết tầm vận động khớp ở tư thế kháng trọng lực, thắng được lực đề kháng tương đối mạnh từ phía người khám
3	Người bệnh co cơ thực hiện hết tầm vận động khớp ở tư thế kháng trọng lực, không có lực đề kháng từ phía người khám
2	Người bệnh co cơ thực hiện hết tầm vận động khớp ở tư thế loại bỏ trọng lực tác động lên chi thể
1	Người khám có thể nhìn hoặc sờ thấy sự co cơ nhưng không có sự vận động nào của khớp
0	Không sờ/nhìn thấy sự co cơ nào

2. CHỈ ĐỊNH

- Liệt do tổn thương thần kinh trung ương
- Liệt do tổn thương thần kinh ngoại biên
- Liệt do bệnh cơ
- Một số bệnh lý cơ xương khớp khác có ảnh hưởng đến chức năng vận động
- Yếu cơ do nằm lâu, sau thở máy kéo dài
- Yếu cơ thứ phát do các bệnh hô hấp mạn tính

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương chưa liền
- Ngay sau phẫu thuật, giai đoạn liền tổn thương
- Tăng trương lực cơ quá nhiều
- Người bệnh tổn thương khả năng nhận thức hoặc kiểm soát hành vi, không có khả năng phối hợp với người đánh giá

4. THẬN TRỌNG

- Đau, co cứng, hạn chế tầm vận động hoặc giảm hợp tác có thể làm sai kết quả; ghi rõ yếu tố ảnh hưởng, không cố dùng lực tối đa.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Phiếu thử cơ

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Bàn khám

- Mặt phẳng ít ma sát

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh phải thoải mái, tốt nhất là ở tư thế nằm hoặc ngồi.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, Buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Hướng dẫn người bệnh về những thao tác sẽ thực hiện để người bệnh phối hợp tốt với người đánh giá.

- Đặt tư thế người bệnh sao cho phù hợp với từng nhóm cơ và bậc thử cơ.

- Cố định tốt để tránh vận động thay thế của các nhóm cơ khác.

- Đánh giá sơ bộ tầm vận động thụ động của khớp liên quan

- Yêu cầu người bệnh thực hiện hết tầm vận động khớp theo các tư thế và lực đề kháng khác nhau tùy thuộc vào bậc thử cơ

- Kết hợp nhìn, sờ, tạo lực đề kháng tùy thuộc vào bậc thử cơ

- Thử các cơ ở gốc chi trước, ngọn chi sau

- Thực hiện thử cơ ở cả 2 bên cơ thể để đối chiếu

- Quan sát, cho điểm từng nhóm cơ theo thang điểm từ 0 đến 5

- Điền vào phiếu thử cơ

- Ghi lại ngày giờ đánh giá. Ký, ghi rõ họ tên người đánh giá.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tiến hành thử cơ định kỳ trong suốt thời gian nằm viện và khi người bệnh xuất viện. Theo dõi sự tiến triển về cơ lực của người bệnh.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

65 ĐO TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: Đo tầm vận động khớp là kỹ thuật lượng giá tầm vận động của khớp.

- Đo tầm vận động khớp là một trong những phương pháp lượng giá quan trọng trong thực tiễn khám, lượng giá và đánh giá tiến triển bệnh, kết quả điều trị.

- Phương pháp đo và ghi dựa trên nguyên tắc của phương pháp Zero (0) của Can và Robert, có nghĩa là ở vị trí giải phẫu, mọi khớp được quy định là 0°.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thương tật về hệ thống vận động.

- Những tổn thương thần kinh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Bảo vệ khớp sau chấn thương hoặc phẫu thuật; đo trong giới hạn được phép, tránh ép khớp vượt đau và ghi đúng tư thế đo.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Thước đo góc 180° hay 360°

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành...

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30-60 phút (ước tính 0,50-1,00 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Đặt chi, khớp cần đo ở vị trí Zero.

- Xác định đặc tính của khớp thuộc loại khớp nào.

- Xác định 3 điểm mốc cố định để đặt thước cho chính xác.

- Tiến hành đo.

- Ghi kết quả vào bệnh án: sự giới hạn tầm vận động được ghi từ vị trí khởi đầu đến cuối tầm. Ví dụ: gấp khuỷu từ 30º - 90º được ghi 30º - 90º

- Cần ghi rõ vận động khớp là:

+ Chủ động.

+ Thụ động.

+ Có hay không kèm theo cưỡng bức một phần hay toàn bộ.

+ Khi cử động có đau không.

+ Có tình trạng kháng lại cử động có ý thức không.

+ Người bệnh có khả năng hợp tác với bác sỹ không.

- Cần lập bảng số đo trung bình hay bình thường của tầm vận động.

- Cần ghi rõ tầm vận động chính xác đo được.

- Tầm vận động chi đo được so sánh với bên đối diện. Sự khác biệt được diễn tả bằng độ hay tỷ lệ phần trăm bị giảm tầm vận động so với chi bên đối diện. Nếu không có chi bên đối diện thì so với tầm vận động trung bình của một người

khác cùng tuổi, cùng thể tạng.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tình trạng chung của người bệnh.

- Tình trạng tại khớp đang đo

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

66 ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP VÀO ĐIỂM VẬN ĐỘNG VÀ HUYỆT ĐẠO

1. ĐẠI CƯƠNG

- Laser là một hình thức điều trị bằng nguồn ánh sáng đơn sắc đặc biệt. Cơ chế tạo ra tia laser dựa trên hiện tượng khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức. Trong phục hồi chức năng thường sử dụng các laser công suất thấp có hiệu ứng kích thích sinh học nhằm điều chỉnh lại các rối loạn hoạt động của mô bị tổn thương, tăng cường sức đề kháng và tái tạo lại mô. Laser thường sử dụng là laser khí He-Ne và các laser bán dẫn (*semi-conductor laser*) phát tia trong vùng ánh sáng đỏ hoặc vùng hồng ngoại (gần).

- Laser công suất thấp có thể dùng chiếu ngoài, chiếu nội mạch hoặc chiếu trên các điểm vận động và huyệt đạo (*laser châm*) để điều trị bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chống viêm: viêm cấp tính, bán cấp hay mạn tính, viêm của tổ chức phần mềm (da, cơ), xương khớp, nội tạng...

- Giảm đau: đau do chấn thương, đau thần kinh, đau xương khớp, đau điểm...

- Kích thích tái tạo mô, làm nhanh liền sẹo vết thương, vết loét.

- Điều hòa tuần hoàn và hoạt hóa hệ thần kinh trung ương (*laser nội mạch*).

- Điều trị trên huyệt đạo (*laser châm*): chỉ định vị trí huyệt giống như huyệt dùng trong châm cứu.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh ác tính nặng, sốt, bệnh truyền nhiễm cấp tính.

- Trực tiếp lên vùng đang chảy máu hoặc đe dọa chảy máu.

4. THẬN TRỌNG

- Vùng tổn thương u ác tính, lao đang hoạt động.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Băng dính cố định đầu chiếu tia laser.

- Dụng cụ dẫn tia laser: dây quang sợi và/hoặc đầu mở rộng tia.

- Đầu chiếu tia laser: dạng ống, bút, kim laser.

- Găng tay

- Mũ giấy

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

5.4. Thiết bị y tế: Máy laser công suất thấp: laser He-Ne hoặc laser bán dẫn.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh phải thoải mái, tốt nhất là ở tư thế nằm hoặc ngồi.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 10-20 phút (ước tính 0,17-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Chọn các tham số kỹ thuật cần thiết tùy theo loại laser, bao gồm:

- Bước sóng laser.

- Công suất đầu phát laser.

- Chế độ phát xung hay liên tục, tần số lặp lại xung.

- Cường độ chùm tia laser: tính bằng mật độ công suất (với laser liên tục) hay mật độ năng lượng (với laser xung).

- Đặt thời gian điều trị (tự động trên máy hay bằng đồng hồ hẹn giờ bên ngoài).

6.2. Chiếu chùm tia laser vào vùng điều trị (qua dây quang sợi hoặc đầu mở rộng tia). Áp dụng các kỹ thuật chiếu laser

- Chiếu chùm: chiếu chùm tia laser bao phủ lên toàn bộ bề mặt vùng tổn thương bằng đầu mở rộng tia hoặc bằng kỹ thuật quét chùm tia laser (di chuyển hình xoáy ốc hoặc hình dích dắc).

- Chiếu điểm: chiếu chùm tia laser trực tiếp lên vị trí điểm vận động.

- Chiếu lên huyệt (laser châm): chiếu chùm tia laser trực tiếp lên vị trí của huyệt đạo. Áp dụng công thức huyệt giống như trong châm cứu theo Y học cổ truyền.

Lưu ý: Chùm tia laser phải được chiếu vuông góc với bề mặt da bộ phận cơ thể điều trị. Có thể dùng băng dính cố định đầu phát tia lên bề mặt da tại vị trí huyệt đạo trong quá trình điều trị. Tránh để chùm tia laser chiếu trực tiếp vào mắt có thể làm tổn thương võng mạc đáy mắt.

* Thời gian điều trị phụ thuộc vào loại bệnh lý, cường độ của đèn laser.

6.3. Kết thúc điều trị

- Khi hết thời gian điều trị: chỉnh cường độ về "0" rồi tắt công tắc nguồn.

- Một số máy có chế độ hẹn giờ tự động, thì máy sẽ tự động ngừng phát tia khi hết thời gian điều trị mà vẫn giữ nguyên giá trị của các tham số kỹ thuật cho lần điều trị tiếp theo.

- Tháo đầu phát laser khỏi vị trí điều trị. Khử trùng đầu phát và dây quang sợi bằng cồn 70 độ rồi đặt về vị trí bảo quản.

- Kiểm tra vị trí chiếu tia xem có biểu hiện gì bất thường hay không.

- Dặn dò người bệnh những điều cần thiết trước khi về.

6.4. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi hoạt động của máy, các thông số, chùm tia.

- Phản ứng của người bệnh, đặc biệt khi chiếu trên huyệt (laser châm).

- Ghi chép diễn biến sau điều trị: tình trạng người bệnh, tình trạng vùng điều trị.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu và cộng sự, 2019, "Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng", NXB Y học.

67 TẬP VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cột sống là một cấu trúc xương gồm nhiều đốt sống chồng lên nhau, có nhiệm vụ nâng đỡ cơ thể, vận động và bảo vệ tủy sống. Có tổng cộng 32-34 đốt sống trong cột sống, gồm 7 đốt sống cổ, 12 đốt ngực, 5 đốt thắt lưng, 5 đốt sống cùng và 3-5 đốt sống cụt. Cột sống có bốn đoạn cong lồi lõm xen kẽ nhau gồm đoạn cổ và đoạn thắt lưng cong lồi ra trước, đoạn ngực và đoạn cùng cụt cong lồi ra sau.

- Tập vận động cột sống có vai trò rất quan trọng trong điều trị bệnh lý tại cột sống hoặc các bộ phận liên quan đến cột sống. Tùy từng bệnh, tùy từng mục đích khác nhau mà có những bài tập phù hợp với mục đích đó.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cong vẹo cột sống do bẩm sinh hoặc mắc phải.

- Thoái hóa cột sống.

- Hội chứng chèn ép rễ do thoát vị đĩa đệm như đau thần kinh tọa, hội chứng cổ vai cánh tay.

- Hạn chế vận động cột sống sau can thiệp phẫu thuật.

- Các bệnh lý của cơ liên quan đến tư thế và độ vững của đốt sống, cột sống.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- U đốt sống

- Chấn thương gây gãy, mất vững đốt sống.

- Người bệnh không hợp tác

4. THẬN TRỌNG

- Lao đốt sống

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Ga trải giường

- Gối kê

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Phòng tập phải thông thoáng nhưng đủ kín đáo để người bệnh và người hướng dẫn tập cảm thấy thoải mái dễ chịu.

- Giường tập

5.5. Người bệnh

- Giải thích cặn kẽ cho người bệnh tác dụng của bài tập.

- Người bệnh cần thoải mái và thư giãn

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 10-20 phút (ước tính 0,17-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

- Kiểm tra đúng phương pháp tập và những yêu cầu trong quá trình tập luyện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Chọn bài tập: dựa trên tình trạng bệnh của người bệnh, bác sĩ chỉ định tập bài tập phù hợp cho người bệnh.

* Đối với cong vẹo cột sống: bài tập mạnh vùng cơ yếu, kéo giãn cơ bị co rút co cứng, điều chỉnh lại tư thế cột sống.

* Đối với đau do thoái hóa cột sống: bài tập có tác dụng điều hòa lại trương lực cơ, kéo giãn cơ ức chế quá trình co rút cơ.

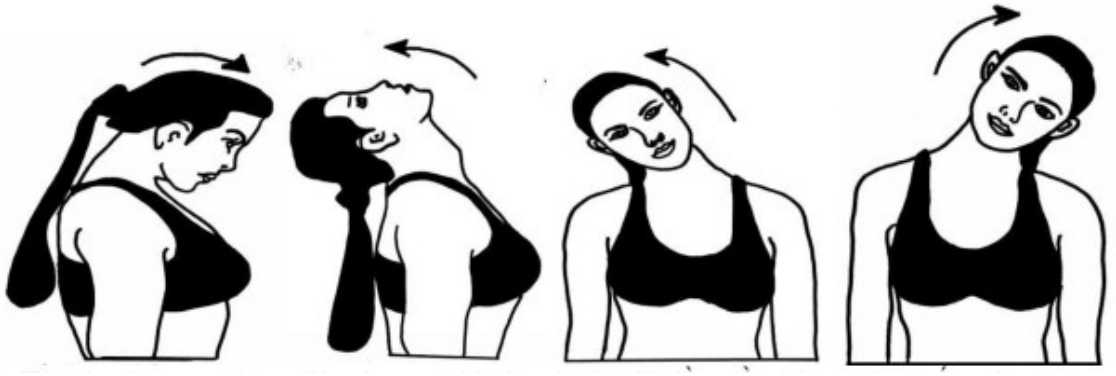
* Đối với bệnh lý cơ tại vùng cột sống: bài tập mạnh cơ yếu, kéo giãn cơ bị co rút.

6.2. Bài tập vận động cột sống cổ

Tư thế chuẩn bị

- Người tập ngồi thư giãn (thả lỏng) trên ghế có chiều cao phù hợp để hai bàn chân đặt sát trên sàn nhà, khớp cổ chân, khớp gối, khớp háng hai bên vuông góc, thân mình thẳng, đầu và cổ thẳng, hai vai ngang bằng nhau, hai tay duỗi dọc theo thân, trọng lượng dồn lên hai mông và hai chân.

Bài 1. Gấp và duỗi cột sống cổ



- Từ vị trí trung gian nói trên, người tập từ từ cúi đầu về phía trước (gấp cột sống cổ) càng nhiều càng tốt cho đến mức tối đa (cằm sát vào ngực nếu có thể) kết hợp với thở ra hết.

- Sau đó người tập từ từ ngửa đầu ra phía sau (duỗi cột sống cổ) càng nhiều càng tốt cho đến mức tối đa (mặt song song với trần nhà nếu có thể) kết hợp với hít vào sâu, rồi tiếp tục tập lại động tác gấp và duỗi như đã làm ở trên...

Bài 2. Nghiêng cột sống cổ sang bên phải và bên trái

- Từ vị trí ngồi trong tư thế chuẩn bị như trên, người tập từ từ nghiêng đầu và cổ sang bên phải càng nhiều càng tốt cho đến mức tối đa (tai bên phải chạm vai phải nếu có thể), kết hợp với hít vào sâu...

- Sau đó từ từ nghiêng đầu và cổ sang bên trái càng nhiều càng tốt cho đến mức tối đa (tai bên trái chạm vai trái nếu có thể) kết hợp với thở ra hết, rồi tiếp tục tập lại động tác nghiêng sang bên phải và bên trái như đã làm ở trên...

Bài 3. Quay cột sống cổ sang bên phải và bên trái

- Từ vị thế ngồi như trên trong tư thế chuẩn bị ban đầu, người tập quay mặt từ từ sang phía bên phải càng nhiều càng tốt cho đến mức tối đa (cằm ngang với mỏm vai phải nếu có thể) kết hợp hít vào sâu, sau đó...

- Từ vị trí này người tập từ từ quay mặt sang phía bên trái càng nhiều càng tốt cho đến mức tối đa (cằm ngang với mỏm vai trái nếu có thể) kết hợp với thở ra hết, rồi tiếp tục tập lại động tác quay sang bên phải và bên trái như đ làm ở trên...



Bài 4. Vận động đầu và cổ ra phía trước và về phía sau

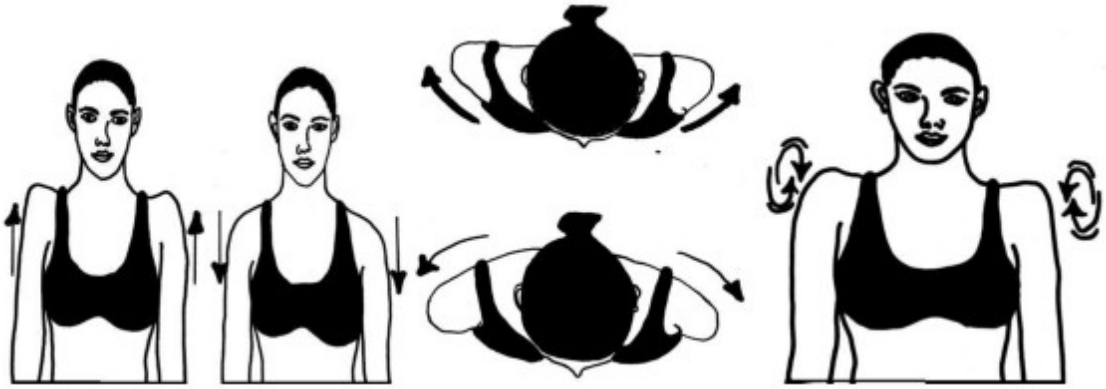
- Từ vị thế ngồi ở tư thế chuẩn bị ban đầu, người tập vận động "đưa" đầu ra phía sau đến mức tối đa (kết hợp hít vào), sau đó "đưa" đầu ra phía trước đến mức tối đa (kết hợp với thở ra), rồi tiếp tục tập lại như đã làm ở trên.

Bài 5. Tập vận động khớp vai

- Nâng khớp vai lên và hạ xuống: Từ vị thế ngồi như ở tư thế chuẩn bị ban đầu, người tập từ từ nâng vai lên phía trên đầu cho đến mức tối đa (kết hợp với hít vào sâu), sau đó hạ vai xuống trở về vị trí ban đầu (kết hợp với thở ra hết).

- Vận động hai vai ra trước và ra sau: Người tập ngồi như tư thế ban đầu hai tay dạng ngang vai vuông góc, hai khuỷu tay gấp vuông góc, cẳng tay quay sấp. Sau đó từ từ đưa hai khuỷu tay ra phía sau đến mức tối đa (kết hợp với thở ra hết), sau đó tiếp tục tập lại như ở trên.

- Xoay khớp vai: Người tập ngồi như trên trong tư thế chuẩn bị ban đầu, hai tay duỗi dọc theo thân mình, sau đó từ từ xoay tròn hai vai theo chiều từ sau ra trước, rồi xoay theo chiều ngược lại từ trước ra sau.



6.3. Bài tập cột sống thắt lưng (Bài tập Mc Gill)

Bài 1. Tư thế mô phỏng hình con mèo và con lạc đà

- Hai đầu gối quỳ, cẳng chân và bàn chân duỗi thẳng, hai tay duỗi thẳng lòng bàn tay tiếp xúc với sàn, lưng thẳng, mặt nhìn về phía trước.
- Hít vào và hóp cơ bụng, làm cong xương sống của bạn lên. Thu căm của bạn một chút và giữ căng trong 8 đến 10 giây.



- Thở ra và lưng cong xuống dưới và kéo ngực bạn lên và đi lên, giữ căng trong 8 đến 10 giây.

- Trở lại vị trí bắt đầu và lặp lại động tác đầy đủ 5 - 10 lần.

Bài 2. Cuộn đầu

- Nằm ngửa, thẳng người, đặt bàn tay hoặc một chiếc khăn cuộn ở dưới cột sống thắt lưng, gối chân phải gập lại chân trái duỗi thẳng.
- Nâng cao đầu và vai của bạn, không uốn cong lưng, giữ căng trong 8 đến 10 giây. Sau đó hạ đầu và vai xuống sàn.



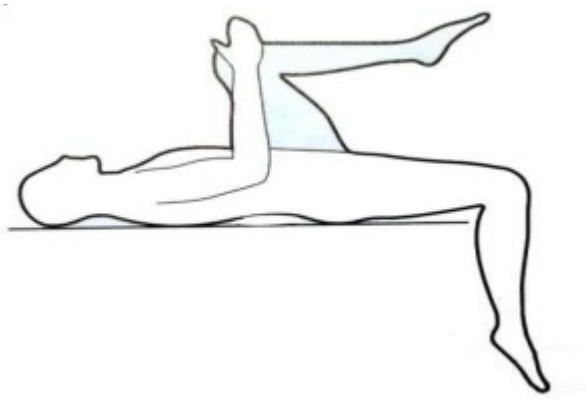
- Đổi chân và lặp lại động tác đầy đủ 5 - 10 lần.

Bài 3. Tư thế mô phỏng hình con chim và con chó



- Đầu gối dưới hông quỳ, bàn chân duỗi, hai tay duỗi thẳng lòng bàn tay tiếp xúc với sàn.
- Từ từ đưa chân trái ra sau trong khi đưa cánh tay phải về phía trước, giữ hông và vai căng trong 8 đến 10 giây. Sau đó trở lại vị trí bắt đầu.

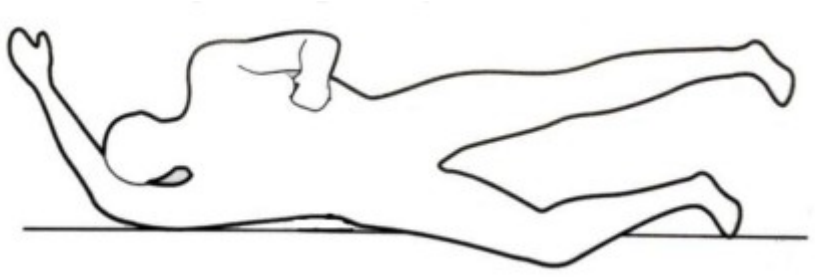
Bài 4. Tập căng cơ thắt lưng chậu



- Nằm thẳng người trên giường với hai đầu gối gấp vuông góc với cạnh giường.
- Bây giờ dùng hai tay kéo một chân lên ngực tư thế gối gấp trong khi giữ nguyên chân còn lại, giữ căng trong 8 đến 10 giây.
- Đổi chân và lặp lại động tác đầy đủ 5 - 10 lần.

Bài 5. Tập cơ căng mạc đùi

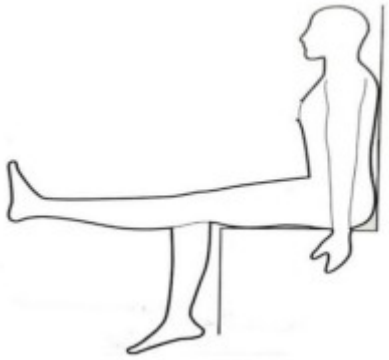
- Nằm thẳng nghiêng mình.
- Nâng chân phía trên thẳng lên trên trần cách từ 30 đến 50 cm từ chân kia, giữ căng trong 8 đến 10 giây.
- Hạ chân của bạn, nằm nghiêng sang bên đối diện.
- Đổi chân và lặp lại động tác đầy đủ 5 - 10 lần.



Bài 6. Tập căng cơ tam đầu đùi

- Người tập ngồi thư giãn (thả lỏng) trên ghế có chiều cao phù hợp để hai bàn chân đặt sát trên sàn nhà, khớp cổ chân, khớp gối, khớp háng hai bên vuông góc, thân mình thẳng, đầu và cổ thẳng, hai vai ngang bằng nhau, hai tay duỗi dọc theo thân, trọng lượng dồn lên hai mông và hai chân.
- Nâng chân trái lên duỗi thẳng, chân phải giữ nguyên, giữ căng trong 8 đến 10 giây.
- Chậm dần hạ chân xuống.

- Đổi chân và lặp lại động tác đầy đủ 5 - 10 lần.



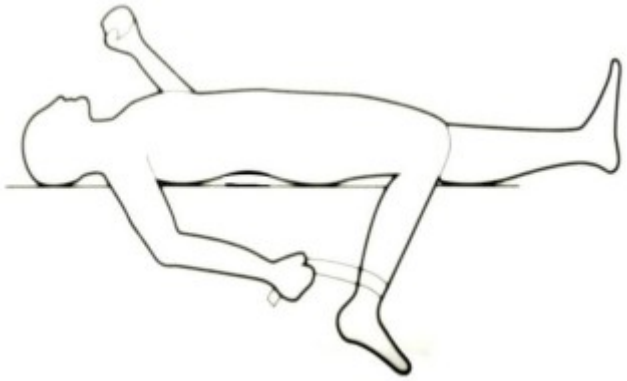
Bài 7. Tập căng cơthẳng đùi

- Nằm ngửa, thẳng người trên mép giường, tay và chân duỗi thẳng.

- Chân trái gấp xuống mép giường, chân phải giữ nguyên. Dùng dây vòng qua cổ chân trái hoặc tay nắm cổ chân trái gấp căng chân trái về phía lưng, giữ căng trong 8 đến 10 giây.

- Chậm dân duỗi chân trái. Trở về vị trí ban đầu.

- Đổi chân và lặp lại động tác đầy đủ 5 - 10 lần.



* Trong quá trình tập cần một số lưu ý:

- Đau thần kinh tọa: hạn chế cúi gập lưng.

- Hội chứng vai tay do chèn ép rễ hoặc đám rối thần kinh cánh tay: hạn chế động tác ngửa cổ vì dễ kích thích gây choáng chóng mặt.

- Các bài tập cột sống còn có vai trò duy trì và phòng chống đau thắt lưng hay vai gáy.

6.4. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬTRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Khả năng đáp ứng và thực hiện bài tập của người bệnh.

- Tình trạng đau hay mệt mỏi trong quá trình tập luyện.

- Sau tập có thể thấy đau tăng lên hoặc động tác tập gây đau tăng nên giảm cường độ hoặc mức độ tập hay loại bỏ những tư thế tập đau.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

68 KỸ THUẬT XOA BÓP BẰNG MÁY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xoa bóp bằng máy là sử dụng một nhóm các thủ thuật xoa nắn bằng máy hoặc chân không tại các mô của cơ thể một cách khoa học và hệ thống nhằm mục đích điều trị hay dự phòng.

- Xoa bóp được đánh giá là một trong những phương pháp điều trị đa năng có tác dụng điều trị nhiều bệnh.

- Các động tác xoa bóp tác động trực tiếp lên các thụ cảm thể thần kinh dày đặc ở dưới da tạo ra các phản xạ thần kinh đáp ứng từ đó gây nên tác dụng điều hòa quá trình hưng phấn hay ức chế hệ thần kinh gây thư giãn, giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung, giảm đau, giãn cơ, và điều hòa chức năng nội tạng. Xoa bóp trực tiếp lên các dây thần kinh hay đám rối thần kinh có thể gây tăng hoặc giảm cảm giác, kích thích vận động, kích thích quá trình phát triển tái sinh nhanh những sợi thần kinh bị tổn thương.

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau và di động các lớp mô co thắt.

- Kích thích hoặc làm êm dịu hệ thần kinh.

- Cải thiện tuần hoàn, tăng bài tiết các chất cặn bã và giảm phù nề.

- Chống mệt mỏi, thư giãn, giảm stress.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng nhiễm trùng.

- Nhiễm trùng da.

- Viêm tĩnh mạch huyết khối.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh quá suy kiệt.

- Rối loạn tri giác nhận thức

- Gãy xương

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Dầu xoa

- Bột tal

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Máy xoa bóp

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...để người bệnh yên tâm kết hợp thực hiện

- Người bệnh cần thoải mái và thư giãn toàn bộ cơ thể, vùng cơ thể khi đang thực hiện kỹ thuật.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa: tình trạng bệnh, cách thức điều trị

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20 - 30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vùng điều trị...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Xoa bóp với máy xoa bóp cơ: kỹ thuật y bộc lộ vùng điều trị. Xoa nhẹ bột tal hoặc dầu lên vùng điều trị. Đặt máy xoa bóp, điều chỉnh chế độ theo chỉ định, đặt thời gian điều trị 20-30 phút và tiến hành di chuyển chậm và nhẹ nhàng máy xoa bóp trên vùng da điều trị. Sau khi hết thời gian điều trị, máy sẽ báo và ngắt hoạt động.

- Đối với máy xoa bóp bằng chân không: cố định bộ phận phần tạo chân không vào vùng điều trị, đặt chế độ được chỉ định. Đặt thời gian điều trị.

- Sau khi kết thúc thời gian điều trị kỹ thuật y di chuyển máy ra khỏi người bệnh. Kiểm tra vùng da điều trị. Đánh giá kết quả điều trị. Viết nhận xét theo dõi trong quá trình điều trị.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tình trạng vùng điều trị. Tình trạng tiến triển của bệnh.

- Tình trạng sức khỏe nói chung.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

69 KỸ THUẬT XOA BÓP DẪN LƯU

1. ĐẠI CƯƠNG

- Kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu hay còn gọi kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu bạch huyết (Lymphatic Drainage Massage) là kỹ thuật xoa bóp và ép nhẹ nhàng sử dụng để gia tăng tuần hoàn bạch huyết bằng cách di chuyển những dịch bạch huyết ứ đọng ra khỏi vùng tổn thương. - Kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu là kỹ thuật sử dụng để giảm ứ trệ bạch huyết do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân phù bạch mạch sau phẫu thuật lấy các hạch bạch huyết.

- Có hai giai đoạn của kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu, đó là làm vận chuyển dịch và tái hấp thụ dịch.

- Tác dụng: Giảm phù bạch huyết, tăng cường hệ thống miễn dịch, thải độc tố, thư giãn, giảm đau mạn tính

2. CHỈ ĐỊNH

- Phù hạch bạch huyết tiên phát và thứ phát

- Dự phòng huyết khối tĩnh mạch.

- Phù nề do bạch huyết: sau phẫu thuật cắt bỏ mạch bạch huyết (ví dụ: do cắt bỏ tuyến vú, nạo hạch...).

- Phù nề cấp tính: sau phẫu thuật, sau bỏng tiểu đường.

- Phù nề sau liệt thần kinh trung ương: tổn thương tuỷ sống, đột quỵ não.

- Phù nề sau liệt thần kinh ngoại biên, sau chấn thương, bong gân, sau phẫu thuật nút tĩnh mạch...

- Xơ cứng tĩnh mạch, bệnh giãn tĩnh mạch, suy tĩnh mạch mạn tính, suy động mạch.

- Phù chân thai nghén

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Suy tim, tăng huyết áp.

- Tiền sử huyết khối tĩnh mạch (DVT), tắc mạch phổi (PE).

- Lở loét vùng da điều trị, bỏng.

- Hoại tử cấp tính kèm theo sốt và phát ban đỏ.

- Viêm vùng ngoại vi nghiêm trọng.

4. THẬN TRỌNG

- Loại trừ tình trạng cấp cần xử trí trước dẫn lưu; chọn hướng, lực và vùng phù hợp, theo dõi da và dung nạp.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Bàn tập, giường tập.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Đánh giá người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật:

+ Xác định xem vùng tổ chức nào bị ứ đọng bạch huyết, nguyên nhân làm ứ đọng bách huyết và chọn tư thế nằm thích hợp, thoải mái cho người bệnh.

+ Đánh giá mức độ ứ dịch bạch huyết nhiều hay ít, rộng hay hẹp.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20 - 30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ :

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh : Đánh giá tính chính xác của người bệnh : đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Lựa chọn vùng điều trị để có thể đạt được mục đích tốt nhất

- Đặt người bệnh trong tư thế thoải mái, vững chắc và ổn định để cho phép mặt phẳng cử động là tốt nhất khi quy trình kỹ thuật được thực hiện.

- Dùng các kỹ thuật thư giãn, nhiệt nóng đối với tổ chức mô mềm trước khi thực hiện để làm tăng khả năng đẩy dịch và hấp thụ dịch, giảm chấn thương.

- Thực hiện kỹ thuật dịch chuyển dịch bạch huyết.

- Vận chuyển dịch ở các khu vực :

+ Vùng bạch huyết trên xương đòn ngay dưới hai xương đòn.

+ Vùng bạch huyết hõm nách ngay dưới cánh tay.

+ Vùng bạch huyết bên trong khuỷu.

+ Kỹ thuật vận chuyển dịch có thể được lặp lại nhiều lần như khoảng 10 lần/ngày, luôn luôn xoa bóp cả hai bên cơ thể, không chỉ ở bên có ứ dịch bạch huyết.

+ Có ba giai đoạn của dịch chuyển dịch bạch huyết theo trật tự vùng trên đòn, vùng hõm nách và vùng mặt trong khuỷu tay.

+ Dịch chuyển dịch vùng trên đòn:

Để người bệnh năm ngửa trên mặt phẳng chắc chắn, thoải mái.

Bắt chéo hai cánh tay trên ngực người bệnh với hai bàn tay đặt nghỉ ngay phía dưới hai xương đòn.

Nâng hai khuỷu tay người bệnh lên chậm và nhẹ nhàng. Hoạt động cơ này cần càng nhiều áp lực càng tốt để chuẩn bị cho hoạt động đẩy dịch bạch huyết di chuyển.

+ Dịch chuyển dịch vùng nách:

Đặt một tay người bệnh lên trên đầu.

Sử dụng tay kia để vét nhẹ nhàng vùng hõm nách từ đỉnh xuống đáy, lực ép chỉ vừa đủ và nhẹ nhàng đủ để di chuyển bề mặt da.

+ Dịch chuyển dịch vùng mặt trong của khuỷu tay : Đặt cánh tay dọc theo thân thể. Sử dụng các ngón tay bên đối diện nhẹ nhàng kéo da mặt trong khuỷu một vài cm mỗi lần kéo.

Lưu ý:

- Lực ép hết sức nhẹ nhàng, trong kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu bạch huyết, bạn chỉ cần làm việc với cấu trúc da vùng nông, đó là nơi ta có thể lấy được dịch ứ đọng.

- Kỹ thuật tái hấp thụ dịch bạch huyết.

+ Phần thứ hai của kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu là giai đoạn tái hấp thụ dịch bạch huyết. Để thực hiện giai đoạn xoa bóp này, ta cần bắt đầu ở vùng cơ thể bị ảnh hưởng xa nhất so với trung tâm cơ thể, có thể bắt đầu ở các đầu ngón tay nếu người bệnh có phù bạch mạch ở bàn tay, cánh tay và vai.

+ Sử dụng cử động vuốt với lực ép vừa phải để thay đổi bề mặt của da, xoa bóp từ các ngón tay đến bàn tay, từ bàn tay đến khuỷu tay và từ khuỷu tay đến vùng vai.

+ Người bệnh phải đồng ý với việc tự xoa bóp dẫn lưu cho bản thân đặc biệt là phụ nữ vì phụ nữ thường quen chăm sóc cho người khác. Người bệnh cần thực hiện ít nhất 20 phút mỗi ngày kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu bạch huyết vì nếu làm thời gian ngắn thì sẽ chỉ đủ để dịch chuyển dịch chứ không đủ thời gian cho

dịch tái hấp thụ.

- Những điều cần lưu ý khi thực hiện kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu.

+ Lực ép vừa đủ sâu sao cho cử động không trượt trên mặt da, nhưng nhẹ nhàng vừa đủ sao cho người bệnh không cảm thấy khó chịu dưới da. Lực ép khoảng 25 - 100g. Đây là kỹ thuật thường được áp dụng và huấn luyện tại Thụy Điển và mô sâu được xoa bóp dẫn lưu với lực ép nhiều hơn. Rất nhiều người cho rằng với lực ép nhẹ thì kỹ thuật không thể tạo được hiệu quả. Tuy nhiên kỹ thuật y cần hiểu rằng họ đang làm kỹ thuật trên da, nếu sử dụng quá nhiều lực ép, kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu bạch huyết sẽ thất bại.

+ Hướng của kỹ thuật xoa bóp rất quan trọng để đẩy dịch bạch huyết về đúng các hạch bạch huyết. Nếu kỹ thuật y thực hiện động tác với hướng sai, kỹ thuật sẽ không hiệu quả.

+ Nhịp điệu của động tác cũng rất quan trọng để hoàn thành kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu bạch huyết, bởi với nhịp điệu và tốc độ đúng, các hạch bạch huyết gốc mới mở ra và sau đó cho phép đóng lại và với thời gian ngắn những hạch này hút bạch huyết xuống các mao mạch. Nhịp điệu và tốc độ thích hợp cũng kích thích hệ thống thần kinh phó giao cảm làm người bệnh thư giãn dễ chịu.

+ Trật tự của kỹ thuật vuốt rất quan trọng. Khi chúng ta muốn dẫn lưu một vùng nào đó, chúng ta luôn luôn lưu ý rằng nên bắt đầu ở vùng gần với hạch bạch huyết gốc mà chúng ta muốn dẫn lưu dịch bạch huyết về. Luôn luôn đẩy bạch huyết hướng về phía hạch khi thực hiện kỹ thuật. Và khi làm như vậy, ta đi dần ra vùng xa của hạch bạch huyết nhưng luôn đẩy dịch chảy về phía hạch bạch huyết. Bằng cách này ta đã dịch chuyển dịch theo con đường mà bạch huyết lưu thông cũng như tạo ra một hiệu quả hút dịch bạch huyết vào hạch bạch huyết.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Đây là kỹ thuật điều trị duy trì, nếu người bệnh thực hiện đều đặn kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu thì phù dịch bạch huyết sẽ không trở nên nặng nề hơn.

- Kiểm soát phù mạch bạch huyết cũng có thể thực hiện bằng mang tay áo chật để ngăn cản dịch ứ lại. Một kỹ thuật y có kinh nghiệm cần hướng dẫn người bệnh những điều này. Người bệnh cần được hướng dẫn kỹ, bởi xoa bóp dẫn lưu thực sự hiệu quả với người bệnh, nhưng xoa bóp những mô sâu có thể sẽ khó khăn với những người bị phù bạch mạch, vì vậy đừng cho rằng người bệnh chỉ cần thực hiện xoa bóp thông thường là được.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

70 KỸ THUẬT KIỂM SOÁT TƯ THẾ (NGỒI, BÒ, ĐỨNG, ĐI)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Kiểm soát tư thế là một kỹ thuật tập luyện phục hồi chức năng giúp trẻ có khả năng thăng bằng tốt ở các mốc phát triển vận động của trẻ. Kỹ thuật kiểm soát tư thế nằm trong nội dung các bài tập vận động trị liệu.

- Nguyên tắc: vận động trị liệu theo các mốc phát triển về vận động thô của trẻ từ:

+ Kiểm soát đầu cổ → Lẫy → Ngồi → Quỳ → Bò → Đứng → Đi → Chạy.

+ Phải hoàn thành mốc vận động trước rồi chuyển sang mốc vận động sau.

+ Chỉ tạo thuận vận động cho trẻ chứ không làm hộ trẻ. Khi trẻ làm tốt hơn thì phải giảm dần sự hỗ trợ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trẻ chậm phát triển vận động.

- Trẻ chậm phát triển tâm thần vận động.

- Trẻ bại não.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá tuổi phát triển, khả năng phối hợp và sức khỏe của trẻ; thao tác nhẹ, nâng đỡ đầu cổ thân phù hợp. Không kéo giật chi hoặc ép trẻ tập khi đau, khó thở hoặc chống đối nhiều.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

- Dụng cụ hỗ trợ tập (bóng tập, gối tròn, bàn tập đứng, thanh song song...).

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

- Ghi nhận xét trước tập

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 21 - 30 phút (ước tính 0,35-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, Buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Bước 1

Người thực hiện trực tiếp tiến hành đánh giá trẻ và lựa chọn kỹ thuật kiểm soát tư thế theo mốc phát triển mà trẻ đang đạt được.

Bước 2

Tiến hành các kỹ thuật tập kiểm soát tư thế trên trẻ.

6.1. Kỹ thuật kiểm soát tư thế ngồi: thời gian 20-30 phút

- Thăng bằng ở tư thế ngồi trên sàn hoặc trên ghế.

- Chỉ định: trẻ chưa giữ thăng bằng khi ngồi.

- Kỹ thuật: đặt trẻ ngồi trên sàn (trên đùi), dùng hai tay cố định hai đùi trẻ. Đẩy nhẹ người trẻ sang bên, ra trước sau. Để trẻ tự điều chỉnh thân mình để giữ thăng bằng ngồi.

- Kết quả mong muốn: trẻ có thể điều chỉnh thân mình để giữ thăng bằng.

- Thăng bằng ở tư thế ngồi trên người.

- Chỉ định: trẻ chưa giữ thăng bằng khi ngồi.

- Kỹ thuật: đặt trẻ ngồi dạng hai chân trên bụng, lưng tựa vào đùi người tập. Nắm hai tay trẻ, di chuyển chân sang từng bên trong lúc hai tay trẻ vẫn duỗi thẳng, để trẻ tự điều chỉnh và giữ thăng bằng đầu, cổ, thân mình.

- Kết quả mong muốn: trẻ có thể điều chỉnh thân mình để giữ thăng bằng.

- Tập ngồi xổm.

- Chỉ định: trẻ chưa tự ngồi xổm.

- Kỹ thuật: đặt trẻ ngồi xổm. Người tập quỳ phía sau trẻ dùng hai tay cố định hai gối trẻ, dồn trọng lượng của trẻ lên hai bàn chân. Khuyến khích trẻ chơi ở tư thế ngồi xổm.

- Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng giữ thăng bằng thân mình ở tư thế ngồi xổm trong vài phút.

6.2. Kỹ thuật kiểm soát tư thế bò: thời gian 20-30 phút

* Thăng bằng có trợ giúp ở tư thế quỳ trên hai gối

- Chỉ định: trẻ chưa biết quỳ trên hai gối.

- Kỹ thuật: đặt trẻ quỳ trên hai gối, người tập quỳ phía sau trẻ và dùng hai tay giữ hai bên hông trẻ, đẩy nhẹ người trẻ ra phía trước và sau. Để trẻ lấy lại thăng bằng.

- Kết quả mong muốn: trẻ có thể giữ thăng bằng thân mình khi quỳ hai điểm.

* Tạo thuận thay đổi trọng lượng ở tư thế quỳ trên hai điểm

- Chỉ định: trẻ chưa biết giữ thăng bằng ở tư thế quỳ trên hai điểm.

- Kỹ thuật: đặt trẻ quỳ trên hai gối trước một cái bàn ngang, người tập quỳ phía sau trẻ và dùng hai tay giữ hai bên hông trẻ, nhẹ nhàng đẩy hông trẻ sang bên sao cho trọng lượng của trẻ dồn từ bên này sang bên kia, cho phép trẻ gập háng.

- Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng chuyển và dồn trọng lượng từ bên này sang bên kia ở tư thế quỳ hai điểm mà không mất thăng bằng.

* Thăng bằng ở tư thế quỳ một chân

- Chỉ định: trẻ chưa biết giữ thăng bằng ở tư thế quỳ một chân.

- Kỹ thuật: đặt trẻ quỳ trên một gối người đổ nhẹ ra sau và sang trái để giữ cho chân phải đưa ra trước, khuyến khích trẻ với tay ra phía trước. Kỹ thuật y quỳ phía sau trẻ và dùng hai tay giữ nhẹ hai bên hông trẻ để trẻ cố định khi cần giữ thăng bằng.

- Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng giữ thăng bằng ở tư thế quỳ một chân trong lúc chơi.

* Tạo thuận quỳ bốn điểm

- Chỉ định: trẻ chưa biết bò.

- Kỹ thuật: đặt trẻ quỳ trên hai tay và hai gối. Dùng hai tay giữ thân mình trẻ hoặc dùng một gối tròn hỗ trợ nâng thân trẻ khi trẻ quỳ. Bảo trẻ nhặt đồ chơi bằng từng tay bỏ vào rổ.

- Kết quả mong muốn: trẻ có thể quỳ bốn điểm khi có hỗ trợ.

* Tạo thuận bò trên đùi

- Chỉ định: trẻ chưa biết bò.

- Kỹ thuật: đặt trẻ quỳ trên đùi người tập, chân dưới gập, chân trên duỗi thẳng. Dùng một tay cố định trên mông trẻ, tay kia giữ bàn chân trẻ. Đẩy nhẹ vào gót chân trẻ về phía trước và hỗ trợ nâng thân trẻ bằng đùi ta khi trẻ bò.

- Kết quả mong muốn: trẻ có thể giữ thẳng chân trên, thân mình thẳng.

6.3. Kỹ thuật kiểm soát tư thế đứng: thời gian 20-30 phút

* Tập thăng bằng đứng trên bàn thăng bằng

- Chỉ định: trẻ có thăng bằng đứng kém.

- Kỹ thuật: đặt trẻ đứng trên bàn thăng bằng với hai chân để rộng hơn vai. Nghiêng nhẹ bàn thăng bằng và đợi trẻ lấy thăng bằng khi bàn nghiêng di chuyển. Người tập trợ giúp hai bên hông khi cần.

- Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng giữ thăng bằng ở tư thế đứng khi bàn nghiêng di chuyển.

* Tạo thuận dồn trọng lượng lên từng chân

- Chỉ định: trẻ thăng bằng đứng chưa tốt

- Kỹ thuật: đặt trẻ đứng bám vào tường với hai chân để rộng hơn vai. Yêu cầu trẻ co một chân lên để trọng lượng dồn vào chân kia. Người tập trợ giúp hai bên hông khi cần. Lặp lại với chân kia bằng cách đổi bên đứng bám.

- Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng dồn trọng lượng lên chân sát tường.

6.4. Kỹ thuật kiểm soát tư thế đi: thời gian 20-30 phút

* Tập đi với thanh song song

- Chỉ định: trẻ chưa tự đi.

- Kỹ thuật: đặt trẻ đứng bám vào hai thanh song song với hai chân để rộng hơn vai. Yêu cầu trẻ co một chân lên để trọng lượng dồn vào chân kia khi bước đi. Ta trợ giúp hai bên hông khi cần.

- Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng dồn trọng lượng lên từng chân khi bước đi.

* Tập đi với khung đi

- Chỉ định: trẻ chưa tự đi.

- Kỹ thuật: đặt trẻ đứng bám vào hai tay cầm của khung đi với hai chân để rộng hơn vái. Yêu cầu trẻ co chân lên để trọng lượng dồn vào chân kia khi bước đi. Người tập trợ giúp hai bên hông khi cần.

- Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng dồn trọng lượng lên từng chân khi bước đi.

6.5. Lưu ý trong quá trình tập

- Môi trường tập: phòng tập cần phải đủ rộng để trẻ tự do di chuyển, bề mặt phòng cần nhãn, phẳng, có ma sát, tạo môi trường thoải mái cho trẻ, có đầy đủ các Thiết bị y tế cần thiết.

- Tình trạng của trẻ: tạo cho trẻ hợp tác một cách tối đa, tránh tình trạng trẻ

quấy khóc.

6.6. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi sự hợp tác và sự an toàn của trẻ trong quá trình tập.

- Theo dõi đau và phản ứng quấy khóc, nôn trớ của trẻ.

- Nếu trẻ đau và chống đối nhiều thì ngừng tập, chụp X quang nếu nghi ngờ gãy xương.

- Nếu có gãy xương thì gửi khám bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

71 KỸ THUẬT TẠO THUẬN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ (LẪY, NGỒI, BÒ, ĐỨNG, ĐI)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Kiểm soát tư thế là một kỹ thuật tập luyện phục hồi chức năng giúp trẻ có khả năng thăng bằng tốt ở các mốc phát triển vận động của trẻ. Kỹ thuật kiểm soát tư thế nằm trong nội dung các bài tập vận động trị liệu.

- Nguyên tắc:

+ Vận động trị liệu theo các mốc phát triển về vận động thô của trẻ từ Kiểm soát đầu cổ → Lẫy → Ngồi → Quỳ → Bò → Đứng → Đi → Chạy.

+ Phải hoàn thành mốc vận động trước rồi chuyển sang mốc vận động sau.

+ Chỉ tạo thuận vận động cho trẻ chứ không làm hộ trẻ. Khi trẻ làm tốt hơn thì phải giảm dần sự hỗ trợ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trẻ chậm phát triển vận động.

- Trẻ chậm phát triển tâm thần vận động.

- Trẻ bại não.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá tuổi phát triển, khả năng phối hợp và sức khỏe của trẻ; thao tác nhẹ, nâng đỡ đầu cổ thân phù hợp. Không kéo giật chi hoặc ép trẻ tập khi đau, khó thở hoặc chống đối nhiều.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

- Đệm tập, gối tròn, bóng, khăn, đồ chơi

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho trẻ (trẻ có khả năng hiểu) và gia đình trẻ biết việc mình sắp làm. Hướng dẫn trẻ (trẻ có khả năng hiểu) những điều cần thiết.

- Trẻ không trong giai đoạn ốm, sốt.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, Buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra tên trẻ và chỉ định điều trị trong phiếu điều trị.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TẠO THUẬN LẪY

a) Lẫy từ ngửa sang sấp

- Kỹ thuật y ngồi dưới chân trẻ. Đặt trẻ nằm ngửa. Chân phía dưới duỗi. Gập một chân trẻ và nhẹ nhàng đưa chéo qua người trẻ. Khi trẻ đã nằm nghiêng ta từ từ đẩy thân mình trẻ sang bên đó và đợi trẻ tự lật nghiêng người.

- Kết quả mong muốn: trẻ có thể phối hợp lật nghiêng người từ nằm ngửa sang sấp.

b) Lẫy từ sấp sang ngửa

- Kỹ thuật y ngồi phía dưới chân trẻ dùng một tay gập gối và háng một chân trẻ và nhẹ nhàng đẩy chéo vào bụng trẻ. Khi trẻ đang nằm nghiêng ta từ từ đẩy thân mình trẻ sang bên đó và đợi trẻ tự lật ngửa.

- Kết quả mong muốn: trẻ có thể phối hợp lật nghiêng người từ nằm sấp sang ngửa.

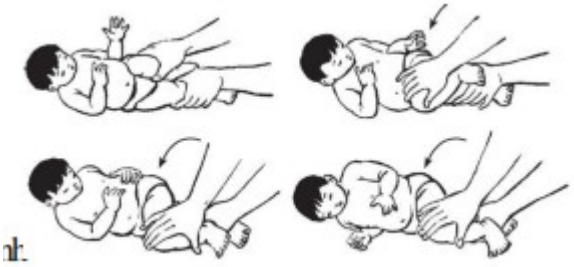
c) Hướng dẫn gia đình cách tập

d) Ghi phiếu điều trị

- Ghi ngày giờ tập.

- Ghi số lần tập.

e) Thu dọn dụng cụ để vào nơi quy định



6.2. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TẠO THUẬN NGỒI

a) Tập năm ngồi dậy

Tạo thuận kéo ngồi dậy ở tư thế năm ngửa.

- Kỹ thuật: đặt trẻ năm ngửa. Ta dùng hai tay đưa vai trẻ ra phía trước trong khi khuỷu tay duỗi và từ từ kéo trẻ ngồi dậy.
- Kết quả mong muốn: trẻ nâng đầu lên khi được kéo ngồi dậy.



b) Tạo thuận ngồi dậy ở tư thế năm sấp trên sàn

- Đặt trẻ năm sấp trên sàn. Một tay ta cố định trên mông trẻ, tay kia cố định vào dưới nách trẻ. Từ từ kéo háng trẻ lên đưa ra sau và ấn xuống. Hỗ trợ tại nách trẻ bằng cách kéo ra trước và lên trên.
- Kết quả mong muốn: trẻ có thể ngồi dậy bằng cách sử dụng cơ nâng đầu cổ thân mình và tay để ngồi dậy.



c) Tập ngồi trên sàn

Đặt trẻ ở tư thế ngồi duỗi thẳng chân: đặt trẻ ngồi 2 chân dạng háng, duỗi gối. Kỹ thuật y dùng 2 tay đè lên đùi trẻ hoặc ngồi ở phía sau cố định đùi trẻ.

d) Thăng bằng ở tư thế ngồi trên sàn hoặc trên ghế

Đặt trẻ ngồi trên sàn, kỹ thuật y dùng 2 tay cố định hai đùi trẻ, đẩy nhẹ người trẻ sang từng bên, ra trước, sau, có thể dùng đồ chơi đưa sang từng bên để trẻ với cầm và đợi trẻ điều chỉnh thân mình để giữ thăng bằng ngồi.

e) Thăng bằng ở tư thế ngồi trên bóng tập

Đặt trẻ ngồi trên bóng tập, kỹ thuật y dùng 2 tay cố định 2 bên đùi trẻ, đẩy nhẹ người sang từng bên, ra trước sau bằng cách lăn bóng, có thể dùng đồ chơi đưa sang từng bên để trẻ với cầm và đợi trẻ điều chỉnh thân mình.

f) Hướng dẫn gia đình cách làm

g) Ghi phiếu điều trị

Ghi ngày giờ tập. Ghi số lần tập.

h) Thu dọn dụng cụ để vào nơi quy định

6.3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TẠO THUẬN BÒ

a) Tạo thuận bò bằng tay hoặc khăn đỡ

Đặt trẻ quỳ trên hai tay và hai gối. Kỹ thuật y dùng hai tay giữ thân mình trẻ hoặc dùng một khăn mềm hỗ trợ nâng thân khi trẻ bò.

b) Tạo thuận bò trên đùi kỹ thuật y

Đặt trẻ quỳ trên đùi kỹ thuật y , chân dưới gập, chân trên duỗi thẳng. Kỹ thuật y dùng một tay cố định trên mông trẻ, tay kia giữ bàn chân. Đẩy nhẹ gót chân trẻ về phía trước và hỗ trợ nâng thân trẻ bằng đùi kỹ thuật y khi trẻ bò.



c) Hướng dẫn gia đình cách làm

d) Kết thúc tập, ghi phiếu điều trị

- Ghi ngày giờ tập.
- Ghi số lần tập.

e) Thu dọn dụng cụ để vào nơi quy định

6.4. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TẠO THUẬN ĐỨNG - ĐI

a) Tạo thuận đứng dậy từ tư thế ngồi

Mục tiêu: tăng khả năng đứng dậy từ tư thế ngồi.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ ngồi trên một đùi của kỹ thuật y , kỹ thuật y dùng hai tay giữ gối trẻ.

- Đẩy mạnh xuống hai gối trẻ rồi bỏ tay ra. Làm như vậy vài lần.

- Gập gối trẻ và đẩy người ra trước sao cho đầu trẻ đưa ra phía trước gối.

- Kỹ thuật y trượt tay xuống phía dưới hông trẻ để cố định thân mình của trẻ, ấn - mạnh hai hông trẻ.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng đứng dậy từ tư thế ngồi.

Kết quả không mong muốn: trẻ ưỡn người ra sau, hai gối khép chặt, hai chân bắt chéo vào nhau toàn thân trở nên co cứng.

b) Tạo thuận đứng dậy từ tư thế ngồi trên ghế

Mục tiêu: tăng khả năng đứng dậy từ tư thế ngồi trên ghế.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ ngồi lên ghế.

- Kỹ thuật y dùng hai tay giữ ở hai khớp khuỷu của trẻ sao cho khớp khuỷu duỗi thẳng, ngón cái hướng lên trên.

- Kéo nhẹ trẻ ra phía trước.

- Dồn trọng lực của trẻ ra phía trước và khuyến khích trẻ đứng dậy.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng đứng dậy từ tư thế ngồi trên ghế.

Kết quả không mong muốn: trẻ không có khả năng gập háng và không có khả

năng đứng dậy.

c) Tạo thuận đứng trong bàn đứng

Mục tiêu: tăng khả năng thăng bằng ở tư thế đứng. Phá vỡ phản xạ duỗi chéo và nâng đỡ hữu hiệu.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ nằm sấp trên bàn đứng với hai chân để rộng hơn vai, đai cố định ở gối háng và ngực trẻ. Sau đó nghiêng bàn đứng cạnh bàn.

- Đặt vài đồ chơi trên bàn. Khuyến khích trẻ với tay ra phía trước, sang hai bên với đồ chơi.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng giữ thăng bằng ở tư thế đứng trong bàn đứng trong lúc chơi, hai chân duỗi thẳng ở khớp gối, bàn chân đặt vuông góc xuống sàn.

Kết quả không mong muốn: chân bị khuỵu xuống.

e) Tạo thuận đứng giữa hai cột có đai cố định

Mục tiêu: tăng khả năng thăng bằng ở tư thế đứng. Phá vỡ phản xạ duỗi chéo và nâng đỡ hữu hiệu.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ đứng giữa hai cột với hai chân để rộng hơn vai, đai cố định ở gối, háng, ngực trẻ.

- Khuyến khích trẻ với hai tay ra trước, sang hai bên để lấy đồ chơi.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng giữ thăng bằng ở tư thế đứng trong lúc chơi, hai chân duỗi thẳng ở khớp gối, bàn chân đặt vuông góc với sàn.

Kết quả không mong muốn: chân khuỵu xuống.

f) Tạo thuận đứng bám có trợ giúp bằng tay

Mục tiêu: Tăng khả năng thăng bằng ở tư thế đứng. Phá vỡ phản xạ duỗi chéo và nâng đỡ hữu hiệu.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ đứng bám vào mép bàn, hoặc trước bảng với hai chân để rộng hơn vai. Kỹ thuật y dùng hai tay cố định ở đùi hoặc háng trẻ.

- Đặt vài đồ chơi trên bàn. Khuyến khích trẻ với tay ra phía trước, sang hai bên để lấy đồ chơi.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng thăng bằng ở tư thế đứng trong lúc chơi, hai chân duỗi thẳng khớp gối, bàn chân đặt vuông góc với sàn.

Kết quả không mong muốn: chân bị khuỵu xuống.

g) Tạo thuận đứng bám bằng hai tay

Mục tiêu: tăng khả năng thăng bằng ở tư thế đứng. Phá vỡ phản xạ duỗi chéo và nâng đỡ hữu hiệu.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ đứng bám vào hai ghế với hai chân để rộng hơn vai.

- Đặt quả bóng phía trước hai chân trẻ. Khuyến khích trẻ giơ một bàn chân ra trước đá vào quả bóng.

- Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng giữ thăng bằng ở tư thế đứng một chân. Kết quả không mong muốn: chân chịu trọng lượng bị khuỵu xuống.

h) Thăng bằng đứng trên bàn thăng bằng

Mục tiêu: tăng khả năng thăng bằng ở tư thế đứng.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ đứng trên bàn thăng bằng với hai chân để rộng hơn vai.

- Nghiêng nhẹ bàn thăng bằng và đợi trẻ lấy thăng bằng khi bàn nghiêng di chuyển, kỹ thuật y trợ giúp hai bên hông khi cần.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng giữ thăng bằng ở tư thế đứng khi bàn di chuyển.

Kết quả không mong muốn: chân bị khuỵu xuống, mất thăng bằng.

i) Tạo thuận bước đi có trợ giúp bằng tay

Mục tiêu: tăng khả năng thăng bằng trên một chân ở tư thế bước đi.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ đứng trước một bậc nhỏ với hai chân để rộng hơn vai. Hai tay kỹ thuật y trợ giúp hai bên hông trẻ.

- Từ từ dồn trọng lượng trẻ lên một chân và trợ giúp trẻ giơ chân kia đặt lên bậc.

- Tăng dần độ dài bước chân trẻ sao cho trọng lượng được dồn lên chân thẳng.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng giữ thăng bằng ở tư thế đứng và dồn trọng lượng lên chân thẳng.

Kết quả không mong muốn: chân bị khuỵu xuống, mất thăng bằng.

k) Tạo thuận dồn trọng lượng lên từng chân

Mục tiêu: tăng khả năng thăng bằng tư thế đứng một chân.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ đứng bám vào tường với hai chân để rộng hơn vai.

- Yêu cầu trẻ co một chân lên để trọng lượng dồn lên chân kia. Kỹ thuật y trợ giúp hai bên hông khi cần. Lặp lại với chân kia bằng cách đổi bên đứng bám.

- Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng dồn trọng lượng lên chân sát tường. Kết quả không mong muốn: chân bị khuỵu xuống, mất thăng bằng.

l) Tập đi trong thanh song song

Mục tiêu: tăng khả năng đi.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ đứng bám vào hai thanh song song với hai chân rộng hơn vai.

- Yêu cầu trẻ co một chân lên để trọng lượng dồn vào chân kia khi bước đi. Kỹ thuật y trợ giúp hai bên hông khi cần.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng dồn trọng lượng lên từng chân khi bước đi.

Kết quả không mong muốn: chân chịu trọng lượng kia bị khuỵu xuống, mất thăng bằng.

m) Tập với khung đi

Mục tiêu: tăng khả năng đi.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ đứng bám vào hai tay cầm của khung đi với hai chân để rộng hơn vai.

- Yêu cầu trẻ co một chân lên để trọng lượng dồn vào chân kia khi bước đi. Kỹ thuật y trợ giúp hai bên hông khi cần.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng dồn trọng lượng lên từng chân khi bước đi.

Kết quả không mong muốn: chân chịu trọng lượng bị khuỵu xuống, mất thăng bằng.

n) Tập đi băng nạng

Mục tiêu: tăng khả năng đi.

Kỹ thuật:

- Đặt trẻ đứng tựa lên hai nạng nách với hai chân để rộng hơn vai.

- Yêu cầu trẻ đưa hai nạng ra trước. Sau đó co hai chân lên và đu người theo.

- Kỹ thuật y trợ giúp hai bên hông khi cần.

Kết quả mong muốn: trẻ có khả năng thăng bằng khi đu người bước đi.

Kết quả không mong muốn: chân chịu trọng lượng bị khuỵu xuống mất thăng bằng.

Kết thúc tập, ghi phiếu điều trị

Ghi ngày giờ tập. Ghi số lần tập.

Thu dọn dụng cụ để vào nơi quy định

6.5. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi sự hợp tác và sự tiến bộ của trẻ sau mỗi đợt can thiệp.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh

ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

72 KỸ THUẬT KÉO GIÃN CHO TRẺ EM BỊ VẸO CỔ DO XƠ CƠ ỨC ĐÒN CHŨM (KỸ THUẬT KÉO GIÃN CHO TRẺ EM BỊ VẸO CỔ BẨM SINH)

1. ĐẠI CƯƠNG

Vẹo cổ do u cơ ức đòn chũm là tình trạng cơ ức đòn chũm bị xơ hoá, co rút dẫn đến tư thế đầu nghiêng về bên có khối u cơ và mặt xoay về phía đối diện.

2. CHỈ ĐỊNH

- Áp dụng cho trẻ em sau sinh bị vẹo cổ do u cơ ức đòn chũm (UĐC).

- Thời điểm điều trị: ngay khi phát hiện khối u trên cơ ức đòn chũm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Khối u cơ ức đòn chũm đang sưng, nóng và đau.

4. THẬN TRỌNG

- Loại trừ nguyên nhân vẹo cổ ngoài cơ và bất thường cột sống cổ; thực hiện nhẹ, không ép xoay cổ; dừng khi trẻ đau hoặc bất thường hô hấp.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Bàn tập có nệm

- Ghế tập

- Đồ chơi có âm thanh êm nhẹ và có màu sắc

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế: không

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Mặc áo gọn gàng, bộc lộ rõ vùng cổ, vai

- Nằm ngửa, thân mình bên trái của trẻ nằm dọc theo một bên của cạnh bàn. Trẻ

thoái mái, không khóc.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

- Hỏi bệnh:

+ Tiền căn sản khoa: sinh ngôi mông, sinh khó, sinh hút, cân nặng lúc sinh, sinh đủ tháng hay thiếu tháng.

+ Thời điểm phát hiện khối u 526ren cơ ức đòn chũm.

- Khám lâm sàng:

+ Tư thế của đầu khi nằm ngửa hoặc khi ngồi.

+ Tầm vận động cột sống cổ: đo tầm độ giới hạn.

+ Tình trạng cơ UĐC và cơ thang 526ren: mềm hay co thắt, co rút.

+ Khối u 526ren cơ UĐC: mềm hay cứng, xác định kích thước khối u qua kết quả siêu âm.

+ Hình thể sọ mặt: lép hoặc biến dạng.

+ Mắt và chức năng thị giác.

+ Cột sống.

+ Các bệnh và tật khác.

- Cận lâm sàng: Siêu âm cơ UĐC khi cần chẩn đoán phân biệt.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20 - 30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Kỹ thuật kéo giãn và hình ảnh sau đây chỉ minh họa cho trường hợp vẹo cổ do u cơ UĐC bên phải

6.1. Tư thế người điều trị: ngồi ghế cạnh bàn, phía dưới chân của trẻ để có thể nhìn đối diện với mặt của trẻ.

6.2. Thực hiện kỹ thuật: kéo giãn cơ UĐC bên phải bằng cử động nghiêng cột sống cổ qua trái.

- Tay cố định: tay trái người điều trị cố định đai vai bên phải của trẻ (hình minh họa), để giữ đai vai bên phải không di chuyển trong khi thực hiện động tác kéo giãn nghiêng cột sống cổ qua trái.

- Tay di động: tay phải người điều trị nâng đỡ toàn bộ phía sau đầu trẻ. Tay di

động của người điều trị kéo giãn từ từ đầu trẻ nghiêng sang trái. Lưu ý giữ cho mặt trẻ không bị xoay trong suốt động tác kéo giãn.

- Khi cảm nhận sự kháng cản trong lúc thực hiện do giới hạn của chiều dài cơ ức đòn chũm, giữ lại ở tầm vận động giới hạn này khoảng 30 - 60 giây/lần, tùy theo khả năng chịu đựng được của trẻ. Tăng tiến tầm vận động nghiêng cổ này sẽ được thực hiện từ từ qua mỗi buổi tập, cho đến khi đạt được tầm vận động bình thường.

- Lặp lại kỹ thuật từ 5 - 15 lần/buổi tập.

6.3. Thực hiện kỹ thuật kéo giãn cơ UĐC bên phải bằng cử động xoay cột sống cổ qua phải.

- Tay cố định: tay trái người điều trị cố định xương bả vai bên phải của trẻ với 4 ngón tay ở sau và ngón cái đặt dọc theo hàm dưới của trẻ (hình minh họa), để giữ xương bả vai không di chuyển ra sau trong khi thực hiện động tác kéo giãn xoay cột sống qua phải.

- Tay di động: tay phải người điều trị nâng đỡ toàn bộ phía sau đầu trẻ với 4 ngón tay đặt ở một bên của phần xương sọ và ngón cái đặt bên đối diện. Tay di động của người điều trị kéo giãn từ từ cho mặt trẻ xoay sang phải.

Khi cảm nhận sự kháng cản trong lúc thực hiện do giới hạn của chiều dài cơ ức đòn chũm, giữ lại ở tầm vận động giới hạn này khoảng 30 - 60 giây/lần, tùy theo khả năng chịu đựng được của trẻ. Tăng tiến tầm vận động xoay cổ này sẽ được thực hiện từ từ qua mỗi buổi tập, cho đến khi đạt được tầm vận động bình thường.

- Lặp lại kỹ thuật từ 5 - 15 lần/buổi tập.



Tập nghiêng đầu qua



Tập xoay mặt qua phải

6.4. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Trong 3 tháng đầu, tập 2 lần/tuần tại bệnh viện. Sau đó tái khám mỗi tháng.

- Tiêu chuẩn ngưng điều trị: đầu ở vị thế thẳng, tầm vận động cột sống cổ chủ động không bị giới hạn, không còn khối u cơ UĐC.

- Không được xoa trên khối u cơ UĐC vì làm khối u sưng thêm.

- Tránh kéo giãn cột sống cổ thái quá vì có nguy cơ gây liệt đám rối thần kinh cánh tay.

- Đối với những khối u quá to, nên kéo giãn chậm, nhẹ nhàng để tránh trẻ bị ho, sặc hoặc tím tái./.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

73 KỸ THUẬT TẬP VẬN ĐỘNG CHO TRẺ XƠ HÓA CƠ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xơ hóa cơ là tình trạng một phần hoặc toàn bộ các tế bào cơ bị xơ hóa ảnh hưởng đến chức năng vận động và thẩm mỹ.

- Xơ hoá cơ là một quá trình diễn biến từ từ, mà trong đó quá trình xơ hoá làm cho các tế bào cơ chuyển biến thành tế bào xơ do các tác nhân cơ học, lí hoá như chấn thương gây đụng giập cơ, gây chảy máu tại chỗ, gây phù nề dẫn đến thiếu nuôi dưỡng tổ chức cơ, hoặc do các tác nhân hoá học làm thay đổi dinh dưỡng và chuyển hoá của tế bào cơ. Xơ hoá cơ thường kéo dài nhiều năm tháng, mang tính chất lan toả và hậu quả là các tế bào xơ thay thế tế bào cơ làm mất đi khả năng đàn hồi, gây co kéo và mất đi chức năng vận động của cơ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Xơ hóa cơ tứ đầu đùi.

- Xơ hóa cơ Ức đòn chũm.

- Xơ hóa cơ Delta…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chấn thương hay chảy máu, viêm cơ da vùng cơ xơ hóa.

4. THẬN TRỌNG

- Không có

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Gối tròn, gối vuông, gối mềm

- Dụng cụ chỉnh hình

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế:

- Giường tập

5.5. Người bệnh

- Giải thích kỹ về các bước tiến hành kỹ thuật cho gia đình bệnh nhi.

- Trẻ ở tư thế phù hợp thuận lợi cho thực hiện kỹ thuật tập cho từng nhóm cơ xơ hóa.

- Kiểm tra trẻ: xác định cơ xơ hóa, lượng giá chức năng vận động.

- Trẻ ở tư thế phù hợp. Ví dụ: xơ hóa cơ Ức đòn chũm - trẻ nằm nghiêng sang bên không có khối xơ để bộc lộ khối xơ, đầu trẻ thấp hơn vai…

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa. Ghi chép đầy đủ tình trạng bệnh lý và kết quả lượng giá vùng cơ xơ hóa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bước 1: kéo giãn cơ xơ hóa.

- Bước 2: xoa bóp nhóm cơ đối kháng với cơ xơ hóa.

- Bước 3: tập vận động các khớp thụ động, hoặc có trợ giúp nhằm tăng tầm vận động khớp, cải thiện chức năng cơ xơ hóa.

+ Chỉ thực hiện khi khối xơ không có nóng, đỏ, đau.

+ Kéo giãn nhẹ nhàng, từ từ, không kéo giãn tối đa đột ngột.

+ Không thực hiện kỹ thuật khi trẻ khóc, chống đối. Thời gian 30-60 phút tùy theo tuổi của trẻ.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Khám định kì theo hẹn của bác sĩ phục hồi chức năng để theo dõi và lượng giá chức năng vận động cơ xương khớp cho đến khi trẻ thực hiện được hết tầm vận động và khối xơ hóa biến mất.

- Trẻ điều trị tại nhà không tiến bộ cần điều trị tại bệnh viện.

- Tai biến: gây chấn thương vùng kéo giãn → dừng thủ thuật, kiểm tra mức độ chấn thương và giải quyết.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

74 KỸ THUẬT TẬP VẬN ĐỘNG CHO TRẺ BỊ BIẾN DẠNG CỘT SỐNG (CONG, VẸO, GÙ, ƯỠN)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cong vẹo cột sống là tình trạng cột sống lệch sang bên phải hoặc trái so với đường giữa của cột sống nếu nhìn thẳng từ phía sau lưng.

- Gù cột sống là tình trạng đoạn cột sống lưng cong quá mức ra phía sau so với đường cong sinh lí nếu nhìn từ phía bên của người bệnh.

- Ưỡn cột sống là tình trạng đoạn cột sống thắt lưng cong quá mức ra phía trước (ưỡn) so với đường cong sinh lí nếu nhìn từ phía bên người bệnh.

- Biến dạng cột sống làm cho hình dáng cơ thể bị biến dạng không những ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến chức năng vận động, đặc biệt ảnh hưởng đến chức năng tim mạch, hô hấp. Ở trẻ gái có thể bị ảnh hưởng đến chức năng sinh đẻ sau này.

- Các bài tập vận động giúp đề phòng các biến chứng cũng như giúp trẻ phát triển cân bằng hơn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Vẹo cột sống.

- Gù cột sống.

- Ưỡn cột sống.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng cột sống.

- Khối u cột sống và u cạnh cột sống.

- Bệnh ưa chảy máu.

- Bệnh tắc mạch máu.

4. THẬN TRỌNG

- Đánh giá tuổi phát triển, khả năng phối hợp và sức khỏe của trẻ; thao tác nhẹ, nâng đỡ đầu cổ thân phù hợp. Không kéo giật chi hoặc ép trẻ tập khi đau, khó thở hoặc chống đối nhiều.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Đệm tập

- Dụng cụ đo góc

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Trang thiết bị: sử dụng phương tiện phù hợp với thao tác và các dụng cụ đã liệt kê tại mục 5.3; kiểm tra an toàn trước thực hiện. Không yêu cầu thêm máy chuyên dụng ngoài các phương tiện này.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành...

- Mặc quần áo rộng, thoải mái

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 20-30 phút (ước tính 0,33-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, Buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

Bài tập 1: tăng tầm vận động của cột sống lưng

- Mục tiêu: gia tăng tầm vận động gập của cột sống lưng.

+ Kéo giãn nhóm cơ duỗi lưng.

- Kỹ thuật:

+ Tư thế bệnh nhi: ngồi, 2 chân duỗi thẳng và áp sát, 2 tay đưa ra phía trước.

+ Tư thế kỹ thuật y : ngồi cạnh và làm mẫu.

+ Tiến hành: bệnh nhi duỗi thẳng 2 chân áp. Hai tay đưa ra trước lưng gập, càng gần các ngón càng tốt.

Bài tập 2: tăng cơ lực nhóm cơ gập và xoay thân

- Mục tiêu

+ Tăng cơ lực nhóm cơ gập và xoay thân.

+ Tăng cường tính linh hoạt của cột sống

- Kỹ thuật:

+ Tư thế bệnh nhi: nằm ngửa, 2 tay đan sau gáy, 2 chân duỗi thẳng.

+ Tư thế kỹ thuật y : đứng hoặc quỳ bên cạnh, 1 tay cố định trên 2 đùi và 1 tay cố định trên 2 cẳng chân bệnh nhi.

+ Tiến hành: kỹ thuật y cố định 2 chân, bệnh nhi 2 tay đan sau gáy, gập thân và xoay thân, khuỷu sang bên đối diện.

Bài tập 3: kéo giãn cơ ở phần lõm của đường cong

- Mục tiêu:

+ Kéo giãn các nhóm cơ phía lõm của đường cong thắt lưng trái.

+ Phòng ngừa co rút cột sống thắt lưng.

- Kỹ thuật:

+ Tư thế bệnh nhi: nằm sấp, 2 tay bám chặt 2 bên cạnh bàn.

+ Tư thế kỹ thuật y : đứng cạnh bệnh nhi và đỡ 2 tay mặt trước đùi bệnh nhi.

+ Tiến hành: bệnh nhi giữ thân trên của mình cố định. Kỹ thuật y kéo giãn đốt sống vùng thắt lưng sang trái.

Bài tập 4: kéo giãn cơ ở phần lõm của đường cong

- Mục tiêu: kéo giãn phía lõm của đường cong ngực phải, tăng tính linh hoạt và duy trì tầm vận động của cột sống lưng.

- Kỹ thuật:

+ Tư thế bệnh nhi: nằm nghiêng sang phía có đường cong, thả người xuống mép bàn.

+ Tư thế kỹ thuật y : đứng và giữ hông bệnh nhi.

+ Tiến hành: bệnh nhi thả người xuống mép bàn, tay phía trên duỗi thẳng qua đầu, cuộn 1 khăn tắm kê vào đỉnh đường cong. Giữ tư thế này 3 đến 5 phút.

Bài tập 5: Kéo giãn cột sống

- Mục tiêu:

+ Kéo giãn cột sống.

+ Tăng cường tính đàn hồi của thân mình.

- Kỹ thuật:

+ Tư thế bệnh nhi: đứng 2 tay gập 180º, duỗi thẳng.

+ Tư thế kỹ thuật y : đứng cạnh.

+ Tiến hành: hai tay bệnh nhi bám vào xà ngang, gắng cho gót chân rời khỏi sàn.

Bài tập 6:

- Mục tiêu

+ Tập mạnh nhóm cơ nghiêng thân.

+ Kéo giãn phía lồi của đường cong ngực phải.

- Kỹ thuật:

+ Tư thế bệnh nhi: nằm nghiêng.

+ Tư thế kỹ thuật y : đứng sau.

+ Tiến hành: bệnh nhi nằm nghiêng về phía trái và nhấc thân lên khỏi sàn để kéo giãn phía lồi của đường cong ngực phải.

Bài tập 7:

- Mục tiêu:

+ Cải thiện chức năng hô hấp và tim mạch.

+ Tăng cường độ giãn nở của lồng ngực.

- Kỹ thuật:

+ Tư thế bệnh nhi: nằm ở tư thế nửa nằm nửa ngồi.

+ Tư thế kỹ thuật y : đứng cạnh

+ Tiến hành: Bệnh nhi hít sâu và thở ra từ từ. Hai tay bệnh nhi đặt dưới cơ hoành.

Bài tập 8:

- Mục tiêu:

+ Cải thiện tư thế cột sống.

+ Tăng cường chức năng phổi.

- Kỹ thuật:

+ Tư thế bệnh nhi: ngồi, người cúi về phía trước.

+ Tư thế kỹ thuật y : ngồi sau, 2 bàn tay đặt sau lưng và đáy phổi.

+ Tiến hành: bệnh nhi hít vào thật sâu và thở ra từ từ, đảm bảo có sự giãn nở của lồng ngực.

- Theo dõi: ghi chép phiếu tập

+ Ghi ngày, giờ tập.

+ Ghi số lần tập.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Theo dõi tình trạng trẻ, mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.

- Thận trọng với các trẻ vẹo cột sống nặng với góc Cobb trên 40º.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

75 KỸ THUẬT KIỂM SOÁT TƯ THẾ VÀ VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI BỆNH PARKINSON

1. ĐẠI CƯƠNG

Rối loạn tư thế là triệu chứng thường gặp ở người bệnh Parkinson, đặc biệt là tư thế gập/ngả người ra trước, hậu quả của rối loạn tư thế ở người bệnh Parkison gây hạn chế tầm nhìn, khó khăn khi ăn, nói, giảm khả năng đi lại và tăng nguy cơ ngã. Các kỹ thuật kiểm soát tư thế là cần thiết đối với người bệnh Parkinson để cải thiện chức năng sinh hoạt cũng như nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh Parkinson giai đoạn I đến IV (theo Hoehn & Yahr Scale).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh Parkinson đang mắc các bệnh lý nội khoa cấp tính chưa kiểm soát được.

- Bệnh Parkinson giai đoạn V.

- Người bệnh không hợp tác

4. THẬN TRỌNG

- Người có rối loạn tri giác nhận thức

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Thảm tập, gối mỏng mật độ chắc

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Giường tập

- Gương lớn

- Ghế tựa (phần tựa thấp ngang đỉnh xương bả vai)

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành ...

- Người bệnh trang phục gọn gàng

- Giải thích và hướng dẫn cách tập cho người bệnh

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật : 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện : phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán...

- Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Kỹ thuật kéo căm ra sau

- Mục đích bài tập: kỹ thuật này chống lại tư thế đầu cúi gập ra phía trước ở người bệnh Parkinson.

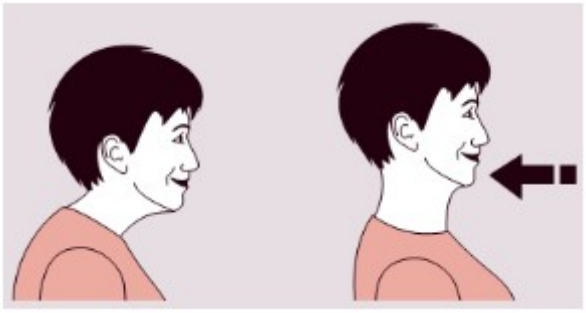
Bước 1: Kỹ thuật y làm bài tập mẫu tư thế ngồi và tư thế nằm sau đó đưa người bệnh vào ghế /giường tập.

Bước 2: Thực hiện bài tập:

- Tư thế nằm: nằm ngửa 541ren giường đệm không lún, kê gối ở vị trí xương chẩm, không đặt gối ở cột sống cổ.

- Yêu cầu người bệnh kéo đầu ra phía sau sao cho tạo ra 2 căm, lúc này có cảm giác đầu ép xuống gối (thể hiện qua độ lún gối), người bệnh có thể tự hướng cử động bằng cách đặt 2 ngón tay ở trước căm, giữ ở tư thế 2 giây sau đó thư giãn. Lặp lại 8 - 15 lần/chuỗi tập, mỗi buổi tập 4 - 5 chuỗi.

- Tư thế ngồi: tốt nhất là ngồi trước gương, ngồi ghế có tựa phần lưng. Người bệnh cũng làm thực hiện các động tác như tạo ra 2 căm bằng cách kéo đầu ra phía sau.



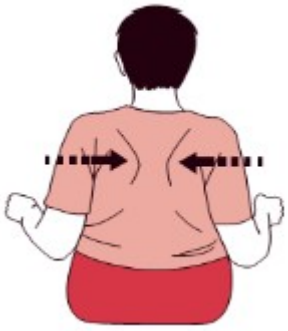
6.2. Kỹ thuật kéo xương bả vai

- Mục đích: nhằm giảm độ cong/gù vùng bả vai.

Bước 1: Kỹ thuật y làm bài tập mẫu sau đó hướng dẫn tư thế đúng khi tập.

Bước 2: Thực hiện bài tập.

Người bệnh ngồi thẳng lưng nhất có thể, khuỷu tay gập 90°, cánh tay áp sát thân, kéo 2 khuỷu về phía sau thân lúc này 2 xương bả vai kéo gần sát cột sống, cố gắng kéo cho vai càng phẳng càng tốt, giữ ở tư thế này 2 - 5 giây sau đó thư giãn. Lặp lại động tác từ 8 - 15 lần/chuỗi, mỗi buổi tập 4 - 5 chuỗi tập, xen kẽ với các kỹ thuật khác.



6.3. Kỹ thuật ưỡn ngực

- Mục đích: nhằm giảm độ gù vùng lưng cao.

Bước 1: Kỹ thuật y hướng dẫn tư thế đúng khi tập và thực hiện bài tập mẫu trước, sau đó sẽ hướng dẫn người bệnh tập cụ thể.

Bước 2 : Thực hiện bài tập

- Người bệnh ngồi dựa lưng trên ghế có phần tựa thấp dưới đỉnh của xương bả vai, 2 tay người bệnh cài vào nhau về đặt phía sau đầu.

- Ưỡn ngực ra trước đồng thời mở rộng khuỷu ra sau và ra 2 bên, mặt của người bệnh hướng lên trần nhà, giữ 3 - 5 giây sau đó thư giãn.

- Lặp lại động tác từ 8 - 15 lần/ 1chuỗi tập sau đó chuyển sang bài tập khác, rồi lặp lại 3 - 4 chuỗi tập như trên.

Chú ý :

- Luôn thở đều trong khi tập, tránh nín thở trong khi tập.

- Tăng dần số lần tập và chuỗi tập để tránh mệt và mỏi cơ.

6.4. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tiến bộ về kiểm soát tư thế của người bệnh.

- Có thể xuất hiện mỏi cơ sau tập.

- Xử trí đau mỏi cơ: thư giãn, nghỉ ngơi, có thể xem xét giảm cường độ tập (chuỗi tập và số lần tập).

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

76 KỸ THUẬT GƯƠNG TRỊ LIỆU

1. ĐẠI CƯƠNG

Dùng phương pháp gương trong điều trị lần đầu tiên được thực hiện bởi V.S. Ramachandran vào năm 1996 trên những người bệnh đau chi mà sau khi bị cắt cụt chi. Sau đó, nhiều nghiên cứu khác chứng minh được hiệu quả của việc dùng phương pháp gương trong phục hồi chức năng vận động ở những người bệnh liệt nửa người do đột quỵ. Đặc biệt cải thiện tầm vận động, tốc độ cũng như độ khéo léo của bàn tay, chức năng chi dưới.



2. CHỈ ĐỊNH

Liệt nửa người do đột quỵ não, chấn thương sọ não, viêm não, viêm màng não, bại não…

Đau chi do cắt cụt chi.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tạm hoãn khi người bệnh chưa ổn định hoặc đang có tình trạng cấp cần xử trí; không thực hiện động tác trái chỉ định bất động, giới hạn chịu tải hoặc vận động của bác sĩ. Đánh giá điều kiện thực hiện trước từng buổi.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh còn trong tình trạng cấp cứu
- Đau đầu, chóng mặt
- Người bệnh suy giảm, nhận thức

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư:

- Hộp gương có kích thước phù hợp cho chi trên và chi dưới.

- Bóng cao su.

- Gối

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế

- Bàn tập

- Ghế tập

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành...

- Tư thế người bệnh thoải mái

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15 - 30 phút (ước tính 0,25-0,50 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

- Các thông số đánh giá về chức năng bàn tay liệt của người bệnh trước khi điều trị.

6. THỰC HIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

Bước 1: bộc lộ vùng cần điều trị (chi trên hoặc chi dưới).

a) Chi trên:

Bước 2: gương đặt trên bàn, trước mặt người bệnh. Tay lành của người bệnh sẽ được đặt đối diện với gương. Tay liệt đặt phía đằng sau gương.

Bước 3: trong suốt thời gian tập, người bệnh sẽ quan sát cử động của tay lành qua gương, cố gắng tưởng tượng tay cử động trong gương chính là tay liệt. Đồng thời, cử động tay liệt theo tay lành.

Các bài tập cho bàn tay và cổ tay như sau:

- Thực hiện các cử động bình thường của bàn tay như gập duỗi, dang khép các ngón tay, đối chiếu ngón cái với các ngón tay khác. Thực hiện các cử động của cổ tay như gập duỗi cổ tay, nghiêng trụ, nghiêng quay cổ tay.

- Tập với dụng cụ làm tăng sức mạnh bàn tay như bóng cao su hoặc miếng mút.

- Tiến hành can thiệp phương pháp gương trong thời gian 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần.

- Thực hiện 5 ngày/tuần x 4 tuần.

b) Chi dưới

Bước 2: gương được đặt ở đường giữa cơ thể và giữa hai chân của người bệnh.

Bước 3: người bệnh thực hiện các động tác co duỗi đồng thời hai bên của chi dưới trong khi quan sát chuyển động của chi không bị ảnh hưởng được phản chiếu qua gương

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

Đánh giá tình trạng người bệnh trong và sau khi tập.

- Vỡ gương nếu gây tại nạn cho người bệnh: xử trí cấp cứu theo quy định.

- Chóng mặt, đau đầu, ngã: dừng tập và xử trí theo quy định.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

77 KỸ THUẬT THÔNG MŨI HỌNG NGƯỢC DÒNG Ở TRẺ EM

Khoa PHCN phối hợp khoa Nhi xác nhận chỉ định, thao tác đóng miệng, dẫn lưu và giới hạn dịch theo tuổi trước phê duyệt. Không giao người nhà tự thực hiện các thao tác chuyên môn.

1. ĐẠI CƯƠNG

Kỹ thuật thông mũi họng ngược dòng là một sự dẫn lưu chất tiết bằng dung dịch NaCl 0,9% trong mũi họng ra ngoài, để trẻ dễ thở hơn.

2. CHỈ ĐỊNH

Áp dụng cho trẻ em có bệnh lí gây ứ đọng chất tiết trong mũi họng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Phẫu thuật vùng hàm - mặt.

- Chảy máu cam.

4. THẬN TRỌNG

- Chỉ nhân viên được huấn luyện thực hiện, có phương tiện theo dõi và cấp cứu sẵn sàng; theo dõi nguy cơ sặc, thiếu oxy, không làm khi trẻ chưa ổn định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: Nước muối sinh lí NaCl 0,9 %

5.3. Vật tư:

- Giấy lót đầu loại thấm nước, dày và dai khổ 40 x 60 cm

- Giấy lấy chất tiết mũi và đàm loại dai và mềm

- Thùng đựng chất thải lây nhiễm.

- Nệm bọc bàn: dày 5 cm, có độ đàn hồi tốt. Nệm bọc simili trơn láng và có màu sáng.

- Găng tay

- Mũ giấy

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Khăn lau tay

5.4. Thiết bị y tế:

- Bàn tập thích hợp, cao ngang hông người điều trị, rộng 60 cm. Sắp xếp bàn tập trong phòng: nơi có đủ ánh sáng để dễ quan sát trẻ, các bàn tập cách nhau khoảng 1,5 - 2 m để ngăn ngừa nhiễm trùng chéo.

- Thiết bị đo độ bão hòa oxy

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người nhà trẻ về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế trẻ: cởi áo trẻ và đặt trẻ nằm nghiêng, đầu và thân thẳng trục, mặt trẻ xoay nhẹ về phía mặt bàn. Đặt trẻ nằm gần về phía người điều trị đang đứng. Tuyệt đối tránh ngửa đầu ra sau vì có nguy cơ hít sặc dẫn đến ngưng tim ngưng thở.

- Cách giữ trẻ: mẹ đứng dưới chân trẻ. Một tay mẹ giữ hai tay trẻ khoanh lại trước ngực. Tay kia mẹ giữ ngang hông trẻ. Không giữ hai chân trẻ vì cách giữ này sẽ tạo một đòn bẩy từ chân của trẻ làm cho người điều trị rất khó khăn để cố định đầu.

5.6. Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15 - 20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, Buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Thực hiện bốn bước với các thao tác sau:

6.1. Thông rửa mũi với NaCl 0,9%

- Đặt tay: một tay giữ đầu trẻ ở tư thế trung tính bằng phần mềm của lòng bàn tay, với ngón cái đặt sau đầu trẻ. Tay kia cầm chai dung dịch NaCl.

- Đặt chai NaCl vào lỗ mũi nằm trên song song với mặt bàn, hướng về khoang mũi theo vị trí giải phẫu học của khoang mũi.

- Thực hiện bơm chậm và liên tục vào khoang mũi trên, tạo thành một dòng chảy liên tục từ khoang mũi trên xuống khoang mũi dưới để làm loãng và đưa chất tiết chảy ra ngoài qua lỗ mũi dưới.

- Thể tích, áp lực và cách đưa NaCl 0,9% phải được bác sĩ xác định theo tuổi, tình trạng trẻ và dụng cụ đã được phê duyệt; không dùng một mức tối thiểu 30 mL cho

mọi trẻ.

- An toàn của thao tác: luôn giữ đầu trẻ ở tư thế trung tính, không để chất tiết mũi và dung dịch NaCl chảy ra dính vào mắt trẻ.

6.2. Hỉ mũi (thực hiện trong thì thở ra)

- Đặt tay: một ngón tay trên cánh mũi của lỗ mũi trên, không đè lên mắt trẻ. Một ngón tay của bàn tay kia đặt dưới hàm tại gốc lưỡi.

- Thực hiện: hai ngón tay này đồng thời đóng kín miệng và lỗ mũi trên của trẻ trong thì thở ra, làm cho không khí từ trong phổi đi ra ngoài qua lỗ mũi dưới và đưa chất tiết trong mũi ra ngoài. Có thể sử dụng thêm một ngón tay đặt ở môi dưới của trẻ để giúp đóng kín miệng khi cần thiết.

+ Hai ngón tay trước khi thực hiện thao tác phải có sự chuẩn bị lực. Trong khi thực hiện luôn luôn duy trì sự tiếp xúc.

+ Thao tác nhẹ nhàng: không làm nhăn nhó mặt mũi trẻ một cách thái quá, không đẩy lệch mũi trẻ.

+ An toàn của thao tác: không gây dập lưỡi.

+ Hiệu qủa của thao tác: chất tiết mũi chảy ra ngoài theo lỗ mũi dưới. Trong khi thực hiện, nếu thấy không còn chất tiết chảy ra ngoài theo lỗ mũi dưới thì ngưng thao tác này.

6.3. Đưa chất tiết mũi xuống họng (thực hiện trong thì hít vào)

- Đặt tay: hai ngón tay cái đặt dưới hàm. Các ngón tay còn lại của hai bàn tay ôm giữ hai bên mặt trẻ.

- Thực hiện**:** hai ngón cái giữ miệng trẻ đóng lại trong thì hít vào để đưa chất tiết còn lại trong khoang mũi đi xuống họng.

+ Thao tác nhẹ nhàng: không đẩy cổ của trẻ ưỡn ra sau thái quá.

+ An toàn của thao tác: không gây dập lưỡi, chảy máu miệng.

+ Hiệu qủa của thao tác: cảm nhận được hoặc nghe được trẻ hít vào mạnh khi đóng miệng trẻ lại.

6.4. Đẩy đờm (đưa chất tiết từ họng ra khỏi miệng)

Thực hiện trong thì thở ra

- Đặt tay: ngón cái đặt dưới hàm ngay tại gốc lưỡi, các ngón tay còn lại đặt dọc theo một bên mặt trẻ. Có thể sử dụng bàn tay kia giúp giữ đầu trẻ ở tư thế trung tính hoặc giúp đẩy đờm.

- Thực hiện: ngón cái tại gốc lưỡi cho một áp lực nhẹ nhàng, thẳng góc với vòm miệng và di chuyển nhẹ nhàng ngón cái hướng ra trước để đưa chất tiết từ vùng hầu ra khỏi miệng nhờ vào lực đẩy của dòng khí đang thở ra.

+ Ngón cái có tác dụng ngăn cản cử động nuốt của lưỡi và làm giảm khẩu kính vùng hầu họng theo chiều trên - dưới giúp làm tăng lực đẩy của dòng khí thở ra để đẩy đờm ra khỏi miệng.

+ Thao tác nhẹ nhàng: ngón cái di chuyển tại chỗ, không rời vị trí gốc lưỡi.

* **An toàn của thao tác:**

- Không làm trẻ bị tím tái, nghẹt thở. Điều cần biết là thanh quản của trẻ 0 - 6 tháng tuổi nằm rất cao, nếu ngón cái đặt sai vị trí sẽ có khả năng đặt lên thanh quản hoặc lực đẩy bị lệch hướng cũng sẽ tác động lên thanh quản làm cho trẻ đau, bị tím tái, nghẹt thở. Trẻ sẽ giãy giụa và phản ứng đến cùng.

- Không đẩy cổ trẻ ưỡn ra sau thái quá.

- Không xoay mặt trẻ qua một bên để đẩy đờm trong tư thế nằm ngửa.

- Hiệu quả của thao tác: đẩy đờm đúng vào thì thở ra, thực hiện tối đa 3 - 5 lần có thể đẩy đàm ra khỏi miệng. Không làm trẻ bị ói ọc.

6.5. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Thực hiện khi có chỉ định và nhân viên đã được huấn luyện, trong phạm vi hành nghề phù hợp; không áp dụng thường quy chỉ dựa vào lượng đờm.

- Cần thận trọng khi thực hiện kỹ thuật.

- Theo dõi sắc mặt, nhịp thở, SpO2 và đáp ứng trong từng thao tác. Dừng ngay, giải phóng đường thở và gọi hỗ trợ nếu tím tái, ngừng thở, giảm SpO2, sặc hoặc giảm đáp ứng; cấp cứu theo tình trạng.

- Nên thực hiện kỹ thuật sau khi trẻ ăn uống ít nhất là 1 giờ.

- Chỉ cho trẻ ăn uống lại khi tỉnh, thở ổn định và nuốt an toàn theo đánh giá; không mặc định đủ 15 phút là an toàn.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Bộ y tế (2014), “Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật”.

3. Bộ y tế (2016), “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng”.

78 ĐIỀU TRỊ BẰNG ÂM DẪN THUỐC

1. ĐẠI CƯƠNG

Siêu âm dẫn thuốc là phương pháp dùng năng lượng sóng siêu âm để đưa thuốc vào cơ thể qua vùng da điều trị.

2. CHỈ ĐỊNH

- Giảm đau cục bộ

- Giãn cơ.

- Viêm mạn tính.

- Xơ cứng, sẹo nông ở da.

- Dẫn một số thuốc vào tổ chức cục bộ (siêu âm dẫn thuốc).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trực tiếp lên các u ác tính, tinh hoàn, buồng trứng, tử cung đang có thai, đang hành kinh.

- Trực tiếp vùng khớp ở trẻ em, các đầu xương của trẻ em, nhất là phần sụn tiếp hợp.

- Viêm tắc mạch, viêm da cấp tại vị trí điều trị.

- Vùng phổi người bị lao đang tiến triển, giãn phế quản thể khô hoặc viêm hạch do lao.

- Trực tiếp vùng chảy máu, đe dọa chảy máu.

4. THẬN TRỌNG

- Khi thực hiện trên các vùng da bị tổn thương

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: Thuốc giảm đau, chống viêm dạng mỡ, gel hoặc dung dịch…

5.3. Vật tư:

- Găng tay, Mũ giấy, Khẩu trang y tế,Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

5.4. Thiết bị y tế

- Máy điều trị siêu âm cùng các phụ kiện

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Tư thế người bệnh thoải mái, tốt nhất là ở tư thế nằm hoặc ngồi.

- Kiểm tra và bộc lộ vùng da điều trị.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 15-20 phút (ước tính 0,25-0,33 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Bật máy. Đặt các thông số kỹ thuật và cách điều trị theo chỉ định.

- Bôi gel, thuốc theo chỉ định lên vùng điều trị, điều chỉnh cường độ và tiến hành điều trị.

- Hết giờ tắt máy (bằng tay hoặc tự động).

- Kiểm tra vùng điều trị, thăm hỏi người bệnh, ghi chép hồ sơ.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Cảm giác và phản ứng người bệnh.

- Hoạt động của máy.

- Điện giật: Tắt máy và xử trí theo quy định.

- Dị ứng tại chỗ: ngừng điều trị, kiểm tra thuốc, chất tiếp âm và da; báo bác sĩ xử trí.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh

ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.

2. Bộ Y tế (2014). Điều trị bằng siêu âm. Quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng đợt 1.

79 ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT CAO

Laser công suất cao: xác nhận bước sóng, chế độ, liều năng lượng, vùng kiểm soát, kính bảo vệ và hướng dẫn thiết bị trước áp dụng; không sao chép thông số từ máy khác.

1. ĐẠI CƯƠNG

- Laser công suất cao là laser lớp 4, có công suất trên 500 mW. Laser công suất cao có đủ các tác dụng của laser công suất thấp, ngoài ra có thêm tác dụng nhiệt, độ xuyên thấu sâu hơn và thời gian điều trị ngắn hơn.

- Tác dụng của laser công suất cao: giảm đau, kháng viêm, giảm phù nề, tăng hoạt động thần kinh, tăng tạo xương, lành thương và tác dụng nhiệt.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau cơ xương khớp: đau cổ vai, đau lưng, đau vai, thoái hóa khớp gối, viêm gân…

- Đau thần kinh: hội chứng ống cổ tay, đau thần kinh tọa…

- Kích thích tái tạo mô, làm liền vết thương, vết loét

- Liệt dây thần kinh mặt

- Phù nề sau chấn thương

- Co rút sẹo, dây chằng, gân, bao khớp

- Co thắt cơ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Vùng mắt

- Vùng cơ thể có bệnh lý ác tính

- Vùng tuyến nội tiết như tuyến giáp, tinh hoàn

- Có thai

- Rối loạn đông cầm máu

4. THẬN TRỌNG

- Hình xăm

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y phục hồi chức năng.

b) Nhân lực hỗ trợ: bố trí theo tình trạng người bệnh, mức độ phụ thuộc và nguy cơ ngã; người hỗ trợ được hướng dẫn, không thay thế người thực hiện chuyên môn.

5.2. Thuốc: không sử dụng thuốc trực tiếp thường quy cho kỹ thuật này. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu dùng theo y lệnh khi có chỉ định.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang y tế

- Cồn sát khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn

- Kính bảo vệ cho người bệnh và người trong vùng kiểm soát; kính ghi đúng bước sóng và mật độ quang học phù hợp với máy laser công suất cao.

5.4. Thiết bị y tế

- Máy laser công suất cao.

- Đầu phát tia laser, bộ phận mở rộng đầu phát.

5.5. Người bệnh

- Người thực hiện giải thích cho người bệnh, người chăm sóc về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra ...

- Nằm hoặc ngồi tư thế thoải mái trong khi điều trị.

- Bộc lộ da vùng điều trị. Với các vết thương vết loét nên được thay băng làm sạch dịch mủ và các mô hoại tử bề mặt.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định hoặc phiếu điều trị chuyên khoa.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 10-15 phút (ước tính 0,17-0,25 giờ; điều chỉnh theo người bệnh và chỉ định).

5.8. Địa điểm thực hiện: Phòng thực hiện kỹ thuật, buồng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Đối chiếu chỉ định, ít nhất hai thông tin nhận dạng, vùng và bên thực hiện; kiểm tra giới hạn vận động hoặc thông số được kê. Thực hiện bảng kiểm an toàn theo loại thủ thuật khi áp dụng; đặt tư thế an toàn và giải quyết sai khác trước bắt đầu.

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Thực hiện theo trình tự

- Chọn các tham số kỹ thuật theo chỉ định: cường độ, thời gian chiếu, chế độ chiếu liên tục hay ngắt quãng.

- Gắn bộ phận mở rộng đầu phát nếu cần chiếu rộng và nông.

- Di chuyển đầu phát liên tục trên vùng điều trị để tránh gây nóng quá mức. Nếu vùng điều trị rộng thì có thể di chuyển theo hình dích dắc. Nếu điều trị điểm thì di chuyển theo hình xoắn ốc hướng tâm.

Lưu ý: không để chùm tia laser chiếu trực tiếp vào mắt.

- Kết thúc điều trị, lau khô, kiểm tra vùng da, thăm hỏi người bệnh.

- Ghi phiếu thực hiện kỹ thuật.

6.2. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng và đáp ứng sau kỹ thuật. Thu dọn, làm sạch hoặc khử khuẩn phương tiện theo quy định. Ghi ngày giờ, vùng thực hiện, thông số hoặc mức tập, đáp ứng và người thực hiện; bàn giao cho bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và xử trí trong khi thực hiện

- Tình trạng nóng quá mức, đỏ da, bỏng tại vùng điều trị, thường là do di chuyển đầu phát chậm, cường độ quá cao hay vùng da sẫm màu.

- Có thể gây bỏng, xử trí theo mức độ bỏng.

7.2. Theo dõi sau thực hiện

- Đánh giá lại đau, da, chức năng và sinh hiệu theo tình trạng; bảo đảm người bệnh ổn định trước rời vị trí điều trị. Bất thường mới xuất hiện cần báo bác sĩ và xử trí theo nguyên nhân.

7.3. Theo dõi biến chứng muộn

- Hướng dẫn báo sớm đau tăng, sưng, tổn thương da, yếu hoặc tê mới xuất hiện, khó thở hoặc giảm chức năng. Ghi nhận, đánh giá lại và điều chỉnh kế hoạch; cấp cứu khi có dấu hiệu nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. Bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN năm 2025. Xem danh mục đối chiếu chung và lưu ý hiệu lực Tập 2.